SUJET N°1 : APPENDICITE AIGUE

QCD

1. L'appendicite est une inflammation de l'intestin grêle et du côlon A / B
2. L'appendicite est l'inflammation brutale de l'appendice iléo-caecale A / B
3. L'appendice est situé dans le flanc droit A / B
4. L'appendicite est causée par une alimentation déséquilibrée A / B
5. La voie hématogène est la modalité exceptionnelle de survenue de l'infection appendiculaire A / B
6. La voie endogène est la modalité la plus habituelle de survenue de l'infection appendiculaire A / B
7. L'appendicite n'atteint pas les nouveau-nés A / B
8. L'appendicite n'atteint pas la gent féminine A / B
9. L'appendicite atteint les adolescents plus que les adultes A / B
10. Le traitement de l'appendicite est uniquement chirurgical A / B
11. L'appendicite est la 1ère cause d'urgence en chirurgie digestive A / B
12. Le diagnostic positif de l'appendicite est de raviver la douleur au point de Mac Burney A / B
13. La manœuvre de Rosving consiste à décompresser brutalement la fosse iliaque droite pour provoquer la douleur de l'appendicite A / B
14. Le signe fonctionnel capital de l'appendicite est l'hyperthermie A / B
15. L'appendicite touche plus les hommes que les femmes A / B
16. Le signe capital fonctionnel de l'appendicite aigüe n'est pas la douleur abdominale constante, spontanée à la fosse iliaque droite A / B
17. Le trouble du transit est constitué de constipation prédominant la diarrhée A / B
18. Un débit trop rapide peut créer un œdème aigu des poumons A / B
19. La bronchite peut créer l'appendicite aigüe A / B
20. Les appendicites ont des aspects variables en fonction de la gravité A / B
21. L'appendicite atteint les adolescents plus que les adultes A / B
22. L'appendicite est une maladie bénigne A / B
23. L'appendicite est due à une mauvaise hygiène corporelle A / B
24. L'appendicite peut être provoquée par une sinusite A / B
25. Le signe du psoas est la flexion forcée de la cuisse droite qui entraîne la douleur dans l'appendicite A / B
26. La manœuvre de BLUMBERG (positive) consiste à décompresser brutalement la FID pour provoquer la douleur A / B
27. Par voie endogène, l'appendicite réalise une obstruction de la lumière appendiculaire A / B
28. Les parasites intestinaux font partie des étiologies de l'appendicite A / B
29. La douleur provoquée lors de la palpation de la fosse iliaque droite pour le diagnostic de l'appendicite est un signe physique ? A / B
30. La défense pariétale lors de la palpation de la fosse iliaque droite pour le diagnostic de l'appendicite est un signe physique ? A / B
31. Les vers intestinaux sont la principale étiologie de l'appendicite A / B
32. L'appendicite peut guérir spontanément sans traitement A / B

QCM

33. La rate est située dans : choisir la bonne réponse

A- L'hypochondre gauche	C- Le flanc gauche	E- La fosse iliaque gauche
B- L'hypochondre droit	D- Le flanc droit	F- La fosse iliaque droite

34. Les signes de l'inflammation de l'appendice sont : choisir 4 éléments

A- Tuméfaction	C- Fièvre	E- Rongeur
B- Douleur	D- Rougeur	F- Prostration

35. Cette inflammation se traduit par des signes : choisir une seule réponse

A- Cliniques seulement D- Cliniques et biologiques uniquement

B- Biologiques seulement E- Cliniques et radiologiques uniquement
C- Radiologiques seulement F- Cliniques, biologiques et radiologiques

36. L'infection appendiculaire peut survenir selon deux modalités : lesquelles ?

A- La voie endogène B- La voie hématogène C- La voie lymphatique

37. Les signes fonctionnels de l'appendicite aigüe sont : choisir 4 réponses

A- Douleurs abdominales constantes C- Troubles du transit E- Fièvre
B- Nausées et vomissements D- Céphalées F- Arthralgies

38. Les signes physiques de l'appendicite aigüe sont :

A- Augmentation du volume abdominal
B- une position antalgique fréquente, cuisse droite fléchie
C- Météorisme abdominal
D- Dépigmentation cutanée localisée dans la fosse iliaque droite
E- Diminution de la respiration au niveau de la fosse iliaque droite
F- Augmentation de la fréquence respiratoire

39. A la palpation deux signes fondamentaux sont à rechercher dans la fosse iliaque droite. Lesquels ?

A- Douleur provoquée C- Chaleur localisée
B- Défense pariétale D- Concrétion dure formée à partir des matières fécales

40. Les causes de l'appendicite aigüe sont : choisir toutes les bonnes réponses

A- Infections C- Parasitoses intestinales E- Coprolithe (stercolithe – fécalite)
B- Calcul appendiculaire D- Corps étrangers F- Toutes ces réponses

41. La manœuvre de BLUMBERG (positive) consiste à : choisir la bonne réponse

A- décompresser brutalement la FID pour provoquer la douleur
B- presser la FID pour provoquer la douleur dans la FIG
C- mieux exposer la région inguinale à la défense de la FID
D- à la palpation

42. Le signe du psoas: choisir la bonne réponse

A- la flexion forcée de la cuisse droite est douloureuse
B- la flexion forcée du membre supérieur droit est douloureuse
C- l'extension du membre supérieur droit est douloureuse
D- l'extension du membre inférieur droit est douloureuse

43. Quels sont les 3 examens biologiques à faire pour confirmer l'appendicite ? :

A- N.F.S Hyperleucocytose sup 10.000 élts/mm3 à PNN D- GE/FS
B- Elévation de CRP E- Sérodiagnostic de Widal et Félix
C- Accélération de VS F- Test d'Elisa

44. Quels sont les 3 examens radiologiques à faire pour confirmer le diagnostic ?

A- Radiographie abdomen sans préparation D- Tomodensitométrie abdominale
B- Radiologie abdomen avec préparation E- Electrocardiogramme
C- Echographie abdominale F- Cœlioscopie

45. Quels sont les éléments du diagnostic différentiel de l'appendicite et des affections médicales ? (Trois réponses)

A- torsion de kyste de l'ovaire chez la femme C- hépatite B E- péritonite primitive
B- typhoïde D- gastro-entérite F- arthrite de la hanche

46. Les complications de l'appendicite aigüe sont : choisir toutes les bonnes réponses

A- Plastron appendiculaire (masse palpable dans la FID) D- Péritonite localisée ou généralisée
B- Abcès appendiculaire (collection de pus) E- Septicémie
C- Perforation de l'appendice F- L'ensemble de ces réponses

47. Quels sont les buts de traitement de l'appendicite ? (2 réponses)

A- Supprimer le foyer infectieux C- Calmer la douleur E- Dissiper l'anxiété du patient
B- Eviter l'évolution vers les complications D- Administrer la médication

48. Les objectifs de soins pour un patient qui doit subir une appendicectomie sont : (1 réponse)

A- Réduire l'anxiété
B- Assurer l'exécution des examens préopératoires
C- Conseiller le jeûne au moins 72 heures avant l'intervention

49. Les rôles de l'IDE au CSR dès l'appendicite suspectée sont :(1seule réponse)

A- Appeler le médecin pour confirmer le diagnostic
B- Demander au patient de réaliser les examens
C- Référer le patient dans un centre plus équipé

50. Les rôles de l'IDE à l'hôpital sont : (4 réponses)

A- Contrôler les constantes hémodynamiques
B- Vérifier la réalisation du bilan paraclinique
C- Réaliser le groupe/rhésus
D- Favoriser l'hospitalisation du patient
E- Réaliser l'appendicectomie
F- Surveiller le pansement

51. Les interventions infirmières préopératoires dans l'appendicectomie sont : 4 réponses

A- Prescrire des solutés au patient
B- Administrer la prémédication la veille de l'intervention
C- Informer le patient sur la nature des actes de la pathologie
D- Maintenir à jeun le patient au moins 72 heures avant l'intervention
E- Aseptiser la région de l'intervention
F- Vérifier la réalisation des différents examens d'opération

52. Quels sont les rôles de l'IDE en peropératoire ? (4 reponses)

A- Préparer psychologiquement le patient à l'intervention
B- Apprêter les appareils dans la chambre du patient
C- Contrôler le réveil du patient
D- Dresser le lit du patient pour attendre son retour
E- Etre l'intermédiaire entre le bloc opératoire et la famille
F- Dissiper les informations erronées des membres de la famille

53. L'infection appendiculaire peut survenir selon deux modalités : lesquelles ?

A- La voie endogène
B- La voie hématogène
C- La voie lymphatique
D- La voie percutanée
E- La voie laryngée

54. La liste ci-dessous est celle des signes fonctionnels de l'appendicite aigüe exceptés deux (2) ; lesquels ?

a. Douleurs abdominales constantes
b. Nausées et vomissements
c. Troubles du transit
d. Céphalées
e. Fièvre
f. Arthralgies

55. Les examens radiologiques ci-dessous sont à faire pour confirmer le diagnostic de l'appendicite ; lesquels ? (Trois réponses)

A- Radiographie abdomen sans préparation
B- Radiologie abdomen avec préparation
C- Echographie abdominale
D- Tomodensitométrie abdominale
E- Electrocardiogramme
F- Cœlioscopie

56. L'objectif de soins pour un patient qui doit subir une appendicectomie est :

A. Réduire l'anxiété
B. Assurer l'exécution des examens préopératoires
C. Conseiller le jeûne au moins 72 heures avant l'intervention

57. Le rôle de l'IDE au CSR dès l'appendicite suspectée est

A. Appeler le médecin pour confirmer le diagnostic
B. Demander au patient de réaliser les examens
C. Référer le patient dans un centre plus équipé

58. Les rôles de l'IDE à l'hôpital dès la suspicion de l'appendicite sont ci-dessous exceptés deux ; lesquels ? (2 réponses)

A. Contrôler les constantes hémodynamiques
B. Vérifier la réalisation du bilan paraclinique
C. Réaliser le groupe/rhésus
D. Favoriser l'hospitalisation du patient
E. Réaliser l'appendicectomie
F. Surveiller le pansement

59. L'appendicite se rencontre plus chez (2 réponses)

A. Les hommes
B. Les femmes
C. Les adultes
D. Les adolescents
E. Les enfants
F. Les nourrissons

60. La liste ci-dessous est celle des signes annonciateurs de l'appendicite chez l'enfant ; lesquels ?

A. Nausées C. Vomissements E. Polydipsie
B. Polyphagie D. Anorexie F. Hyperthermie

61. Dans la clinique de l'appendicite, le signe du psoas est obtenu

A. Par la palpation du point de Mac Burney C. Par le toucher rectal ou vaginal
B. Par la flexion forcée de la cuisse sur l'abdomen D. Par la flexion douce de la hanche

62. Dans les examens paracliniques de l'appendicite, la NFS fait suspecter une péritonite lorsqu'on relève une hyperleucocytose

A. Comprise entre 10 000 et 15 000/ml C. Supérieure à 20 000/ml
B. Inférieure à 10 000/ml D. Comprise entre 15 000 et 20 000/ml

CAS CLINIQUE N°1

Mlle Charine Z. étudiante en Licence3 communication à la FLASH de l'Université A.O de Bouaké est amenée aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales brutales, constantes avec nausées et vomissements incoercibles. Elle est en surpoids et est stressée par rapport à l'examen de certification. L'auxiliaire relève les constantes suivantes : Poids = 85 kg Taille = 154 cm Âge = 23 ans Pouls = 100 puls/min Fièvre = 39° C Tension artérielle = 120/75 mm Hg

L'interrogatoire révèle que : - La douleur est aggravée par la toux et les mouvements - les vomissements sont alimentaires, bilieux - Le trouble du transit est constitué de constipation

A l'examen, le médecin note : -Langue saburrale - Conjonctives peu colorées- La palpation douce du cadran inférieur droit de l'abdomen réveille la douleur -La flexion forcée de la cuisse droite sur l'abdomen exacerbe la douleur - Ailleurs sans particularités.

En attente de la réalisation des examens de l'intervention, le médecin lui prescrit :

1) Paracétamol50ml en perfusion : 1fl x 3/jour 2) Ceftriaxone1g : 1amp. x 2/jour en IVD 3) Hydrosol polyvitaminé inj. : 4 amp. x 3/jour

4) Sérum glucosé 500 cm3 : 1fl.x 3/jour

NB : 1ampoule de HPV= 4 ml

63. De quoi souffre Mlle Charine Z. ?

A- Ulcère gastroduodénal C- Appendicite aigüe
B- Occlusion intestinale aigüe D- Péritonite généralisée

64. Quels sont les éléments qui ont permis de poser le diagnostic ? (choisir 3 éléments)

A- La palpation douce du cadran inférieur droit de l'abdomen réveille la douleur
B- La flexion forcée de la cuisse droite sur l'abdomen exacerbe la douleur
C- Tension artérielle = 120/75 mm Hg
D- Fièvre = 39° C
E- Langue saburrale
F- Conjonctives colorées

65. Quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic ? (choisir 3 examens)

A- KOP C- ASP E- NFS/VS
B- ECBU D- Echographie abdominale

66. Quels peuvent être les autres diagnostics chirurgicaux différentiels ? (choisir 2 éléments)

A- Grossesse extra-utérine C- Gastroentérite E- Constipation opiniâtre
B- Torsion de kyste D- Colique néphrétique F- Hépatite

67. Quelles sont les probables causes de la pathologie de Mlle Charine Z. ? (Choisir 4 réponses)

A- Parasitoses intestinales C- Coprolithes E- Obésité
B- Corps étrangers D- Infections F- Stress

68. Quel est le débit d'une perfusion ?

A- 20 gouttes/min B- 21 gouttes/min C- 22 gouttes/min D- 24 gouttes/min

69. Donnez 3 contre-indications de la perfusion ?

A- Anasarque C- Anémie E- Hyperthermie

B- Œdème aigu des poumons D- Déshydratation F- Coma

70. Formulez deux diagnostics infirmiers en rapport avec la pathologie ?

A- Hyperthermie reliée à la maladie C- Douleur abdominale causée par la pathologie

B- Anémie causée par les vomissements D- Difficultés respiratoires dues à son hospitalisation

71. Identifiez les deux besoins prioritaires à satisfaire chez la malade ?

A- Besoin de manger et boire D- Besoin de maintenir la température corporelle dans les limites normales

B- Besoin d'apprendre E- Besoin de s'occuper en vue de se rendre utile

C- Besoin de se récréer

72. Pour déterminer le groupe sanguin de Mlle Charine Z., on a utilisé les globules et les sérums tests (Anti-A, Anti-B, Anti-A+B et Anti-D). Quelle est la méthode qui a été utilisée ?

A- La méthode de Simonin B- La méthode Simonne C- La méthode de Beth Vincent

73. Quels sont les moyens physiques de lutte contre la fièvre chez Mlle Charine Z ? (deux réponses)

A- Bain à l'eau chaude C- Ventilation manuelle E- Pose de vessie de glace

B- Enveloppement humide D- Déshabillage complet F- Mettre la climatisation

SUJET N° 2 : OCCLUSIONS INTESTINALES

QCD

1. Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal A / B
2. L'arrêt des gaz est plus fiable que l'arrêt des matières A / B
3. Le but du traitement est de lever ou supprimer l'obstacle A / B
4. L'occlusion intestinale relève de quatre (04) processus A / B
5. Les occlusions inflammatoires sont aussi appelées mixtes A / B
6. Les occlusions mécaniques sont dues à un obstacle organique A / B
7. La strangulation se caractérise par l'existence de lésions vasculaires liées à l'écrasement ou à la torsion des vaisseaux du méso-colon A / B
8. Les occlusions fonctionnelles sont le fait du dérèglement du système nerveux intestinal A / B
9. Les occlusions hautes ne siègent pas sur l'œsophage A / B
10. Les occlusions siègent aussi dans l'estomac A / B
11. Les occlusions hautes siègent uniquement sur l'intestin grêle A / B
12. Les occlusions basses siègent uniquement sur le côlon A / B
13. L'intestin grêle est la portion la plus longue (environ 7m) du tube digestif A / B
14. Le météorisme abdominal est l'augmentation du volume de l'abdomen A / B
15. La rate ne fait pas partie des organes de l'appareil digestif A / B
16. Le côlon est la partie du tube digestif située entre l'intestin grêle et le rectum A / B
17. Le côlon sigmoïde est la partie du gros intestin située juste au-dessus du rectum A / B
18. L'hyperthermie est le signe fonctionnel capital de l'occlusion intestinale aigüe A / B
19. Toute affection de voisinage peut créer une occlusion inflammatoire A / B
20. Les occlusions inflammatoires sont la combinaison des occlusions mécaniques et fonctionnelles A / B
21. La parasitose intestinale peut créer une occlusion A / B
22. Les aliments non digestes peuvent réaliser une occlusion intestinale A / B
23. Le volvulus est la torsion de l'anse intestinale sur elle-même A / B
24. Quatre symptômes essentiels caractérisent l'occlusion A / B
25. Chez l'occlus intestinal, la pose d'une sonde d'aspiration nasogastrique est un geste d'urgence A / B
26. Chez l'occlus intestinal, la pose d'une sonde urinaire à demeure est un geste d'urgence A / B
27. L'occlusion intestinale provoque une perturbation de l'ionogramme du patient A / B
28. L'occlusion par strangulation est une occlusion fonctionnelle A / B
29. L'occlusion par abcès appendiculaire est une occlusion mécanique A / B
30. L'occlusion par abcès appendiculaire est une occlusion mécanique A B L'occlusion se caractérise par deux (2) signes physiques et un (1) signe fonctionnel A / B

31. Le météorisme abdominal est un signe fonctionnel de l'occlusion intestinale A / B
32. Un trouble du métabolisme peut occasionner une occlusion intestinale A / B

QCM

33. Identifiez les segments de l'intestin grêle parmi ceux qui sont énumérés en dessous. (Trois réponses)

A- L'appendice C- Le duodénum E- L'iléon
B- Le caecum D- Le jéjunum

34. Quelles sont les trois principales parties du côlon ?

A- L'anus C- Le côlon descendant E- Le sphincter anal
B- Le côlon ascendant D- Le côlon transverse

35. Quels sont les trois processus dont relève l'occlusion intestinale aigüe ?

A- Les occlusions chimiques D- Les occlusions mécaniques
B- Les occlusions fonctionnelles E- Les occlusions thermiques
C- Les occlusions inflammatoires (ou mixtes) F- Les occlusions hormonales

36. Le syndrome occlusif est constitué de : choisir la bonne réponse

A- Signes cliniques D- signes cliniques et biologiques
B- Signes biologiques E- signes biologiques et radiologique
C- Signes radiologiques F- signes clinique, biologique et radiologique

37. L'obstacle organique dans les occlusions mécaniques relève de deux mécanismes. Lesquels ?

A- Le déchirement C- L'éclatement E- L'obturation
B- L'étirement D- La dispersion F- La strangulation

38. Dans l'OIA mécanique l'obturation ou l'obstacle peut intéresser. (Choisir la bonne réponse)

A- La lumière intestinale
B- La paroi intestinale
C- La compression du tube intestinal
D- La lumière intestinale et la paroi intestinale
E- La paroi intestinale et la compression du tube intestinal
F- La paroi intestinale, la lumière intestinale et la compression du tube intestinal

39. La strangulation se caractérise par : (3 réponses)

A- Une élongation de l'anse D- Un raccourcissement de l'intestin
B- Une incarcération d'une anse dans un orifice ou une logette E- Un volvulus
C- Une invagination

40. Les occlusions fonctionnelles se manifestent soit par :

A- une paralysie des anses B- des spasmes C- des spasmes ou une paralysie des anses

41. les occlusions mixtes se rencontrent au cours :

A- des péritonites aigües C- d'affections septiques de voisinage
B- des péritonites chroniques D- des péritonites aigües, chroniques ou affections de voisinage

42. Quel est le bon item qui caractérise l'occlusion parmi les quatre symptômes essentiels énumérés en dessous. (Choisir la bonne réponse)

A- 1 signe fonctionnel et 3 signes physiques C- 2 signes fonctionnels et 2 signes physiques
B- 3 signes fonctionnels et 1 signe physique

43. Quels sont les signes fonctionnels qui caractérisent l'occlusion ? Choisir les trois (03) bonnes réponses

A- L'arrêt des matières et des gaz C- Les douleurs abdominales E- Les vomissements
B- Les céphalées D- L'hyperthermie F- L'obnubilation

44. Quel est le signe physique de l'occlusion intestinale aigüe ? : Choisir la bonne réponse

A- La contracture abdominale C- Le météorisme abdominal
B- La déformation de la cage thoracique

45. A l'inspection le météorisme abdominal peut-être :

A- Actif B- Immobile C- Ni immobile ni actif

46. A La palpation, on note : (3 réponses)

A- Abdomen tendu, siège d'une résistance élastique C- Douleur provoquée
B- Absence de contracture pariétale D- Présence de contracture pariétale

47. La percussion révèle soit : (Deux réponses)

A- Une matité B- Un tympanisme C- Ni tympanisme ni matité

48. L'auscultation révèle soit : (Choisir deux réponses)

A- Borborygmes B- Ni borborygmes C- Silence abdominal D- Ni silence abdominal

49. Que recherchent les touchers pelviens ? (Trois réponses)

A- Absence de douleur au niveau du cul-de-sac D- Obstacle haut situé
B- Vacuité de l'ampoule rectale E- La présence d'une ascite
C- Obstacle bas situé (tumeur, fécalome) F- Le volume de l'abdomen

50. Quels sont les signes généraux d'une occlusion intestinale aigüe ? 4 reponses

A- Etat général est bien conservé C- le pouls régulier et bien frappé E- L'hyperthermie
B- TA normale, D- Absence de fièvre F- hyper sialorrhée

51. Quels sont les signes biologiques d'une occlusion intestinale aigüe ? Choisir les trois bonnes réponses

A- Acidose D-Hyperglycémie/Hyperazotémie/Hyperleucocytose
B- Basique E- Hémoconcentration/Hypovolémie
C- Hypochlorémie/Hyponatrémie/Hypokaliémie

52. Quels sont les signes radiologiques parmi ceux proposés en dessous ? Choisir les deux plus usités dans notre pratique

A- Les clichés de l'abdomen sans préparation C- Le lavement baryté
B- L'imagerie par résonance magnétique D- La tomodensitométrie

53. Quels sont les symptômes de l'occlusion intestinale parmi ceux-ci énumérés ? (3 réponses)

A- Douleurs brutales et vives avec paroxysmes rapprochés
B- Douleurs progressives et insidieuses
C- Vomissements précoces, abondants et bilieux
D- Vomissements rares et tardifs
E- Images hydro-aériques centrales, multiples plus hautes que larges
F- L'arrêt des matières et des gaz est très net

54. Quels sont les symptômes de l'occlusion colique parmi ceux-ci énumérés ? (4 réponses)

A- Douleurs brutales et vives avec paroxysmes rapprochés
B- Douleurs progressives et insidieuses
C- Vomissements précoces, abondants et bilieux
D- Vomissements rares et tardifs
E- Images de bulles hydro-aériques d'autant plus nombreuses que l'obstacle est plus bas situé
F- L'arrêt des matières et des gaz est très net

55. Le traitement des OIA comporte une double action :

A- la correction des déséquilibres humoraux C- A et B
B- la suppression de l'obstacle

56. Les brides intestinales sont la cause de l'une des occlusions ci-dessous, exceptée une ; laquelle ?

A. Occlusions mécaniques B. Occlusions fonctionnelles C. Occlusions mixtes

57. DN a un taux d'hémoglobine bas. La quantité de sang à transfuser à DN se calcule avec la constante

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

58. ND reçoit un culot globulaire pour sa transfusion après une numération. La quantité du culot globulaire a été calculée par la constante

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

59. Les éléments ci-dessous décrivent la clinique d'une occlusion intestinale colique exceptés deux ; lesquels ?

A. L'arrêt des matières et des gaz est net D. La dégradation rapide de l'état général
B. L'arrêt des matières et des gaz peu nets E. L'état général est longtemps bien conservé
C. Le météorisme est précoce et important F. Les vomissements sont rares et tardifs

60. La liste ci-dessous contient deux causes de l'occlusion intestinale fonctionnelle ; lesquelles ?

A. Hypocalcémie C. Hypercalcémie E. Hypokaliémie
B. Hypomagnésémie D. Hypernatrémie F. Hyperkaliémie

61. Le syndrome occlusif comprend la symptomatologie ci-dessous exceptée deux (2) signes ; lesquels ?

A. Tuméfaction inguinale C. Epreinte abdominale E. Vomissements
B. Douleur abdominale D. Météorisme abdominal F. Arrêt des matières et des gaz

CAS CLINIQUE N°1

Mlle KOSSIA âgée de 25 ans avec une taille de 1.65 mètres et un IMC = 21,67 et un taux d'hémoglobine de 4g/dl que le médecin veut ramener à 10g/dl après la transfusion d'un culot globulaire.

62. Le poids de Mlle KOSSIA est

A. 60 kg B. 59 kg C. 58 kg D. 57 kg

63. La constante à utiliser pour calculer la quantité de culot globulaire de transfusion de Mlle KOSSIA est

A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

64. La quantité de culot globulaire à transfuser à Mlle KOSSIA est

A. 2124 ml B. 1770 ml C. 1062 ml D. 708 ml

65. BK fait une occlusion intestinale et son état général s'est rapidement dégradé. L'occlusion de BK est probablement A. Haut située B. Bas située

66. BKA fait une occlusion intestinale et le lavement baryté injecté prend la totalité du cadre colique en encerclant les anses jéjunales. L'occlusion de BKA est probablement

A. Haut située B. Bas située

67. Les éléments ci-dessous décrivent la clinique d'une occlusion intestinale haute ; lesquels ?

A. L'arrêt des matières et des gaz est net D. La dégradation rapide de l'état général
B. L'arrêt des matières et des gaz peu nets E. L'état général est longtemps bien conservé
C. Le météorisme est précoce et important F. Les vomissements sont rares et tardifs

CAS CLINIQUE N°2

Au cours de votre garde aux urgences chirurgicales du CHU de BOUAKE, vous recevez M. KOUYATE Bassori, fervent musulman et chauffeur à la retraite pour douleurs abdominales et vomissements incoercibles depuis environ 6 heures. A la suite d'un examen clinique minutieux effectué par le chirurgien et au regard des résultats des examens paracliniques, celui-ci pose le diagnostic d'occlusion aigüe du grêle. Il est âgé de 68 ans, pèse 74 kg pour 1,77m

68. Qu'est-ce qu'une occlusion intestinale aiguë?

A- Arrêt temporaire du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal
B- Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal donné
C- Arrêt complet et momentané du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal
D-Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans l'œsophage
E- Arrêt complet et permanent du transit des matières et des gaz dans l'estomac

69. Quelles sont les deux causes probables de cette occlusion ?

A- les parasitoses intestinales B- la paralysie intestinale C- l'obésité D- le stress

70. Quels sont les trois (03) mécanismes dont relève l'occlusion intestinale aiguë ?

A- les occlusions mécaniques C- les occlusions humorales E- les occlusions inflammatoires ou mixtes
B- les occlusions fonctionnelles D- les occlusions hormonales

71. Quel est l'examen le plus usuel à pratiquer en urgence pour confirmer le diagnostic ?

A- l'échographie abdominale C- la radiographie de l'abdomen sans préparation
B- le lavement baryté D- le scanner

72. Quels sont les quatre (04) symptômes essentiels qui caractérisent le syndrome occlusif ?

A- les douleurs abdominales C- l'arrêt des matières et des gaz E- la fièvre
B- les vomissements D- le météorisme abdominal F- l' hyper sialorrhée

73. quels sont les signes fonctionnels de l'occlusion parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Trois réponses)

A- les douleurs abdominales C- l'arrêt des matières et des gaz E- la fièvre
B- les vomissements D- le météorisme abdominal F- l' hyperleucocytose

74. Déterminez deux (2) diagnostics infirmiers dont un en rapport avec la maladie et l'autre avec la situation sociale de M.Kouyaté

A- Douleurs abdominales dues à la pathologie
B- Impossibilité de s'occuper en vue de se réaliser reliée à son hospitalisation
C-Risque d'infection du site opératoire relié à l'intervention
D-Renvoi probable dû à son inactivité
E- Difficultés de pratiquer sa religion ou agir selon ses croyances

75. Identifiez deux (2) besoins fondamentaux prioritaires à satisfaire par M. Kouyaté

A-besoin d'éliminer les déchets métaboliques C-besoin de s'occuper en vue de se rendre utile
B-besoin d'être propre, et protéger ses téguments D-besoin d'éviter les dangers

76. Ressortez les activités à mener par l'infirmière à la phase post-opératoire de cette affection

A- Faire la préparation psychologique
B- Rasage large de la zone d'intervention
C- prélever du sang pour le bilan électrolytique et le groupage
D- Surveiller le bon écoulement de la perfusion
E- Contrôler les constantes
F- Assurer les soins d'hygiène

SUJET N°3 : PERITONITES AIGUES/HERNIES

1. La péritonite est une inflammation aigue localisée ou généralisée de la membrane qui couvre les organes de l'abdomen A / B
2. Le péritoine permet de maintenir les organes au sein de la cavité abdominale A / B
3. On peut observer une péritonite dans toutes les régions de l'abdomen A / B
4. Le signe capital de la péritonite est la contracture abdominale A / B
5. La contracture permanente et invincible des muscles de la paroi abdominale est dite « Ventre de Bois » A / B
6. La péritonite même sans traitement évolue vers la guérison A / B
7. La péritonite chronique tuberculeuse est plus fréquente chez l'homme que chez la femme A / B
8. Le traitement de la péritonite est seulement chirurgical A / B
9. La salpingite est une étiologie de la péritonite A / B
10. Un traumatisme abdominal peut provoquer une péritonite A / B
11. La péritonite peut avoir pour cause le BK A / B
12. Dans la péritonite la présence de l'hyperthermie est relative A / B
13. La hernie existe aussi chez la femme A / B
14. La hernie est plus fréquente chez la vieillesse que l'adolescence A / B
15. La hernie atteint exclusivement les hommes A / B
16. La hernie est l'issue spontanée d'un viscère hors des limites de la cavité abdomino-pelvienne A / B
17. L'étranglement herniaire est la constriction brutale serrée et permanente d'un viscère à l'intérieur du sac herniaire A / B
18. Le collet herniaire est le trajet qu'emprunte le viscère pour constituer la hernie A / B
19. L'enveloppe de la hernie s'appelle le sac A / B
20. L'omphalocèle est la hernie ombilicale du nouveau-né A / B
21. Les hernies ombilicales s'observent le plus souvent chez les vieillards A / B
22. La hernie crurale est surtout observée chez la femme adulte A / B

QCM

23. Quels sont les organes qui sont entourés par le péritoine parmi ceux qui énumérés en dessous ? (Trois réponses)
A- Le cœur C- L'estomac E- Le foie
B- L'œsophage D- Les anses intestinales F- La rate

24. La péritonite est une inflammation due à : (Trois réponses)
A- Une agression bactérienne C- Une blessure E- la restriction alimentaire
B- Une agression chimique D- la gourmandise

25. Parmi les types de péritonite énumérés en dessous ; lequel des éléments n'en fait pas partie ?
A- Primitives B- Secondaires C- Tertiaires D- Quaternaires

26. Parmi les causes de la péritonite, quelles sont celles qui sont moins fréquentes ?
A- Perforation appendiculaire C- Perforation du grêle d'origine typhique E- Pancréatite aigüe
B- Perforation d'ulcère gastroduodénal D- Salpingite F- Cholécystite aigüe

27. Quels sont les signes fonctionnels de la péritonite aiguë diffuse parmi ceux qui sont énumérés en dessous? (Trois réponses)
A- Douleur abdominale brutale, intense avec diffusion progressive
B- Vomissements incessants bilieux, porracés puis fécaloïdes
C- Arrêt des matières et des gaz franc
D- Hoquet
E- Immobilité diaphragmatique à l'inspection
F- Contracture abdominale à la palpation

28. Quels sont les signes qu'on retrouve à l'auscultation ? (Deux réponses)
A- Silence abdominal B- Bruits hydro aériques C- Silence abdominal et gargouille

29. Quels sont les signes généraux de la péritonite aiguë généralisée ou diffuse parmi ceux énumérés en dessous ? (Trois réponses)
A- Hyperthermie C- Signes de choc hypovolémique E- Déshydratation
B- Vomissement D- Altération du faciès

30. La péritonite non traitée peut évoluer rapidement vers un choc. Lesquels ? (Trois réponses)
A- Choc anaphylactique C- Choc septique E- Choc traumatique
B- Choc hypovolémique D- Choc cardiogénique

31. Quelles sont les causes pré disposantes de la péritonite chronique chez la femme ?
A- L'obésité C- La grossesse E- L'alcoolisme
B- L'activité sexuelle D- L'accouchement F- L'inactivité physique

32. Quels sont les buts de traitement de la péritonite ? (Quatre réponses)
A- Corriger les désordres hydro électrolytiques D- Prévenir et traiter les complications
B- Supprimer la source de contamination E- Dissiper les craintes du patient
C- Réduire la contamination bactérienne F- Préparer le patient à l'intervention chirurgicale

33. En quoi consiste le traitement médical de la péritonite ? (Quatre réponses)
A- Correction des déséquilibres hydriques et électrolytiques D- Sonde nasogastrique
B- Transfusion sanguine uniquement E- Sonde urinaire à demeure
C- Voies veineuses

34. La liste des différents types de péritonites ci-dessous contient un intrus ; lequel ?
A- Péritonite aigüe diffuse C- Echinococcose péritonéale E- Tuberculose péritonéale
B- Péritonite localisée D- Péritonite œsophagienne F- Péritonite plastique localisée

35. La hernie peut être :
A- Seulement congénitale B- Seulement acquise C- Congénitale ou acquise

36. Quelles sont les causes les plus fréquentes des hernies parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (choisir Trois réponses)
A- L'immaturité du système nerveux C- Amaigrissement rapide E- Les travaux de force
B- La vieillesse D- Le jeûne F- Obésité

37. Parmi les hernies de la paroi abdominale ci-dessous, quelles sont celles qui n'en font pas partie ? (Deux réponses)

A- la hernie discale C- La hernie inguino-péritonéale E- La hernie crurale
B- La hernie diaphragmatique ou hiatale D- La hernie de la ligne blanche F- La hernie ombilicale

38. Quelles sont les hernies les plus fréquentes parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Trois réponses)

A- Les hernies diaphragmatiques C- Les hernies crurales E- Les hernies ombilicales
B- Les hernies discales D- Les hernies inguinales

39. Quels sont les éléments qui ne font pas partie des constituants de la hernie parmi ceux qui sont énumérés ci-dessous ? (Deux réponses)

A- Le collier C- L'enveloppe E- Le scrotum
B- Le collet herniaire D- Le contenu

40. Identifiez les éléments ne faisant pas partie des contenus probables de la hernie ? (Trois réponses)

A- L'intestin grêle C- L'épiploon E- Le pus
B- Le côlon D- L'eau F- Le sang

41. Quels sont les signes de la hernie étranglée parmi ceux qui sont énumérés en dessous? (Quatre réponses)

A- Tuméfaction indolore au niveau du collet D- Non impulsive à la toux
B- Gêne à la marche E- Douleurs vives et intenses
C- Irréductible par pression lente et progressive F- Nausées et vomissements plus ou moins précoces

42. Quels sont les signes de la hernie non compliquée parmi ceux-ci ? (Quatre réponses)

A- Rarement douleur au niveau du collet D- Expansive à la toux
B- Tiraillement à la marche E- Douleurs vives et intenses
C- Réductible par pression lente et progressive F- Arrêt des matières et des gaz

43. La liste ci-dessous contient trois (03) étiologies des hernies, lesquelles ?

A- Age supérieur à 15 ans C- Diabète E- Amaigrissement rapide
B- Obésité D- Métiers de force F- Infection à VIH

44. Lors de la réduction d'une hernie inguinale, le gargouillement indique

A- La présence d'une péritonite par ischémie C- La présence d'un organe plein dans le sac herniaire
B- La présence de l'intestin dans le sac herniaire D- La présence de l'épiploon dans le sac herniaire

45. S'agissant de la hernie non compliquée, trois des assertions ci-dessous sont fausses. Lesquelles ?

A- Une tumeur irréductible et élastique
B- Une tumeur réductible et élastique
C- Une tumeur réductible et disparaissant par le décubitus
D- Une tumeur avec les signes cardinaux de l'inflammation
E- Une tumeur adhérente à la paroi abdominale
F- Une tumeur impulsive à la toux

46. La liste ci-dessous contient les évolutions et complications de la hernie inguinale ; lesquelles ? (Deux réponses)

A- Hydrocèle liée à la hernie C- Etranglement herniaire E- Ectopie testiculaire
B- Contusion herniaire D- Cancer hernie hiatale F- Tuberculose du sac herniaire

47. Parmi les variétés de hernies ci-dessous, l'une est située dans le thorax, laquelle ?

A- Omphalocèle B- Hernie discale C- Hernie hiatale D- Hernie crurale

CAS CLINIQUE N°1

Vous recevez au centre de santé rural de GOUKRO, ou vous exercez en tant qu'IDE M.TOUHE 45 ans extracteur de 'vin de rônier'. A l'interrogatoire, il vous signale ; - Une douleur spontanée et vive au niveau de l'abdomen - Des vomissements précédés de nausées - Hypertendu et diabétique

A l'inspection et la palpation, vous notez : - Une tuméfaction luisante dans le cadran gauche de l'abdomen - Sensation de tension, douloureuse, non impulsive et non expansive à la toux

48. Quel est votre diagnostic présomptif ?

A- Appendicite aigüe C- Hernie compliquée E- Occlusion intestinale aigue
B- Hernie non compliquée D- Péritonite

49. Quels sont les signes qui justifient le diagnostic ? (Deux réponses)

A- Douleur spontanée et vive à l'abdomen
B- Tuméfaction luisante non impulsive et non expansive à la toux
C- Nausées
D- Vomissements

50. Quelles sont les causes probables de cette pathologie ? (Deux réponses)

A- Consommation excessive d'alcool
B- Consommation accrue d'aphrodisiaques
C- Maladies chroniques
D- Métiers de force

51. Choisissez les 3 réponses qui sont les principaux signes de la hernie non étranglée :

A- La réductibilité
B- L'impulsivité à la toux
C- La douleur spontanée
D- De grosses bourses indolentes
E- L'expansion à la toux
F- Les troubles digestifs

52. Quelle est votre CAT au centre de santé ? (Trois réponses)

A- Prise des constantes
B- Soins spécifiques
C- Informer l'entourage de la maladie
D- Inscrire le cas dans le registre
E- Planifier l'intervention chirurgicale
F- Référer vers le centre le plus proche et le plus équipé

CAS CLINIQUE N°2

Au cours de votre permanence aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké, vous recevez Mme KONATE S. 52 ans adressée par une infirmerie privée de la place pour : - Douleurs abdominales diffuses en << coups de poignard » - Nausées et vomissements -TA à 10/7 cm Hg -Pouls à 100 battements par minute - Fièvre à 39°C -Altération de l'état général

Après un examen clinique minutieux, le chirurgien décide de l'opérer dans deux (02) jours et lui prescrit : -1 flacon de sang de 500 ml - Une réanimation hydro électrolytique- Une aspiration digestive

53. A quelle affection vous font penser ces signes ?

A- Ulcère gastroduodénal
B- Pancréatite aigüe
C- Grossesse tubaire
D- Péritonite aigüe
E- Occlusion intestinale aigüe

54. Quelles sont les deux (02) causes probables de cette affection parmi celles-ci ?

A- Traumatisme fermé de l'abdomen
B- Ulcère gastroduodénal perforé
C- Hernie hiatale
D- Salpingite
E- Appendicite non rompue
F- Déficience de l'état général

55. Quel est le signe capital recherché par l'examen physique ?

A- La paresthésie cutanée
B- La douleur abdominale constante
C- L'hyperthermie
D- La contracture abdominale ou ''ventre de bois''
E- L'anémie
F- L'hyperleucocytose

56. Quels sont les soins que vous lui donniez avant l'intervention chirurgicale ? (Trois réponses)

A- Administration de la médication prescrite
B- Prise régulière des constantes
C- Lui présenter un haricot en cas de vomissement
D- Lui dire son diagnostic
E- Faire la préparation physique de la zone d'intervention chirurgicale
F- Vérifier que l'auxiliaire administre des soins de qualité

57. Quelles sont les précautions à prendre avant la pose de la poche de sang ? (quatre réponses)

A- Faire le test de compatibilité
B- Vérifier la concordance de la poche de sang avec le sang prescrit
C- Voir l'aspect du sang
D- Bien régler le débit de la transfusion
E- Vérifier l'écoulement du sang
F- S'assurer que la malade n'a pas de besoin urgent à satisfaire

58. Lors de la pose de cette transfusion, vous vous êtes piqué(e) avec l'aiguille souillée usagée. Que faites-vous ? (Trois réponses)

A- Faire saigner la plaie
B- Nettoyer la plaie avec une solution antiseptique et continuer les soins

C- Informer le Major et vous rentrer chez vous
D- Faire le test de sérologie virale
E- Demander à l'Aide-Soignant de vous suppléer
F- Faire une déclaration d'AES chez le médecin référent

59. Quels sont les éléments de surveillance pendant l'aspiration digestive ? (Deux réponses)

A- Apport liquidien oral pour compenser les pertes liquidiennes
B- Surveiller l'aspect et la quantité du liquide aspiré
C- Mobiliser la sonde pour qu'elle n'adhère pas à la paroi gastrique
D- Contrôler le bon fonctionnement de l'appareillage
E- Vérifier l'état général du patient

60. Quels sont les éléments de préparation physique la veille de l'intervention ? (Trois réponses)

A- Faire la toilette générale
B- Faire un rasage de l'abdomen et du pubis
C- Désinfecter la peau au moyen de solution antiseptique et recouvrir la partie avec un champ opératoire stérile
D- Contrôler le réveil physiologique du malade
E- S'assurer que le patient est à jeun la veille de l'intervention
F- Prescrire la prémédication

61. Quel est le besoin prioritaire non satisfait ?

A- Besoin de maintenir la température du corps dans les limites normales
B- Besoin de respirer
C- Besoin de s'occuper de façon à se sentir utile
D- Besoin de communiquer avec ses semblables
E- Besoin de manger et boire
F- Besoin de se mouvoir et se maintenir dans une position convenable

62. Quelles sont les méthodes qui permettront de déterminer son groupe sanguin et rhésus ? (Deux réponses)

A- Méthode de SIMON C- Méthode de SIMONNE E- Méthode de SIMONIN
B- Méthode de BETH SIMONIN D- Méthode de BETH VINCENT

63. Sachant que les sérums tests Anti-A, Anti-B, Anti AB agglutinent son sang sauf l'Anti-D. Quel est le groupe sanguin de Mme KONATE ?

A- O négatif B- AB négatif C- O positif D- AB positif

64. Avec un débit de 42 gouttes par minute, déterminez l'heure de la fin de la transfusion si celle a débuté 10 h 30. A- 12 h 30 B- 13 h 30 C- 14 h 30 D- 15 h 30

SUJET N°4 : CONTUSIONS ABDOMINALES

QCD

1. La contusion est toute lésion produite par un agent extérieur au niveau du thorax A / B
2. La contusion est un traumatisme fermé sans effraction du tissu de revêtement A / B
3. L'agent causal de la contusion est un agent tranchant physique A / B
4. L'intestin grêle superficiellement exposé est une cause physiologique prédisposante de la contusion A / B
5. La rate paludéenne est une cause pathologique prédisposante de la contusion A / B
6. Les relâchements de la paroi abdominale sont une cause physiologique prédisposante de la contusion A / B
7. Les réplétions des intestins sont une cause anatomique prédisposante de la contusion A / B
8. Les intestins adhérents sont une cause pathologique de la contusion A / B
9. Les lésions pariétales réalisent une simple ecchymose et un hématome de la paroi. A / B
10. Les lésions des viscères creux évoluent vers une péritonite A / B
11. Les lésions des viscères pleins aboutissent à un tableau d'hémorragie externe A / B
12. Une ecchymose est caractérisée par une coloration normale de la peau et des téguments A / B
13. La rate ne fait pas partie des organes de l'appareil digestif A / B

QCM

14. Identifiez les causes des contusions abdominales parmi celles qui sont énumérées en dessous. (3 réponses)

A- Agressions C- Accident de travail et de sport E- Emaciation
B- Accidents de la voie publique D- Dermatoses F- Obésité

15. Quel est le mécanisme de survenue des contusions abdominales ? (1 seule réponse)

A- Choc direct ou indirect C- Choc hypovolémique
B- Choc septique D- Choc anaphylactique

16. Quelles sont les lésions que détermine un choc direct sur l'abdomen secondaire à une percussion ? (Trois réponses) A- Dispersion C- Dilacération E- Ecrasement
B- Dissection D- Eclatement F- Eparpillement

17. Quels sont les agents contondants physiques pouvant être responsables de contusions abdominales : (Trois réponses) A- Le bâton C- Le fusil E- Le marteau
B- Le couteau D- La manchette F- Le coup de poing

18. Quelles sont les lésions qu'un choc indirect dû à la décélération brutale ne peut entraîner ? (3 réponses)

A- Etirement C- Arrachement des moyens de fixité des viscères intra abdominaux E- Nécrose
B- Rupture D- Délabrement F- Macération

19. Les contusions des parties molles peuvent réaliser 4 types de lésions. Lequel n'en fait pas partie ?

A- l'épanchement sanguin C- la nécrose primaire de la peau E- les décollements cutanés
B- l'épanchement séreux D- la nécrose secondaire de la peau

20. Parmi les causes prédisposantes des contusions énumérées ci-dessous, deux n'en font pas partie. Lesquelles ?

A- Les causes anatomiques C- Les causes pathologiques E- Les causes radiologiques
B- Les causes physiologiques D- Les causes biologiques

21. Parmi les causes prédisposantes des contusions abdominales énumérées ci-dessous, quelles sont celles qui relèvent des causes physiologiques ? (2 réponses)

A- le cas des intestins grêles superficiellement exposés D- les intestins adhérents
B- les relâchements de la paroi abdominale E- la rate paludéenne
C- les réplétions des intestins

22. Parmi les causes prédisposantes des contusions abdominales énumérées ci-dessous, quelles sont celles qui relèvent des causes pathologiques ? (deux réponses)

A- le cas des intestins grêles superficiellement exposés D- Les intestins adhérents
B- les relâchements de la paroi abdominale E- La rate paludéenne
C- les réplétions des intestins

23. Quels sont les deux types de contusion qu'on distingue ?

A- Les contusions simples C- Les contusions composées
B- Les contusions graves D- Les contusions complexes

24. Quelles sont les complications qu'on peut observer en cas de contusion abdominale ? (Trois réponses)

A- Infections C- Nécroses cutanées et musculaires E- Pseudarthrose
B- Chocs D- Amyotrophie F- Mauvaises cicatrisations

25. Quels sont les organes les plus atteints lors d'une contusion abdominale parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Quatre réponses)

A- Le cœur C- L'estomac E- La rate
B- Les poumons D- Le foie F- L'intestin grêle et colon

26. Quels sont les organes digestifs que contient la cavité abdominale parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? A- l'estomac C- le foie, E- le pancréas G- les reins
B- les intestins D- la vésicule biliaire F- la rate

27. Les interventions infirmières ci-dessous permettent d'évacuer un hématome post contusion persistant ; lesquelles ? A- Un pansement compressif C- Un repos strict E- Un pansement alcoolisé
B- Une ponction au trocart D- Une incision F- Une injection d'anticoagulant

28. Les interventions infirmières ci-dessous sont menées à l'admission d'un blessé victime d'une contusion (deux éléments de réponses)

a. Radiographie à la recherche d'une lésion osseuse
b. Evacuation rapide pour éviter une complication
c. Transfusion sanguine pour prévenir une anémie
d. Radiographie dorsolombaire systématique
e. Examen physique minutieux du blessé
f. Prélèvement sanguin pour hémoculture et antibiogramme

29. S'agissant des causes pré disposantes des contusions abdominales, l'une des causes ci-dessous est anatomique ; laquelle ?

A- Relâchement de la paroi abdominale
B- Splénomégalie et/ou hépatomégalie
C- Malformation de la paroi abdominale antérieure
D- Choc par percussion abdominale

30. Quels sont les symptômes du syndrome de l'hémorragie interne ; parmi ceux énumérés en dessous ? (Trois réponses)

A- Abdomen tendu
B- Bradypnée superficielle
C- Hépatomégalie
D- Polypnée superficielle
E- Splénomégalie
F- Tension artérielle effondrée

31. La liste ci-dessous contient les trois types de causes pré disposantes des contusions abdominales ; lesquelles ?

A- Les causes pariétales
B- Les causes anatomiques
C- Les causes viscérales
D- Les causes physiologiques
E- Les causes pathologiques
F- Les causes accidentelles

32. La rupture post contusionnelle d'un des viscères pleins ci-dessous est cause d'hémorragie interne et de perturbation de la production du glucagon et de l'insuline ; lequel ?

A- Le foie B- La rate C- Le pancréas D- Le rein

33. Les signes physiques ci-dessous sont en faveur d'une perforation intestinale dans les contusions abdominales ; lesquels ? (Trois réponses)

A- Immobilité diaphragmatique (respiration costale supérieure)
B- Douleur abdominale intense
C- Contracture abdominale (ventre de bois)
D- Nausées et vomissements
E- Ballonnement abdominal
F- Malade agité souffrant d'une soif intense

34. Dans la contusion abdominale, pourquoi l'on perfuse le malade avec modération ? Pour :

A- Ne pas perturber les examens hématologiques
B- Ne pas masquer une hémorragie interne
C- Assurer une surveillance adéquate
D- Dissiper un choc éventuel

35. Les signes fonctionnels ci-dessous permettent de suspecter précocement une perforation intestinale dans les contusions abdominales sauf un ; lequel ?

A- Le vomissement
B- L'émission sanglante anale
C- L'arrêt des matières et des gaz
D- La douleur spontanée ou intermittente

36. Quels sont les deux examens à réaliser pour confirmer la rupture de la rate ? (Deux réponses)

A- La radiographie de l'Abdomen Avec Préparation
B- La radiographie de l'Abdomen Sans Préparation
C- La Numération Formule sanguine
D- La Vitesse de Sédimentation
E- L'échographie abdominale

37. La rate est située dans l'un des cadrans de l'abdomen. Lequel?

A- le flanc gauche
B- le flanc droit
C- l'hypochondre droit
D- l'hypochondre gauche

38. La rate a trois fonctions. Lesquelles parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

A- destruction des globules rouges vieillis
B- Elaboration des hormones
C- participation à l'accroissement des organes intraabdominaux
D- participation au système immunitaire
E- réservoir de sang
F- Synthèse des protéines

39. Quel type de contusion est en cause ?

A- une contusion grave
B- une contusion simple

40. Quels sont les éléments en faveur de cette contusion en cause ? 4 réponses

A- Des douleurs abdominales diffuses
D- T.A. à 10/8 cm Hg

B- Une pâleur conjonctivale E- Taille à 1,72 m
C- Soif intense F- ponction abdominale hémorragique

41. Indiquez l'intervalle de la variation de la température normale chez un individu sain ?

A- 36°5 à 42°C B- 36°5 à 37°5 C 37°5 à 38°5 C

42. Quels sont les signes en faveur du choc hémodynamique ? (2 réponses)

A- Le pouls filant C- La coloration des téguments
B- La pression artérielle basse D- Les douleurs abdominales diffuses

43. Trois des signes ci-dessous sont évocateurs d'une hémorragie interne. Lesquels ?

A- Abdomen tendu C- Extrémités sensibles E- Respiration superficielle
B- Douleurs diffuses D- Langue saburrale F- Soif intense

44. Quelle est la principale conséquence de l'ablation de la rate ?

A- Corrige l'anémie
B- Arrête l'accroissement des organes intra-abdominaux
C- Expose l'organisme à des infections plus fréquentes
D- Régularise la production des hormones

45. Quel sera le débit de la perfusion ?

A- 41 gouttes/min B- 42 gouttes/min C- 43 gouttes/min

46. Quelles sont les interventions infirmières dans la prise en charge de M.HILI ? (Deux réponses)

A- Se présenter au patient D- Faire les pansements
B- Prendre régulièrement les constantes hémodynamiques E- Procéder à l'ablation de la rate
C- Administrer la médication prescrite

SUJET N°5 : HYDROCELE

1. L'hydrocèle est une accumulation de liquide dans une « poche » entourant le testicule A / B
2. L'hydrocèle atteint aussi la femme A / B
3. La vaginale est une membrane qui entoure le testicule A / B
4. Le bacille de Koch peut créer une hydrocèle A / B
5. La bilharziose est une parasitose en cause dans l'hydrocèle A / B
6. L'hydrocèle a les mêmes manifestations cliniques que la hernie A / B
7. Dans l'hydrocèle, la tuméfaction est translucide au test de la lampe torche A / B
8. L'hydrocèle est d'apparition insidieuse et d'évolution rapide A / B
9. L'hydrocèle est fréquente chez le nouveau-né A / B
10. L'hydrocèle chez le nouveau-né disparaît généralement sans traitement au cours de la première année A / B
11. Il n'existe pas de traitement médical de l'hydrocèle A / B
12. Dans l'hydrocèle, les bourses sont douloureuses A / B
13. Le test de la lampe torche ou transillumination permet de faire le diagnostic clinique de la hernie scrotale A / B
14. Dans l'hydrocèle, il est possible de pincer aisément la vaginale des bourses du patient lors de l'examen physique A / B
15. Quel que soit la taille de l'hydrocèle vaginale, la cure chirurgicale est la règle A / B
16. La cryptorchidie est toujours unilatérale A / B
17. Le testicule oscillant une cryptorchidie A / B
18. La cryptorchidie haute est appelée testicule oscillant A / B
19. Il existe deux (2) variétés de cryptorchidie : le testicule oscillant et le testicule ectopique A / B
20. Toutes les cryptorchidies sont associées à des hernies étranglées A / B
21. Le traitement de la cryptorchidie est toujours chirurgical A / B
22. La cryptorchidie basse est appelée testicule ectopique A / B
23. La prise en charge médicale du testicule oscillant est basée sur l'hormonothérapie A / B
24. La prise en charge chirurgicale du testicule ectopique s'impose entre 4 et 8 ans A / B
25. Les cryptorchidies peuvent être associées à une hernie étranglée A / B

QCM

26. Les hommes âgés peuvent développer une hydrocèle suite à : (Quatre réponses)

A- Une blessure
B- Une inflammation
C- Une infection
D- Une consommation excessive d'aphrodisiaque
E- Un choc au niveau des bourses
F- Une torsion testiculaire

27. Quels sont les parasites le plus souvent à l'origine d'une hydrocèle, parmi ceux-ci ? (Trois réponses)

A- La bilharziose
B- La filariose
C- Le bacille de Koch
D- Le virus immuno-humain
E- Le covid-19
F- Le gonocoque

28. Quelle est la cause d'une hydrocèle ? (Deux réponses)

A- Alimentaire B- Acquise C- Congénitale D- Héréditaire

29. L'hydrocèle peut être acquise suite à :

A- Un cancer de testicule
B- Une cryptorchidie
C- Une orchite aigüe
D- Une torsion de kyste testiculaire

30. La cryptorchidie haute est appelée

A. Testicule oscillant
B. Testicule ectopique
C. Hernie de Jean louis Petit
D. Hernie de la ligne blanche

CAS CLINIQUE N°1

M. SANOGO W .21ans 55kgs pour 1.65 m est venu consulter au centre de santé rural de Komboro, pour douleurs dans l'hypogastre depuis 2 jours. A l'interrogatoire Sensation de pesanteur à la marche De grosses bourses indolentes Peau du scrotum déplissée Existence de signes d'inflammation A l'inspection- palpation Tuméfaction rénitente fluctuante, transparente à la lumière Disparition de la verge dans un repli cutané Impossibilité de pincer la vaginale Irréductible Non expansive à la toux

31. Quel est votre diagnostic ?

A- Adénome de la prostate
B- Cryptorchidie
C- Hernie scrotale étranglée
D- Hydrocèle
E- Rétention urinaire

32. Quels sont les signes qui permettent de confirmer le diagnostic ? (Quatre signes)

A- Sensation de pesanteur à la marche
B- De grosses bourses indolentes
C- Impossibilité de pincer la vaginale
D- Existence de signes d'inflammation
E- Disparition de la verge dans un repli cutané
F- Tuméfaction rénitente fluctuante, transparente à la lumière

33. Quel est l'examen à faire ?

A- Abdomen sans préparation B- Echographie C- scanner

34. Quelle est votre conduite à tenir au centre ?

A- Mise en observation + perfusion
B- ponction à l'aiguille + pansement
C- soins spécifiques + référé

SUJET N°6 : ADENOME DE LA PROSTATE

QCD

1. L'adénome de la prostate est une tumeur maligne caractérisée par une hypertrophie et une hyperplasie de la glande prostatique A / B
2. L'adénome de la prostate atteint aussi la femme A / B
3. L'adénome de la prostate est une affection qui touche les hommes de plus de 50 ans A / B
4. L'adénome de la prostate est caractérisé par des troubles urinaires A / B
5. L'adénome de la prostate est caractérisé par des troubles digestifs A / B
6. La prostate est un organe exclusivement masculin A / B
7. La prostate est située sous la vessie A / B
8. Après adénectomie, cette tumeur peut récidiver A / B

9. La principale complication de l'adénome de la prostate est le cancer A / B
10. L'abstinence est la meilleure prévention de l'adénome de la prostate A / B
11. La principale cause de l'adénome de la prostate est la fréquence élevée des rapports sexuels A / B
12. La dysurie est un signe physique l'adénome de la prostate A / B
13. Un globe vésical donne à la percussion une sonorité A / B
14. Le dosage de la PSA permet de poser le diagnostic de l'adénome de la prostate A / B
15. Dans l'éjaculation rétrograde, le sperme est renvoyé en arrière vers la vessie A / B
16. L'une des conséquences de l'adénomectomie est la baisse de la virilité A / B
17. L'urètre a la même longueur chez l'homme et la femme A / B
18. Les douleurs vésicales sont un signe de caillotages lors de l'irrigation continue A / B
19. L'échographie prostatique permet de préciser le caractère malin ou bénin de l'adénome de la prostate A / B
20. La première cause du rétrécissement urétral est la blennorragie A / B
21. L'adénomectomie est pratiquée après la stérilisation des urines A / B
22. La ponction sus-pubienne est conditionnée par l'impossibilité d'une pose de sonde vésicale A / B
23. La portion moyenne de l'urètre est dite portion membraneuse A / B
24. L'adénome de la prostate est une affection qui touche de plus en plus les jeunes et les hommes de plus de 50 ans
25. Chez la femme et l'homme, l'urètre joue exactement le même rôle A / B
26. L'adénomectomie est une cause de l'éjaculation rétrograde A / B
27. Le soin de décaillotage se fait à l'aide d'une seringue de Guyon ou de gavage de 60 cc A / B
28. La portion proximale de l'urètre est dite portion caverneuse A / B
29. La ponction sus-pubienne est systématique en cas de rétention aigue d'urines A / B
30. La ponction sus-pubienne se fait sur une vessie en réplétion A / B
31. La lubrification physiologique de l'urètre est assurée par les sécrétions la glande de COWPER A / B
32. L'urètre spongieux est la portion distale de l'urètre A / B
33. Toute tumeur solide du rein est considérée comme un cancer jusqu'à preuve histologique contraire A / B

QCM

34. Quelles sont les fonctions qui ne sont pas de la prostate parmi celles énumérées en dessous ? 3 réponses

A- Participe à la constitution du sperme
B- participe au bon fonctionnement de l'éjaculation
C- corrige la faiblesse sexuelle
D- améliore la performance sexuelle
E- allonge l'organe sexuel
F- sécrète des hormones

35. Quelles sont les complications de l'adénome de la prostate parmi celles-ci ? 2 réponses

A- rétention urinaire
B- insuffisance cardiaque
C- insuffisance hépatique
D- insuffisance rénale

36. Quels sont les signes fonctionnels de l'adénome de la prostate parmi ceux-ci ? 4 réponses

A- Prolongement de la durée de l'éjaculation
B- Pollakiurie nocturne et/ou diurne
C- Impériosité mictionnelle
D- Miction retardée
E- Diminution de la force et du calibre du jet
F- Rétention urinaire aigue

37. Quels sont les signes physiques de l'adénome de la prostate parmi ceux-ci ? 3 réponses

A- Toucher rectal (vessie vide) pour apprécier le volume de la prostate
B- Palpation des deux fosses lombaires pour rechercher un gros rein (hydronéphrose ou tumeur)
C- Percussion pour rechercher un globe vésical par matité
D- Pollakiurie diurne et/ou nocturne
E- Jet urinaire haché et/ou faible
F- Impression de vidange vésicale incomplète

38. Quels sont les examens biologiques à faire pour poser le diagnostic ? 3 réponses

A- ASP B- Créatinine C- ECBU D- PSA E- IRM F- TDM

39. Quels sont les examens radiologiques à faire pour poser le diagnostic ?

A- Échographie rénale, vésicale et prostatique
B- Urographie intraveineuse(UIV)
C- La radiographie de l'abdomen sans préparation
D- Le lavement baryté

40. Quelles sont les actions infirmières avant l'intervention ? 5 réponses

A- Demander le bilan préopératoire
B- Faire des soins de propreté corporelle au patient
C- Préparation psychologique sur l'intervention
D- Préparation du champ d'intervention la veille
E- Faire observer le jeûne
F- Faire la prémédication

41. Quelles sont les actions infirmières pendant que le patient est en salle d'opération ? 3 réponses

A- Prévoir une feuille de surveillance
B- Réfection du lit
C- Apprêter les potences et appareils
D- Prise des constantes hémodynamiques
E- Surveiller le réveil physiologique du patient

42.Quelles sont les interventions infirmières prioritaires immédiates au retour du patient du bloc opératoire ? (Trois réponses)

A- Prise régulière des constantes
B- Surveillance du réveil physiologique
C- Vérification de la perméabilité des perfusions et leur débit
D- Surveillance du pansement
E- Recherche des signes de caillotages : douleurs vésicales, coloration des urines, arrêt de l'écoulement de la sonde
F- Conseils pour le suivi post-opératoire et le respect des rendez-vous

CAS CLINIQUE N°1

M. GAZO est hospitalisé dans le service d'Urologie du CHU de Bouaké où vous êtes IDE en fonction. Il est âgé de 68 ans. Il est polygame et père de six (06) enfants. Il présente une dysurie et une pollakiurie nocturne avec retard du jet souillant souvent ses vêtements. Le toucher rectal pratiqué par le chirurgien de garde confirme le diagnostic.

43. De quelle affection s'agit-il ?

A- Adénome prostatique
B- Rétrécissement urétral
C- Rétention urinaire
D- Fistule vésicale

44. Selon le modèle conceptuel de Virginia Henderson, deux (2) besoins prioritaires sont perturbés chez M.GAZO. Lesquels ?

A- Eliminer les déchets biologiques
B- Être propre, soigné et protéger ses téguments et phanères
C- Manger et boire
D- Respirer

45. Quels sont les examens para cliniques nécessaires au diagnostic du mal de M.GAZO ? 4 réponses

A- ECBU
B- Glycémie
C- Urétro cystographie rétrograde mictionnelle
D- Abdomen sans préparation
D. Urographie intra veineuse

46. Après l'intervention chirurgicale, quelles sont les activités infirmières à mener dans les 24 premières heures ? 3 réponses

A- Surveiller les signes vitaux
B- Faire le pansement
C- Vérifier le bon écoulement et début des perfusions
D- Administrer le traitement prescrit
E- Conseils pour le suivi post-opératoire et le respect des rendez-vous

47. Quels conseils donnerez-vous à M.ZOGA à sa sortie de l'hôpital ? 3 réponses

A- Lui dire d'arrêter des rapports sexuels
B- L'informer qu'il ne peut plus procréer
C- Lui dire de respecter les rendez-vous pour les pansements
D- De limiter la consommation des liquides le soir
E- De se faire vacciner
F- D'utiliser des aphrodisiaques régulièrement

SUJET N°7 : RETENTION URINAIRE/RETRECISSEMENT URETRAL

1. La rétention urinaire aigüe se traduit par une impossibilité brutale et totale d'uriner A / B
2. La rétention urinaire chronique se traduit par l'impossibilité de vider totalement la vessie A / B
3. La rétention urinaire chronique est caractérisée par l'existence d'un résidu post-mictionnel A / B
4. La rétention aigüe se caractérise par l'absence de résidu post-mictionnel A / B
5. La rétention complète d'urine peut avoir des retentissements sur le haut appareil urinaire A / B
6. La rétention incomplète d'urine ne peut pas créer une insuffisance rénale A / B
7. La rétention urinaire n'existe pas la femme A / B
8. La rétention urinaire aigue est une pathologie exclusivement masculine A / B
9. La rétention urinaire est plus fréquente chez l'homme que chez la femme A / B
10. Les rétentions aigües ou chroniques ont les mêmes étiologies A / B
11. L'urètre est un conduit unilatéral qui transporte les urines des reins vers la vessie A / B
12. L'uretère est un conduit bilatéral qui transporte les urines dans la vessie A / B
13. L'appareil génital féminin n'a pas d'urètre A / B
14. Le rétrécissement urétral est la réduction de la lumière de l'uretère A / B
15. La glande de Cowper outre sa participation à la formation du sperme lubrifie aussi l'uretère A / B
16. Le traumatisme de l'urètre par manipulation sexuelle est dit accidentel A / B
17. Le sphincter urétral permet de retenir les urines selon la volonté A / B
18. La polyurie est un terme qui signifie l'émission d'urine en quantité énorme A / B
19. L'oligurie est le fait d'émettre des urines fréquemment A / B
20. Les clichés per mictionnels montrent l'importance de la retro-dilatation en amont sur le haut appareil urinaire

QCM

21. Quelles sont les étiologies d'un rétrécissement urétral ? (Quatre réponses)

A- Le bacille de Koch
B- La bilharziose
C- La gonococcie
D- Le traumatisme iatrogène ou accidentel de l'urètre
E- La multiplicité des rapports sexuels
F- La consommation excessive des aphrodisiaques

22. Parmi les signes cliniques énumérés ci-dessous ; lesquels sont des signes fonctionnels du rétrécissement urétral ? (Deux réponses)

A- Douleurs lombaires avec masses à la palpation
B- Distension vésicale
C- Incontinence ou miction par regorgement
D- Pollakiurie consécutive à l'apparition d'un résidu vésical
E- Dysurie avec jet urinaire très fin
F- Miction prolongée par des gouttes retardatrices

23. Parmi les signes cliniques énumérés ci-dessous ; quatre (04) sont des signes physiques du rétrécissement urétral. Lesquels?

A- Distension vésicale
B- Douleurs lombaires avec masses à la palpation
C- Dysurie
D- Incontinence ou miction par regorgement
E- Miction prolongée par des gouttes retardatrices
F- Pollakiurie consécutive à l'apparition d'un résidu vésical

24. Identifiez trois (03) examens radiologiques à faire pour poser le diagnostic de rétrécissement urétral?

A- L'urétrocystographie
B- L'urétrographie intraveineuse
C- L'urétrocystographie rétrograde
D- Le dosage de la PSA
E- L'ASP
F- L'Echographie prostatique

25. Quelles sont les deux méthodes de traitement du rétrécissement urétral ? 3 réponses

A- La méthode instrumentale
B- L'urétérostomie
C- L'urétéroplastie
D- La laparotomie
E- La cœlioscopie

26. Deux (02) signes sont physiques de la rétention urinaire aigüe parmi ceux-ci. Lesquels ?

A- Besoins impérieux d'uriner
B- Douleur à la palpation
C- Douleur sus-pubienne
D- Fièvre
E- Impossibilité d'uriner
F- Masse hypogastrique

27. Identifiez les signes fonctionnels de la rétention aigüe parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? 3 réponses

A- Fièvre
B- Impossibilité d'uriner
C- Douleur sus-pubienne
D- Besoins impérieux d'uriner
E- Masse hypogastrique
F- Douleur à la palpation

28. Parmi les signes de la rétention urinaire chronique énumérés ci-dessous ; lesquels sont fonctionnels? (Deux réponses)

A- Fièvre
B- Incontinence par regorgement
C- Indolore à la palpation
D- Parfois gros reins distendus
E- Pollakiurie diurne ou nocturne
F- Présence de globe vésical flaccide

29. Parmi les signes cliniques énumérés ci-dessus ; lesquels sont des signes physiques ? (Trois réponses)

A- Présence de globe vésical flaccide
B- Pollakiurie diurne ou nocturne
C- Parfois gros reins distendus
D- Incontinence par regorgement
E- Indolore à la palpation
F- Fièvre

30. Quelles sont les étiologies des rétentions urinaires chez l'homme parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Quatre réponses)

A- Adénome de la prostate
B- Rétrécissement urétral scléro-inflammatoire
C- Phimosis serré
D- Maladie du col vésical
E- Rétroversion de l'utérus gravidique
F- Activité sexuelle intense

31. Quels sont les examens bactériologique et biologique à faire en cas de rétention urinaire? (Trois réponses)

A- Abdomen sans préparation (ASP)
B- Bilan rénal : Urée-créatinine
C- Dosage de la PSA << Antigène prostatique spécifique>>
D- Echographie
E- Examen Cytobactériologique des urines avec antibiogramme
F- Urographie intraveineuse (UIV)

32. Quels sont les examens radiologiques à faire pour confirmer le diagnostic de rétention d'urine parmi ceux-ci ? (Deux réponses)

A- Urographie intraveineuse (UIV)
B- Abdomen sans préparation (ASP)
C- Bilan rénal : Urée-créatinine
D- Examen Cytobactériologique des urines avec antibiogramme
E- Dosage de la PSA << Antigène prostatique spécifique>>
F- Echographie

33. Quels sont les deux (02) objectifs de soins !

A- effectuer une laparotomie
B- soulager la douleur
C- retour au mode d'élimination normal
D- mettre le patient au repos
E- rétablir la virilité du patient
F- Accroitre la fertilité

34. Deux (02) actes sont à effectuer en urgence chez un patient qui est en rétention urinaire. Lesquels ?

A- pratiquer l'adénomectomie
B- pratiquer la cystectomie
C- ponction sus-pubienne
D- sondage urétral

CAS CLINIQUE 1

IDE au centre de santé rural de Kagbôlo commune de Sinématiali, vous recevez M. SILIE Tiorna. 28 ans père de 2 enfants A l'interrogatoire, il vous signale : - Des douleurs sus pubiennes - Dysurie avec jet urinaire très fin - Miction prolongée par des gouttes retardatrices

A l'examen, vous notez : - Douleurs lombaires avec masses à la palpation - Distension vésicale - Incontinence ou miction par regorgement Ailleurs sans particularité

Les constantes sont les suivantes : - TA= 12/8 cm Hg - T°= 37°4 C - Pouls= 70 puls/min

35. Quel est votre diagnostic de présomption ?

A- Adénome de la prostate
B- Rétention urinaire aigue
C- Rétention urinaire chronique
D- Rétrécissement urétral

36. Quelle est la cause selon vous parmi celles qui sont proposées en dessous?

A- Activités sexuelles intenses
B- Consommation accrue d'aphrodisiaques
C- Présence de globe vésical
D- -Traumatique

37. Quelle est votre CAT ?

A- Pratiquer une dilatation de l'urètre
B- Pratiquer l'urétérostomie
C- Faire une cœlioscopie
D- Demander des examens complémentaires
E- Administrer des analgésiques et le référer vers le centre le plus pour une meilleure prise en charge

CAS CLINIQUE 2

Vous recevez à 21H50 min M. DAGNOGO Séguénon 65ans, pendant votre garde au CHU/Bké. Marié, il a 4 enfants L'Aide-Soignante a relevé les constantes suivantes : - T°= 37°5 C - TA= 150/80 mm Hg - Poids= 75 Kg - Taille= 175 cm - FR= 20 c/min - Pouls= 80 bat/min

Alors que l'interrogatoire mené a révélé : - Impossibilité brutale d'émettre des urines depuis 16 heures - Douleurs sus-pubiennes de plus en plus intense - Des besoins impérieux d'uriner devenant douloureux et n'aboutissant au mieux qu'à l'émission de quelques gouttes

Le médecin-chirurgien après examen a noté :

- Douleurs à la palpation de l'abdomen - Présence de globe vésical - Masse hypogastrique remontant à l'ombilic

38. Quel est votre diagnostic présomptif ?

A- Rétention urinaire chronique B- Adénome de la prostate C- Rétention urinaire aigüe

39. Deux (02) signes caractérisent la rétention urinaire aigüe parmi ceux qui sont énumérés en dessous. Lesquels ?

A- Impossibilité brutale et complète d'émettre des urines C- Présence de globe vésical
B- Impossibilité incomplète de vider totalement la vessie D- Présence de douleurs sus pubiennes

40. Quels sont les signes qui caractérisent la rétention urinaire chronique ? (Deux réponses)

A- Impossibilité complète d'uriner qui se traduit par brutale et totale d'uriner
B- Impossibilité incomplète de vider totalement la vessie
C- Présence de globe vésical
D- Existence de masse hypogastrique

41. Donnez deux causes probables parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

A- Activités sexuelles intenses C- Excès de consommation des aphrodisiaques
B- Maladie du col vésical D- Phimosis serré

42. Quel est le signe fonctionnel qui différencie la rétention chronique de la rétention aigüe ?

A- Douleur sus-pelvienne
B- Pollakiurie diurne ou nocturne par diminution de la capacité fonctionnelle
C- Présence de globe vésical flaccide, parfois énorme 2 à 3 litres

43. Quel est le signe physique qui caractérise la rétention chronique de la rétention aigüe ?

A- Pollakiurie diurne ou nocturne par diminution de la capacité fonctionnelle
B- Présence de globe vésical flaccide, parfois énorme 2 à 3 litres
C- Douleur sus-pelvienne

44. Quel est l'examen radiologique le plus usuel à effectuer pour confirmer le diagnostic ?

A- Abdomen sans préparation (ASP) C- Urographie intraveineuse (UIV) avec clichés per mictionnels
B- Abdomen avec préparation (AAP)

45. Quel est le traitement en urgence à administrer à M.DAGNOGO ?

A- Drainer l'urine B- Procéder à une intervention chirurgicale

46. Quelles sont les méthodes à envisager pour le soulager ? (Deux réponses)

A- Le sondage urétral C- La laparotomie
B- L'intervention immédiate au bloc opératoire D- La ponction sus-pubienne

47. Quelle IEC/CCC devriez-vous faire à M.DAGNOGO à sa sortie de l'hôpital ?

A- L'abstinence sexuelle
B- La prise d'aphrodisiaques
C- Le respect du régime alimentaire
D- L'hygiène corporelle et surtout intime

E- Revenir en consultation dès la constatation d'un quelconque trouble mictionnel
F- Eviter les traitements traditionnels

CAS CLINIQUE 3

Vous recevez M. YIEO Zana âgé de 52 ans en consultation. A l'issu de votre examen, vous posez le diagnostic de rétention aigüe d'urines.

48. Qu'est-ce que la rétention aigüe d'urines ?

A- L'anurie
B- L'existence d'un résidu post-mictionnel
C- L'impossibilité brutale et totale d'uriner
D- L'émission d'une quantité énorme d'urine
E- L'émission fréquente d'urine

49. Un signe fondamental est recherché à l'examen de ce patient : lequel ?

A- L'hyperthermie
B- Le météorisme vésical
C- Le globe vésical flaccide
D- Les gros reins distendus
E- La douleur pelvienne

50. Quel est le besoin fondamental prioritaire non satisfait chez ce malade?

A- Dormir et se reposer
B- Eliminer les déchets métaboliques
C- Manger et boire
D- s'occuper en vue de se rendre utile
E- Être propre, soigné et protéger ses téguments et phanères
F- communiquer

51. Quels sont les signes fonctionnels permettant de justifier ce besoin fondamental prioritaire ? (Trois réponses)

A- Impossibilité d'uriner
B- Douleur sus-pubienne
C- Besoins impérieux d'uriner
D- Masse hypogastrique
E- Douleur à la palpation
F- Matité à la percussion

SUJET N°8 : BRULÛRES

Q.C.D.

1. La peau n'est pas l'organe le plus volumineux du corps A / B
2. La brûlure peut entrainer une anurie A / B
3. Les brûlures provoquées par rayonnement sont plus graves que celles faites par contact A / B
4. Dypuytren a décrit selon la profondeur six degrés de brûlure A / B
5. le 4ème degré d'après la description de Dypuytren est la brûlure des aponévroses A / B
6. le 5ème degré dans la classification de Dypuytren est l'atteinte des muscles A / B
7. le 6ème degré selon Dypuytren est la lésion des os A / B
8. La brûlure du 1ér degré n'a pas besoin de traitement pour guérir A / B
9. Le soleil ne peut pas provoquer une brûlure A / B
10. Seul le feu peut provoquer une brûlure A / B
11. Les brûlures profondes ou étendues, ainsi que les brûlures électriques ou chimiques, nécessitent des soins médicaux immédiats, généralement dans tous les services de santé A / B
12. Les personnes souffrant de brûlures par inhalation doivent être conduites aussi vite que possible à l'hôpital, même si, à l'origine, elles n'ont pas de troubles respiratoires A / B

Q.C.M.

13. La peau qui est l'organe le plus volumineux du corps assure trois (03) fonctions primordiales. Lesquelles parmi celles qui sont énumérées en dessous ?

A- Régulation de la température corporelle
B- Prévient l'évaporation des liquides organiques
C- Joue un rôle de barrière contre les infections
D- fournit l'énergie à l'organisme
E- épuration du sang
F- synthétise les oligoéléments de l'organisme

14. Quels sont les agents qui peuvent causer une brûlure parmi ceux-ci proposés en dessous ? (Quatre réponses)

A- Chimique
B- Contondant
C- Electrique
D- Physique
E- Thermique
F- Tranchant

15. On dénombre deux (02) types de brûlure. Lesquels?

A- Les brûlures par contact
C- Les brûlures par scarification

B- Les brûlures par rayonnement D- La dépigmentation

16. Quels sont les agents vulnérants pouvant créer des brûlures par contact ? (Quatre réponses)

A- les corps solides portés à haute température D- l'atteinte directe par les flammes
B- les liquides chauds E- Les pommades éclaircissantes
C- les corps gazeux

17. Quels sont les facteurs de gravité d'une brûlure ? (Quatre réponses))

A- la surface corporelle brulée de la victime D- le terrain de la victime
B- la profondeur de la brûlure E- le poids de la victime
C- la localisation de la brûlure F- la taille de la victime

18. Les dommages cutanés provoqués par une brûlure peuvent être mineurs ou constituer une urgence qui menace la vie selon trois (03) critères. Lesquels parmi ceux qui sont énumérés en dessous ?

A- l'intensité de la chaleur C- la durée de l'exposition E- le moment
B- la surface de la peau affectée D- le lieu F- la circonstance

19. Indiquez les personnes chez lesquelles les brûlures sont graves parmi celles-ci. (Quatre réponses)

A- l'insuffisant rénal C- le diabétique E- l'hypertendu
B- le malade cardiaque D- la femme enceinte F- l'adulte jeune sans tare

20. la formule de remplissage J1 Q = poids (kg) x 4 x SCB est de qui ? :

A- BAUX B- BAXTER C- EVANS

21. La formule d'évaluation du pronostic vital d'une victime de brûlure suivante : ÂGE + SCB + TARE est de qui ? A- Baxter B- Baux C- Evans

22. Le pronostic vital d'un brûlé se fait avec :

A- La règle d'Evans B- La loi de Baux C- La règle de Baxter

23. Plus la valeur de l'indice du pronostic vital n'est basse:

A- La victime a la chance de survivre
B- La victime a peu de chance de survivre
C- La mort est imminente

24. S'agissant des brûlures, l'atteinte de l'aponévrose, selon la classification de Dypuytren des brûlures, correspond au

A. 2ème degré B. 3ème degré C. 4ème degré D. 5ème degré E. 6ème degré

25.. S'agissant des brûlures, l'atteinte du tissu osseux, selon la classification de Dypuytren des brûlures, correspond au

A. 2ème degré B. 3ème degré C. 4ème degré D. 5ème degré E. 6ème degré

26. La formule: Poids (Kg) x4x SCB, utilisée dans la réanimation hydro électrolytique des brûlés est de

A. BROWDER. C. DYPUYTREN E. WALLACE
B. BAXTER D. LUND F. EVANS

27. Un brûlé à 30% reçoit 9 720 ml de soluté en deux (2) jours, son poids est

A. 45 kg B. 50 C. 54 kg D. 55 kg E. 60 kg

28. Un brûlé pesant 80 kg reçoit 7200 ml de soluté le deuxième jour de réanimation hydro électrolytique, sa surface corporelle brûlée est

A. 40 % B. 45 % C. 50 % D. 55 %

29. La brûlure est considérée grave lorsqu'elle est supérieure à (deux réponses)

A. 5 % chez l'enfant C. 10 % chez l'enfant E. 15 % chez l'adulte
B. 10 % chez l'adulte D. 15 % chez l'enfant F. 20 % chez l'adulte

30. Dans les brûlures, la survenue éventuelle d'un choc hypovolémique est liée à

A. L'hémorragie causée par la brûlure C. La plasmorragie causée par la brûlure
B. La diarrhée causée par la brûlure D. La transpiration causée par la brûlure

CAS CLINIQUE

Vous êtes IDE nouvellement affecté au CHR de BEOUMI en chirurgie. Vous recevez M.DOSSO T. 25 ans, en provenance d'ADAMADOUGOU, village de la sous-préfecture. Il pèse 58 kg et mesure 1m75. Il est reçu pour

brûlure suite à un incendie de sa case. Après un examen somatique complet, le chirurgien de garde relève ces faits : - Destruction de l'épiderme - N'atteint pas la couche basale de Malpighi - Apparition de phlyctènes - La brûlure couvre la tête, le cou, la moitié du dos et tout le membre supérieur gauche - Des douleurs de la ceinture pelvienne accompagnées d'oligurie - Pouls ralenti - Respiration lente - TA = 8/5 cm Hg - T° = 37,5°C - Le taux de l'hémoglobine à son arrivée est à 5g/dl - Il note une absence de tare préexistante

31. Déterminez selon la table de LUND et BROWDER la surface corporelle brûlée

A- 22% B = 24% C = 27% D = 36%

32. Enoncez la loi de l'indice de brûlure selon BAUX

A- Poids (kg) X %SCB X Âge (ans) B= %SCB + ÂGE + TARE C= %SCB + ÂGE + RB

33. Quel est l'indice de brûlure selon la loi de BAUX ?

A- 45 B= 49 C= 54 D= 94

34. Emettre un pronostic en rapport avec la brûlure de M.DOSSO

A- N'a pas de chance de survivre B- A une chance sur deux de guérir C- A toutes les chances de guérir

35. Quel est le degré de brûlure selon la classification des 6 de Dypuytren ?

A- 1ér degré B- 2ème degré superficiel C- 2ème degré profond D- 3ème degré

36. Calculer selon la règle de BAXTER, dans le traitement du choc de M. DOSSO, la quantité de solutés à lui perfuser dans les 24 premières heures de son arrivée.

A- 2784 ml B- 4784 ml C- 5568 ml D- 5800 ml

37. Quelle est la quantité à lui administrée le 2ème jour

A- 2784 ml B- 2900 ml C- 4 784 ml D- 5800 ml

38. Déterminez le débit de la perfusion le 1ér jour D1

A- 80 gouttes/min B= 81 gouttes /min C= 82 gouttes/min

39. Déterminez le débit de la perfusion le 2ème jour

A- 39 gouttes/min B- 40 gouttes/min C- 42 gouttes/min

40. Quels sont les éléments de la surveillance infirmière de DOSSO ? 3 réponses

A- GE/Frottis C- pression artérielle E- ECBU

B- NFS/VS D- fréquence respiratoire F- pouls

41. Combien de temps, faut-il chez un brûlé en cours de traitement avant toute alimentation orale ?

A- 24 heures B- 48 heures C- 72 heures

42. Quel est son groupe sanguin/rhésus sachant que selon la méthode de BETH VINCENT, les sérums tests α, β, α+β et anti D agglutinent son sang.

A- A positif B- B positif C- AB positif D- O positif

43. Calculer la quantité de sang total nécessaire à M.DOSSO si on désire ramener son taux d'hémoglobine à 10g/dl. A- 580 ml B- 870 ml C- 1160 ml D- 1740 ml

44. Calculer le nombre de poches de sang sachant que le CNTS ne dispose que des poches de 450 cc.

A- 3 poches B- 4 poches C- 5 poches D- 6 poches

45. Déterminer le débit d'une poche devant passer en 2 heures et quart.

A- 45 gouttes/min B- 50 gouttes/min C- 55 gouttes/min

SUJET N°9 : FRACTURE N°1

Q.C.D.

1. On appelle fracture, la rupture de la continuité d'un os A / B
2. La fracture pathologique survient à la suite d'un traumatisme important A / B
3. La fracture à étage est une fracture où le trait est triple et délimite un 3ème fragment parallèle entre eux A / B
4. La fracture comminutive est une fracture où l'os s'est fracturé en un seul endroit A / B
5. La fracture incomplète avec flexion se rencontre chez l'enfant A / B
6. La fracture incomplète est encore appelée fracture « en bois vert » A / B
7. La radiographie est le seul examen permettant de confirmer la fracture A / B

8. La peau est intacte dans une fracture fermée A / B
9. La fracture ouverte est une fracture dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie même minime des parties molles A / B
10. La réduction consiste à remettre les fragments osseux dans leur rapport anatomique A / B
11. L'ostéosynthèse consiste à un assemblage des fragments osseux d'une fracture à l'aide de matériel métallique
12. La réduction se fait sous contrôle radiologique A / B
13. La contention se fait à l'aide d'un appareil plâtré A / B
14. La contention consiste à maintenir les fragments osseux dans leurs rapports normaux jusqu'à consolidation A/B
15. L'alimentation est très importante pour la consolidation d'un os fracturé A / B
16. Les fractures du poignet sont appelées la fracture de « Pouteau-Colles » A / B
17. On parle de « Volet costal » lorsqu'on constate sur une même côte l'existence de deux (02) traits de fracture qui isolent un fragment intermédiaire, mobile et indépendant du reste de la cage thoracique A / B
18. Le volet costal siège uniquement sur le thorax A / B
19. La rupture du diaphragme entraîne une détresse respiratoire aigüe mortelle A / B
20. Le diaphragme est un muscle strié qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale A / B
21. On peut avoir plusieurs volets costaux sur plusieurs côtes A / B
22. Lors d'une fracture, on peut observer un déplacement de fragment osseux A / B
23. La fracture de Pouteau Colles se rencontre plus chez les adolescents que chez les vieux A / B

QCM

24. Quels sont les deux (02) éléments qui ne font pas partie des buts du traitement de la fracture de la rotule

A- Immobilisation (genouillère plâtrée en extension) D- chirurgie par ostéosynthèse
B- Réduction anatomique E- Récupération de la fonction du genou
C- Contention solide

25.La liste ci-dessous contient les mécanismes de survenu d'une fracture, lesquels? 2 réponses

A- Choc indirect C- Choc transversal E- Choc pathologique
B- Choc tangentiel D- Choc par carence F- Choc direct

26. Un patient victime d'une fracture présente toujours (deux réponses)

G- Une crépitation osseuse J- Une déformation
H- Une mobilité des fragments osseux K- Une douleur vive
I- Une hémorragie interne ou externe L- Une impotence fonctionnelle

27. En cas de fracture, la recherche clinique de deux signes est à proscrire, lesquels?

M- Une douleur vive O- Une impotence fonctionnelle Q- Une hémorragie interne ou externe
N- Une mobilité des fragments P- Une crépitation

28. L'épanchement séreux de Morel Lavallec et le décollement cutané sont causés par l'un des mécanismes traumatiques ci-dessous

R- Choc direct S- Choc indirect T- Choc tangentiel

29. La fracture « en bois vert » se caractérise par

U- Un trait de fracture simple avec flexion W- Une rupture incomplète sans flexion
V- Un trait de fracture double avec flexion X- Une rupture incomplète avec flexion

30. La fracture à étage est une fracture qui présente

Y- Une fracture avec chevauchement A- Un trait de fracture simple
Z- Un trait de fracture double B- De nombreux fragments osseux

31. Le chevauchement des fragments osseux dans une fracture est un déplacement

C- Angulaire D- Longitudinal E- Rotatoire F- Transversal

32. La fracture de Pouteau Colle est une

G- Fracture de la partie proximale du radius I- Fracture de la partie distale du radius
H- Fracture de la partie distale du cubitus J- Fracture de la partie proximale du cubitus

33. La liste ci-dessous contient le risque majeur à redouter lors d'une fracture ouverte ; lequel?

K- L'infection M- Les lésions vasculo-nerveuses
L- La lésion des parties molles N- Le déplacement des fragments osseux

34. La consolidation d'une fracture normalement traitée se fait par la formation

O- D'un cal vicieux Q- D'une ankylose

P- D'une pseudarthrose R- D'un cal osseux

35. La liste ci-dessous contient deux complications secondaires de fractures ; Lesquelles?

S- Ankylose U- Atrophie musculaire W- Retard de consolidation

T- Pseudarthrose V- Etat de choc traumatique

36. Le protocole de prise en charge d'une fracture comprend les étapes suivantes (trois éléments de réponses)

X- Réduction Z- Rééducation B- Parage

Y- Contention A- Ostéosynthèse C- Enclouage

37. Les interventions infirmières ci-dessous sont communes dans la prise en charge des fractures fermées et ouvertes: 2 réponses

D- Poser un garrot à la racine du membre.

E- Pas de manœuvres ou de mobilisations intempestives

F- Faire un pansement stérile et compressif

G- Immobiliser les articulations sus et sous-jacentes

H- Faire un examen clinique complet

38. Le mouvement de pronosupination caractéristique de la fracture des deux (2) os de l'avant-bras s'observe par les descriptions suivantes

A. La tête cubitale tourne sur place au niveau de l'articulation radio-cubitale supérieure

B. La tête radiale tourne sur place au niveau de l'articulation radio-cubitale supérieure

C. L'extrémité inférieure du radius tourne autour de la tête du cubitus au niveau de l'articulation radio-cubitale inférieure

D. La tête radiale tourne sur le pouce au niveau de l'articulation radio-cubitale supérieure

E. L'extrémité inférieure de l'humérus tourne autour de la tête du cubitus au niveau de l'articulation radio-cubitale inférieure

F. L'extrémité inférieure du cubitus tourne autour de la tête du radius au niveau de l'articulation radio-cubitale inférieure

39. La fracture de Pouteau Colle est fréquente chez

A. Les adolescents C. Les personnes âgées

B. Les enfants déshydratés D. Les nourrissons

40. Dans les fractures, l'un des déplacements des déplacements ci-dessous entraine un raccourcissement

A. Mouvement de rotation B. Mouvement de chevauchement C. Mouvement de translation

41. La liste ci-dessous contient des complications secondaires de la fracture de Pouteau Colle ; lesquelles: 2 réponses

A. Ouverture du foyer de fracture D. Déplacement secondaire sous plâtre

B. Lésions nerveuses E. Cals vicieux

C. Syndrome de Wolskmann F. Troubles trophiques

42. Les fractures transversales sont sujettes aux déplacements suivants sauf un ; lequel ?

A. Angulation C. Arrachement E. Chevauchement

B. Rotation D. Translation

43. La fracture de Pouteau Colles est une fracture du poignet due à un mouvement (deux réponses)

A. D'hyper-rotation C. De supination forcée E. De chevauchement

B. D'hyperextension D. D'hyperflexion F. De pronation forcée

44. Dans la fracture du carpe, l'un des os ci-dessous est le plus concerné

A. Epiphyse radiale C. Scaphoïde

B. Trapézoïde D. Epiphyse cubitale

45. Les fractures ci-dessous sont les variétés des fractures partielles du bassin ; lesquelles ? (Trois réponses)

A. Fractures de l'ilion C. Fractures de l'ischion E. Fractures du sacrum et du coccyx

B. Fractures de l'iléon D. Fractures du pénis F. Fractures du condyle

46. La liste ci-dessous comprend deux (2) fractures du poignet ; lesquelles ?

A. Fracture de Pouteau-Colles
B. Fracture du trapézoïde
C. Fracture du scaphoïde
D. Fracture de l'épiphyse radiale
E. Fracture de l'épiphyse cubitale
F. Fracture de l'épiphyse humérale

47. La liste ci-dessous est celle des gestes d'urgence de l'infirmier en cas de fracture ouverte hémorragique sur le lieu de l'accident 3 réponses

A. Préparation psychologique rapide
B. Pansement compressif
C. Clamper les vaisseaux
D. Immobilisation du membre
E. Perfuser abondamment
F. Faire une antibiothérapie large

48. Les soins ci-dessous sont des éléments de la prévention des escarres chez l'opéré alité 3 réponses

A. Lever précoce
B. Changement de position
C. Soins d'hygiène
D. Réfection de lit non occupé
E. Préparation du champ opératoire
F. Diète alimentaire

49. La liste ci-dessous est celle des éléments de la classification des traumatismes du bassin excepté deux (2)

A. Les fractures partielles du bassin
B. Les fractures de la ceinture scapulaire
C. Les fractures de la ceinture pelvienne
D. Les fractures du cotyle
E. Les disjonctions symphysaires
F. Les ruptures urétrales

50. Les mécanismes ci-dessous sont à la base des fractures du cotyle ; lesquels ? 2 réponses

A. Choc du tableau de bord avec hanche fléchie
B. Chute d'un lieu élevé avec réception par le pied
C. Chute de sa hauteur
D. Compression abdominale brusque par AVP
E. Traumatisme par cisaillement du bassin
F. Immobilisation thérapeutique en milieu hospitalier

51. Les signes ci-dessous présagent une hémorragie interne chez un traumatisé physique (trois réponses)

A. Extrémités froides
B. Abdomen tendu et mat
C. Tension artérielle effondrée
D. Céphalées pulsatiles
E. Hyperthermie intermittente
F. Insomnie diurne

SUJET N°10 : FRACTURE N°2

QCD

1. La fracture en bois vert se manifeste cliniquement par un raccourcissement du membre fracturé A / B
2. Dans la fracture de la diaphyse fémorale, l'impotence fonctionnelle est absolue A / B
3. Dans la fracture, le déplacement des fragments osseux en translation est décalage en rotation A / B
4. Le syndrome de wolkmann est une ischémie suivie de nécrose A / B
5. Le syndrome algodystrophique fait partie des complications secondaires de la fracture de Pouteau Colle A / B
6. Dans la fracture de la diaphyse fémorale, le mouvement actif est légèrement perturbé A / B
7. La fracture de Pouteau Colle est une fracture de l'extrémité proximale du radius par hyperflexion A / B
8. La fracture du col du fémur est très fréquente chez les personnes âgées surtout les femmes A / B
9. La fracture du col du fémur concerne l'extrémité distale A / B
10. Les déplacements le plus souvent associés à la fracture de la diaphyse fémorale concernent le segment distal
11. Le blocage des articulations sus et sous-jacentes dans le cadre d'immobilisation d'un membre fracturé est un acte strictement réservé au médecin A / B
12. La fracture de Pouteau Colle est une fracture de l'extrémité distale du radius par hyperextension A / B
13. La fracture du col du fémur ne survient que chez les femmes âgées A / B
14. Le traitement de la fracture du 1/3 moyen de la diaphyse fémorale est essentiellement orthopédique A / B
15. Dans la fracture de la diaphyse fémorale, l'impotence fonctionnelle est relative A / B
16. L'hydrarthrose du genou est une complication secondaire de la fracture des deux os de la jambe A / B
17. La mobilité passive constatée lors d'une fracture est un mouvement volontaire du patient A / B
18. Les déplacements le plus souvent associés à la fracture de la diaphyse fémorale concernent le segment proximal
19. La fracture du col du fémur est très fréquente chez les adolescents A / B
20. La fracture du col du fémur concerne l'extrémité proximale A / B
21. L'immobilisation d'un membre fracturé consiste à bloquer les articulations sus et sous-jacentes A / B
22. L'embolie pulmonaire constitue l'une des complications secondaires des fractures des deux os de la jambe A /B
23. L'hydrarthrose du genou est un signe fonctionnel de la fracture de la diaphyse fémorale A / B

24. Dans les traumatismes du bassin, la ceinture scapulaire est concernée A / B

Q.C.M.

25. Quels sont les signes qui ne sont pas fonctionnels de la fracture parmi ceux-ci ? (Trois réponses)

A- douleur vive C- déformation du membre E- crépitation osseuse
B- impotence fonctionnelle D- mobilité anormale du membre atteint

26. Quels sont les signes physiques de la fracture parmi ceux-ci ? (Trois réponses)

A- douleur vive D- mobilité anormale du segment atteint
B- impotence fonctionnelle absolue ou partielle. E- crépitation osseuse des fragments osseux
C- déformation du membre

27. Quels sont les gestes à proscrire lors de l'examen clinique d'un blessé ? (Deux réponses)

A- La recherche de la mobilité C- L'agent causal E- Les lésions associées
B- La crépitation osseuse D- Les circonstances de survenue

28. Quels sont les deux types de fractures qu'on peut avoir ?

A- La fracture continue C- La fracture fermée
B- La fracture prolongée D- La fracture ouverte

29. Quelles sont les méthodes de traitement de la fracture ? (Deux réponses)

A- Le traitement par irradiation D- Le traitement orthopédique
B- Le traitement par chimiothérapie E- Le traitement sanglant ou ostéosynthèse
C- Le traitement par Imagerie par résonnance magnétique

30. Quels sont les risques majeurs à redouter en cas de fracture ouverte ? (Deux réponses)

A- La septicémie C- L'amputation E- Le retard de consolidation
B- La gangrène D- L'infection

31. Quels sont les buts visés par le traitement de la fracture ? (Deux réponses)

A- Le rétablissement anatomique de l'os C- La résection
B- Le rétablissement de la fonction du membre atteint D- L'amputation

32. Quelles sont les complications immédiates des fractures parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Quatre réponses)

A- Lésions cutanées C- Lésions nerveuses E- Cals vicieux
B- Lésions vasculaires D- Déplacements secondaires locaux

33. Parmi les complications d'une fracture énumérées en dessous, lesquelles sont secondaires ? (Trois réponses)

A- Lésions nerveuses C- Pseudarthrose E- Raideur articulaire ou ankylose
B- Retard de consolidation D- Atrophie musculaire F- Déplacement secondaire local

34. Quelles sont les complications tardives parmi celles qui sont énumérées ci-dessous ? (Trois réponses)

A- Lésions nerveuses D-Pseudarthrose G-Raideur articulaire ou ankylose
B- Lésions vasculaires E-Cal vicieux
C-Retard de consolidation F-Atrophie musculaire

35. Quelles sont les composantes du traitement orthopédique ? (Trois réponses)

A- La réduction C- La contemplation E- L'éducation
B- La contention D- L'amputation F- La rééducation

36. Le délai de consolidation d'une fracture de la clavicule est estimé à :

A- 4 semaines B- 6 semaines C- 8 semaines

37. Le délai de consolidation d'une fracture de l'humérus est estimé à :

A- 4 à 6 semaines B- 6 à 8 semaines C- 8 à 12 semaines

38. Le délai de consolidation d'une fracture des 2 os de l'avant-bras est estimé à :

A- 4 à 6 semaines B- 6 à 8 semaines C- 8 à 12 semaines D- 3 à 4 mois

39. Le délai de consolidation d'une fracture du fémur est estimé à :

A- 3 à 4 mois B- 4 à 6 mois C- 6 à 12 mois

40. Le délai de consolidation d'une fracture des 2 os de la jambe est estimé à :

A- 6 à 8 semaines B- 8 à 12 semaines C- 3 à 4 mois D- 4 à 6 mois

41. Un item ne fait pas parti des éléments constitutifs de la cage thoracique parmi ceux énumérés en dessous. Lequel ?

A- les vertèbres cervicales C- les vertèbres dorsales
B- le sternum D- les côtes

42. Quelle est la principale fonction de la cage thoracique ?

A- d'accélérer les battements des poumons C- de ralentir les battements cardiaques
B- de protéger certains organes vitaux D- de normaliser le rythme du diaphragme

43. Deux types de choc font suite aux traumatismes violents. Lesquels ?

A- choc anaphylactique C- choc opératoire E- choc septique
B- choc hypovolémique D- choc traumatique

44. Quelles sont les deux (02) complications secondaires des traumatismes du bassin parmi celles-ci ?

A- Ouverture cutanée C- Lésions du rectum E- Lésions de l'urètre
B- Thromboembolie D- Infection

45. Laquelle de ces fractures suivantes fait le diagnostic différentiel de la luxation antéro-interne de l'épaule

A- Fracture du col de l'humérus C- Fracture de la grosse tubérosité
B- Fracture du col de l'omoplate

46. Quel est le rôle de l'infirmier en cas de fracture ouverte sur les lieux de l'accident ?

A- Préparer le champ opératoire C- Faire un pansement aseptique.
B- Faire une immobilisation provisoire

47. Quels sont les symptômes parmi ceux énumérés en dessous qui évoquent le syndrome de Wolkmann ? (Quatre réponses)

A- Œdème C- Hématome E- Impotence fonctionnelle des doigts
B- Hémarthrose D- Douleurs du membre supérieur atteint F- Cyanose du membre atteint

48. En quoi consiste le nursing du malade hospitalisé ? (1 seule réponse)

A- Faire la préparation physique pour une éventuelle opération
B- Faire le prélèvement pour le bilan préopératoire
C- Faire la toilette générale et la prévention des escarres.

49. Un blessé présente plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre inférieur gauche. Ce blessé est-il selon vous ?

A- Un polytraumatisé B- Un polytraumatisé et un polyfracturé C- Un polyfracturé.

50. Quels sont les deux (02) principaux actes que comporte le traitement d'une fracture ?

A- La réduction C- La rééducation
B- La contention-immobilisation D- L'ostéosynthèse

51. La fracture du corps du radius et du cubitus sans déplacement se traite par : (choisir les deux 02 bonnes réponses)

A- Réduction manuelle D- Réduction chirurgicale
B- Rééducation E- Mise en place d'une plaque de compression avec des vis
C- Application d'un plâtre le long du bras F- Traction-suspension

52. Quel est le délai de consolidation de l'évolution favorable en cas de fracture de Pouteau-colles ?

A- 04 à 5 semaines B- 02 mois ½ à 3 mois C- 03 mois à 4 mois

CAS CLINIQUE

M. KANTE Ramadou, chauffeur, 39 ans, 87 kg pour 1m65 est adressé aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké à la suite d'un accident survenu sur l'autoroute. Il est obnubilé, avec embarrure et couvert de sang. L'examen clinique effectué par le chirurgien révèle : - Une otorragie et une rhinorragie - Une fracture fermée du fémur associée à une fracture de DUPUYTREN droit (fracture au niveau de la cheville) - Une luxation antéro-interne sous coracoïdienne de l'épaule droite

53. A quel squelette appartient le fémur ?

A- Squelette axial B- Squelette appendiculaire C- Squelette zonal

54. Définir la fracture fermée du fémur

A- Rupture de la continuité de l'os situé dans le bras

B- Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur par une plaie

C- Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie minime

55. Quels sont les signes évocateurs d'une atteinte du crâne dans le texte ? (Trois réponses)

A- Embarrure C- Obnubilation E- Couvert de sang

B- Otorragie D- Rhinorragie

56. Identifiez les signes cliniques d'une fracture parmi ceux énumérés ci-dessous ? (Trois réponses)

A- Douleur à la mobilisation du membre atteint D- Hyperthermie

B- Impotence fonctionnelle E- Obnubilation

C- Déformation du membre atteint F- Asthénie

57. Formulez sous forme de diagnostic infirmier deux problèmes prioritaires de KANTE en rapport avec sa fracture

A- Douleur liée à la fracture du fémur C- Risque de septicémie dû à la fracture

B- Impotence fonctionnelle du membre reliée à la fracture D- insomnie due à la fracture

58. Quel est le rôle de l'IDE en vue d'une intervention chirurgicale ? (Trois réponses)

A- Prise des constantes D- Vérification des examens à réaliser

B- Rasage soigneux du crâne E- Faire observer le jeûne 72 heures

C- Prescription des antalgiques F- Faire la CCC en rapport avec l'accident

SUJET N°11 : TRAUMATOLOGIE

QCD

1. Une fracture pathologique est une fracture qui survient au cours d'un traumatisme minime A / B

2. La clavicule est un os long de la partie supérieure du thorax A / B

3. La fracture de la clavicule se réduit sous anesthésie générale A / B

4. Dans les fractures ouvertes, l'os brisé traverse la peau et est apparent A / B

5. L'un des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax est d'éviter les complications A / B

6. Dans les signes de souffrance respiratoire, le sujet ne présente pas une lésion du nerf récurrent (trouble phonique) A / B

7. En cas de traumatisme du thorax, l'inspection apprécie les vibrations vocales et le choc de pointe à l'étape analytique A / B

8. L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe physique du traumatisme du bassin. A / B

9. L'état de choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature A / B

10. Le polytraumatisé est tout blessé qui a moins de deux traumatismes A / B

11. Dans le traumatisme thoracique, les lésions pariétales sont causées par le choc direct A / B

12. L'attitude de Desault est un signe fonctionnel dans les fractures de la clavicule A / B

13. La pseudarthrose est fréquente dans la consolidation des fractures claviculaires A / B

14. Une bonne consolidation d'un os fracturé nécessite une alimentation équilibrée et riche en protides A / B

15. Le sternum est un os plat qui appartient au squelette axial A / B

16. L'accroissement en longueur se fait grâce au périoste A / B

17. L'accroissement en épaisseur s'effectue grâce cartilage de conjugaison A / B

18. L'arrêt de croissance varie suivant les os et les individus entre 18 et 25 ans A / B

19. La colonne vertébrale est rectiligne A / B

20. La cyphose est une exagération d'une courbure postérieure A / B

21. La lordose est une exagération d'une courbure latérale A / B

22. La réduction orthopédique de la fracture claviculaire se fait généralement sous anesthésie générale A / B

23. La luxation de l'épaule peut être d'origine congénitale A / B
24. Il existe quatre (4) variétés topographiques de la luxation
25. de l'épaule A / B
26. L'impotence fonctionnelle est relative dans la luxation de l'épaule A / B
27. Le syndrome de Wolkmann est une ischémie liée uniquement aux moyens de contention d'une fracture A / B
28. L'humérus est un segment moyen dans le squelette du membre supérieur A / B
29. L'humérus est un segment distal dans le squelette du membre supérieur A / B
30. La fracture supracondylienne de l'humérus est une fracture en dessous du coude A / B
31. La fracture de l'olécrâne est aussi appelée fracture
32. intercondylienne A / B
33. Dans la contention d'une fracture, les moyens utilisés par l'infirmier sont provisoires A / B

QCM

34. Les os sont constitués de deux éléments chimiques. Lesquels ?

A. L'osséine B. Les sels minéraux C. L'adrénaline D. L'acétylcholine

35. Le tissu osseux peut prendre deux aspects. Lesquels ?

A. épithélial B. Compact C. Spongieux D. nerveux

36. Quels sont les deux modes de développement des os ?

A. L'ossification enchondrale **C. L'hématopoïèse**
B. L'ossification fibreuse **D.** La syndesmologie

37. Le rachis est formé par 33 pièces osseuses. Quelles sont les bonnes assertions parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Deux réponses)

A. Les cervicales au nombre de : 7 D. Les sacrales au nombre : 6
B. Les dorsales au nombre de : 10 E. Les coccygiennes au nombre : 5
C. Les lombaires au nombre : 5

38. Les côtes sont au nombre de 12 et répartis en 3 groupes. Quelles sont les bonnes affirmations parmi celles-ci ? (Trois réponses)

A. Les vraies côtes au nombre de 7 D. Les côtes flottantes au nombre de 2
B. Les fausses côtes au nombre de 3 E. Les côtes frottâtes au nombre de 12
C. Les côtes volantes au nombre de 10

39. Le médiastin comprend ; la région de la cage thoracique située entre les deux poumons. Quels sont les organes qu'il contient ? (Quatre réponses)

A. le cœur C. la trachée E. les poumons
B. l'œsophage D. les bronches

40. Quels sont les organes pouvant être atteints lors d'un traumatisme thoracique ? (Quatre réponses)

A. La rate C. Le rachis E. Le colon
B. L'œsophage D. Le cœur F. Le manubrium

41. Le mélaena et l'hématémèse se rencontrent dans l'une des lésions traumatiques ci-dessous, laquelle?

A. Lésion du nerf phrénique ou diaphragmatique C. Hémothorax
B. Lésion de l'œsophage

42. Quelles sont les indications de la conduite thérapeutique du traumatisé du thorax parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Quatre réponses)

A. Désobstruction des voies aériennes D. Oxygénothérapie par intubation
B. Vérification du caractère de l'épanchement thoracique E. Prise d'une voie veineuse
C. Position demi-assise F. Réparation des lésions

43. La liste ci-dessous contient trois formes topographiques des fractures claviculaires; Lesquelles? (Trois réponses)

A. Fracture du quart moyen C. Fracture du tiers externe E. Fracture du quart externe
B. Fracture du tiers moyen D. Fracture du quart interne F. Fracture du tiers interne

44. La liste des signes physiques ci-dessous contient deux signes à ne pas rechercher lors de la palpation d'une clavicule traumatisée; lesquels?

A. Un hématome très important
B. Un emphysème sous cutané
C. Une douleur à la palpation
D. Une crépitation osseuse
E. Bras du côté de la fracture est rigide et collé au corps
F. Une mobilité anormale

45. S'agissant des formes topographiques des fractures claviculaires ci-dessous, laquelle est sans déplacement ?

A. Fracture du tiers moyen
B. Fracture du quart interne
C. Fracture du quart moyen
D. Fracture du tiers interne
E. Fracture du tiers externe
F. Fracture du quart externe

46. S'agissant des formes topographiques des fractures claviculaires ci-dessous, laquelle est la seconde la plus fréquente ?

A. Fracture du tiers moyen
B. Fracture du quart interne
C. Fracture du quart moyen
D. Fracture du tiers interne
E. Fracture du tiers externe
F. Fracture du quart externe

47. Le bandage en huit de chiffre se fait dans la prise en charge de l'un des traumatismes ci-dessous ; lequel ?

A. Le volet costal
B. La fracture de Pouteau-colles
C. La fracture claviculaire
D. La fracture des deux de l'avant-bras

48. La fracture de Pouteau-colles est une fracture sus-articulaire de quoi ?

A. De l'extrémité supérieure du cubitus
B. De l'extrémité inférieure du radius
C. De l'extrémité inférieure du cubitus
D. De l'extrémité supérieure du radius

49. La liste des complications des fractures du cotyle ci-dessous contient trois complications tardives, lesquelles? (Trois réponses)

A. L'hématome sous-péritonéal
B. La nécrose ischémique de la tête fémorale
C. L'irréductibilité d'une luxation postérieure
D. Les paralysies sciatiques
E. La coxarthrose post-traumatique
F. Les ossifications péri-articulaires.

50. La liste ci-dessous est celle des étiologies de la luxation de l'épaule

A. Cause indéterminée
B. Cause congénitale
C. Cause pathologique
D. Cause traumatique
E. Cause nutritionnelle
F. Cause hématogène

51. Des quatre variétés de luxation de l'épaule ci-dessous, la plus fréquente est

A. Luxation postérieure de l'épaule
B. Luxation antérieure de l'épaule
C. Luxation inférieure de l'épaule
D. Luxation supérieure de l'épaule

52. Les deux avant-bras et bras totalisent

A. 3 pièces osseuses
B. 4 pièces osseuse
C. 6 pièces osseuses
D. 8 pièces osseuses

53. La ceinture scapulaire est composée comprend les os suivants

A. Deux omoplates
B. Deux clavicules
C. Le sternum
D. Deux vertèbres cervicales
E. Une vertèbre dorsale

54. La fracture de l'olécrâne est une fracture

A. Au-dessus du coude
B. En dessous du coude
C. Articulaire du coude

ETUDE DE CAS

De garde aux urgences chirurgicales de l'hôpital général de LAKOTA, vous recevez monsieur DAGO DAGOBERT 29 ans, mécanicien en détresse respiratoire.
L'interrogatoire révèle qu'il a reçu des coups de pied au thorax suite à une rixe.

55. A quel squelette appartient les côtes ? (1 réponse)

A. Le squelette appendiculaire
B. Le squelette axial
C. Le squelette zonal
D. Le squelette sésamoïde

56. S'agissant de la cage thoracique, l'une des propositions ci-dessous constitue les paires des côtes flottantes ; laquelle ?

A. 8ème paire, 9ème paire et 10ème paire de côtes
B. 5ème paire, 6ème paire et 7ème paire de côtes
C. 1ème paire, 2ème paire, 3ème paire de côtes
D. 11ème paire et 12ème paire de côtes

57. La radiographique thoracique de monsieur DAGO révèle deux traits de fracture sur une même côte avec un fragment isolé. Quel est votre diagnostic ?

A. Fractures multi costales C. Volet des côtes
B. Volet costal D. Fracture pauci-costale

58. Quels sont les organes pleins pouvant entraîner un hémopéritoine post-traumatique parmi ceux qui sont énumérés en dessous? (Deux réponses)

A. L'œsophage B. L'estomac C. Le foie

59. Qu'est-ce que la respiration paradoxale ?

A. l'inspiration entraîne l'enfoncement du volet costal et gonflement de la cage thoracique et l'expiration entraîne l'expulsion du volet costal et affaissement de la cage thoracique

B. l'inspiration entraîne l'expulsion du volet costal et affaissement de la cage thoracique et l'expiration entraîne l'absorption du volet costal et le gonflement de la cage thoracique

C. l'inspiration entraîne l'écartement du volet costal et raccourcissement de la cage thoracique et l'expiration entraîne l'explosion du volet costal et durcissement de la cage thoracique

SUJET N°12 : LUXATION/ENTORSE/PANARIS/ PHLEGMON/ SCIATALGIE

1. Les panaris siègent uniquement sur les doigts A / B
2. Le panaris peut siéger aussi sur les orteils A / B
3. Le phlegmon est une infection aigüe de l'une quelconque des parties constituantes des doigts A / B
4. On appelle phlegmon toute infection de l'un quelconque des éléments anatomiques d'un doigt A / B
5. Le phlegmon est une collection purulente des parties molles, closes dans une cavité inaccessible aux antibiotiques A / B
6. Le phlegmon est l'infection des étuis digitaux de la main par les germes pathogènes A / B
7. Les phlegmons des espaces celluleux des gaines digito-carpiennes siègent au niveau du carpe et intéressent les tissus cellulaires jusqu'au poignet A / B
8. Les phlegmons des gaines digitales moyennes sont localisés à la gaine synoviale des tendons fléchisseurs des trois doigts médians A / B
9. La sciatalgie n'est pas une maladie A / B
10. La sciatalgie ou névralgie sciatique ou encore sciatique se définit comme toute douleur dans le territoire du nerf sciatique (L5 S1). A / B
11. Le signe pathognomonique de la sciatique est la douleur A / B
12. Le trajet de la sciatalgie intéresse toutes les vertèbres lombaires A / B
13. La déviation du rachis dans la sciatique est une attitude antalgique A / B
14. Une douleur mécanique est toujours liée au mouvement A / B
15. Dans la sciatique, le « signe de la sonnette est mis en évidence par la Manœuvre de Lasègue » A / B
16. Dans les sciatalgies les douleurs résultent d'une action physique et chimique A / B
17. Les kystes méningés sont l'une des causes des sciatalgies A / B
18. L'entorse est une lésion traumatique d'une articulation produite par l'exagération des mouvements physiologiques sans déplacement des surfaces articulaires A / B
19. L'entorse se rencontre surtout au niveau des articulations mobiles A / B
20. L'entorse peut récidiver A / B
21. La luxation complète est appelée aussi une subluxation. A / B
22. Les lésions vasculo-nerveuses sont des complications primaires des fractures du fémur. A / B
23. La luxation de l'épaule est une perte de contact plus ou moins importante de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre. A / B

24. La luxation se définit comme étant

A- Une perte de contact temporaire entre deux surfaces articulaires
B- Une rupture de la continuité d'un tissu osseux

C- Un traumatisme appuyé respectant la continuité des téguments
D- Une perte de contact permanent entre deux surfaces articulaires

25. Quels sont les signes physiques de la luxation de l'épaule parmi ceux qui ont énumérés en dessous ?

A. Une vacuité de la cavité glénoïde C. Une impotence fonctionnelle E. Une laxité de l'articulation
B. Fracture de la tête humérale D. Une adduction irréductible F. Une douleur

26. L'on définit l'entorse comme étant

A- Une perte de contact permanent entre deux surfaces articulaires
B- Un traumatique fermé d'un ligament articulaire
C- Un traumatisme appuyé respectant la continuité des téguments
D- Une rupture de la continuité d'un tissu osseux

27. Les éléments du protocole de prise en charge ci-dessous concernent à la fois les fractures, les entorses et les luxations sauf un, lequel ?

A. La contention B. La réduction C. La rééducation

28. S'agissant de la physiopathologie de la sciatique, deux des mécanismes ci-dessous sont justes ; lesquels ?

A- Une irritation des racines nerveuses par tout type de vertèbres
B- Une irritation des racines du nerf sciatique par l'inflammation
C- Une irritation des racines nerveuses par des vertèbres dorsales et lombaires
D- Une irritation des racines nerveuses par des vertèbres lombaires ou sacrées
E- Une irritation des racines du nerf sciatique par l'inflammation de l'axis
F- Une irritation des racines du nerf sciatique par l'inflammation du colon

29. La liste ci-dessous contient l'étiologie la plus récurrente de la sciatique ; laquelle ?

A- Spondylodiscite B. Tumeur osseuse C. Hernie discale D. Kyste méningé

30. La liste ci-dessous comprend les moyens du traitement de la sciatalgie sauf un, lequel?

A- Moyen chirurgical C- Moyen hygiéno-diététique
B- Moyen radiologique D- Moyen médicamenteux

31. Dans l'étiologie des sciatalgies, ces propositions ci-dessous énumérées sont exactes ; sauf une, laquelle ?

A- Une spondylodiscite infectieuse C. Une hernie discale
B- Un canal lombaire agrandi

32. Parmi ces signes paracliniques, un seul permet de faire l'exploration neurologique et ostéoarticulaire complète dans les sciatalgies ; lequel ?

A- Sacro radiculographie
B- Scanner du rachis
C- Imagerie à résonnance magnétique

33. Le traitement de la sciatalgie vise à

A- Faire une intervention chirurgicale D- Lever l'irritation des racines nerveuses
B- Donner un régime alimentaire E- Calmer les agitations du patient
C- Permettre au malade de dormir F- Lutter contre la douleur

34. Dans la sciatalgie, la recherche du signe de la sonnette se fait

A- Par l'examen radiologique du rachis lombo-sacré C- A la palpation des épines des vertèbres intéressées
B- Au cours de la manœuvre de Lasègue D- Pendant l'interrogatoire du patient

35. Le crochet digital semi-fléchi est un signe physique de l'une des pathologies ci-dessous, laquelle ?

A. Le phlegmon L'abcès lymphatique
B. La lymphangite D. Le panaris péri-unguéal

36. Quelles sont les étiologies du phlegmon parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Deux réponses)

A. Le manque d'hygiène C. Les dermatoses prurigineuses E. Piqûre hyper septique
B. La macération D. Plaie contuse négligée

ETUDE DE CAS 1

M. CECONGO DOH menuisier de son état vient consulter pour douleur de la main. A l'examen, vous remarquez une tuméfaction non collectée à la pulpe de l'index droit s'étendant entre les tissus mous et l'ongle, plus spécifiquement à la face postérieure de l'ongle.

QUESTIONS

37. quel est votre diagnostic ?

A. Panaris superficiel B. Panaris profond C. Phlegmon

38. Qu'est-ce qu'un panaris ?

A. Toute infection de la main
B. Toute infection aigüe d'un doit de la main ou d'un orteil
C. Toute infection généralisée du membre supérieur

39. Quelles sont les causes d'un panaris ? (Deux réponses)

A. Toute plaie même minime négligée C. Contusion d'un doigt
B. Inoculation dans le doigt d'un germe D. Malformation du doigt de la main incriminée

40. Quels sont les signes cliniques de cette affection parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Quatre réponses)

A. Fièvre C. Insomnie E. Œdème local
B. Nausées et vomissements D. Douleur spontanée pulsatile F. Anorexie

41. Quel traitement allez-vous lui faire ? (Trois réponses)

A-Lui conseiller de plonger le membre atteint dans de l'eau javellisée pendant 15 minutes au moins
B- Mettre le doigt atteint dans un citron perforé
C- Faire un pansement alcoolisé en attente de la collection
D- Lui administrer des antibiotiques et des anti-inflammatoires
E- Lui faire une sérovaccination antitétanique
F- Procéder immédiatement à l'incision

42. Quelles sont les complications du panaris non ou mal traité ? (Trois réponses)

A. Ostéite C. Panaris hyper septique E. Amputation
B. Arthrite D. Gangrène F. Cals vicieux

ETUDE DE CAS 2

M. OUATTARA KOLO plombier dans un état agité et délirant vient consulter pour douleur de la main. A l'examen, vous remarquez une tuméfaction collectée au niveau du carpe et intéressant les tissus cellulaires jusqu'au poignet

A l'interrogatoire ; il vous signale que cela environ trois jours que la douleur devenait de plus en plus intense, vive entrainant l'insomnie

Sa température avoisine 40°C

La pression légère le long de la gaine entraine une douleur traçante et lancinante

QUESTIONS

43. Quel est votre diagnostic ?

A- Panaris superficiel C. Phlegmon
B- Panaris profond D. Phlegmon amygdalien

44. Identifiez deux (02) causes probables parmi celles qui sont énumérées ci-dessous ?

A- Les irritations répétées C. Piqûre hyper septique
B- Blessure D. Les fièvres éruptives

45. Identifiez les signes fonctionnels parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Deux réponses)

a. Douleur traçante par pression légère le long de la gaine D. Hyperthermie à 40°C
b. Insomnie E. Tuméfaction collectée
c. Agitation

46. Quelle est votre conduite à tenir ?

a. (perfusion + évacuation vers un centre plus équipé)
b. (pansement alcoolisé + antibiotique + mise en observation)
c. (incision large + pansement +ATBpie + sérovaccination + CCC)

SUJET N°13 : TRAUMATISMES CRANIENS N°1

QCD

1. Dans les traumatismes crâniens, le blessé est dans un état d'inconscience pendant l'intervalle de temps libre A / B
2. L'amnésie constitue un signe fonctionnel en cas de traumatisme crânien A / B
3.Un traumatisé crânien en phase de réanimation doit avoir une sonde vésicale à demeure A / B
4. Au cours d'un traumatisme crânien, plusieurs structures anatomiques sont sensibles d'être lésée A / B
5. La pie-mère fait partie des 3 enveloppes qui recouvrent le parenchyme Cérébral A / B
6. La notion d'intervalle libre est déterminée par la cotation de Glasgow A / B
7. Dans la cotation du score de Glasgow en cas de traumatisme crânien, le mouvement de retrait d'un membre est un élément d'appréciation du paramètre « ouverture des yeux » A / B
8. L'amnésie constitue un signe physique en cas de traumatisme crânien A / B
9. La précipitation n'est pas un geste salvateur dans la CAT auprès d'un traumatisé des voies publiques A / B
10. Au cours d'un traumatisme crânien, plusieurs structures anatomiques sont sensibles d'être lésées A / B
11. La mydriase est la dilation du diamètre de la pupille A / B
12. L'arachnoïde fait partie des 3 enveloppes qui recouvrent la moelle osseuse A / B
13. L'amnésie n'est pas un signe fonctionnel en cas de traumatisme crânien A / B
14. Dans les sciatalgies les douleurs résultent d'une action physique et chimique A / B
15. Les kystes méningés sont l'une des causes des sciatalgies A / B
16. Le nerf sciatique est le plus gros et le plus long nerf du corps humain A / B
17. Plus le score de Glasgow est élevé plus l'état du malade est grabataire A / B
18. Dans la cotation du score de Glasgow en cas de traumatisme crânien, la réponse de décortication est un élément de la réponse verbale A / B
19. La découverte d'une lordose dorsale lors de l'examen physique d'un patient traumatisé du rachis présage une lésion ostéo-articulaire A / B
20. Les fractures de la base du crâne sont considérées comme des fractures ouvertes A / B
21. Dans l'échelle de Glasgow, la réponse motrice est notée sur 4 A / B
22. Dans les sciatalgies les douleurs résultent d'une action physique seulement A / B
23. Le score de Glasgow est une échelle d'évaluation du niveau de conscience d'un patient A / B
24. Dans l'échelle de Glasgow, l'ouverture des yeux comprend 4 éléments A / B
25. La classification de Master s'applique seulement aux traumatismes crâniens bénins A / B
26. Le plus grand score de Glasgow est supérieur ou égale à 15 A / B
27. Dans l'échelle de Glasgow, la réponse verbale comprend 5 éléments A / B
28. L'attitude de décérébration est une rigidité des membres en extension dans le traumatisme crânien A / B
29. Dans l'échelle de Glasgow, l'ouverture des yeux est notée sur 6 A / B
30. La classification de Master s'applique à tous les traumatismes crâniens A / B
31. L'échelle de Glasgow est également appelée le score de Glasgow A / B
32. Dans l'échelle de Glasgow, la réponse verbale est notée sur 5 A / B
33. Le score de Glasgow est le même que le score d'Apgar A / B
34.Le score d'Apgar remplace souvent le score de Glasgow A / B
35. Dans l'échelle de Glasgow, la réponse motrice comprend 6 éléments A / B
36. Les traumatismes crâniens graves et modérés nécessitent une réanimation A / B
37. L'intervalle libre précédente toujours la perte de connaissance initiale (PCI) dans les traumatismes crâniens A/B
38. Le plus petit de l'échelle de Glasgow est zéro (0) A / B
39. Des trois couches recouvrant le parenchyme cérébral, la première couche de dehors en dedans est la pie mère

40. Master classe les traumatismes crâniens bénins en quatre (4) groupes A / B

41. L'échelle de Glasgow utilise trois critères ou paramètres d'appréciation A / B

42. Les attitudes de décortication et de décérébration sont des éléments de la réponse verbale A / B

QCM

43. Les pathologies ci-dessous sont des causes d'une sciatique, sauf deux ; lesquelles ?

A- Kystes méningés c. Mal de Pott e. Tumeurs osseuses

b. Lymphangite d. Lipome

44. Parmi les propositions ci-dessous, quelle est celle qu'il ne faut pas faire chez les traumatisés du crâne ?

Apprécier l'état de conscience c. Rechercher les signes méningés (céphalées, raideurs de la nuque)

b. Apprécier les fonctions vitales d. Faire une ponction de l'hématome

e. Rechercher une mydriase.

45. Le score de Glasgow permet d'évaluer l'état de conscience et de suivre son évolution à partir des trois éléments énumérés ci-dessous sauf un : lequel ?

A- Ouverture des yeux c. L'ouverture des yeux aux stimulations verbales

b. La capacité à déglutir d. L'appréciation de la réponse motrice à la parole et/ou à la douleur.

46. Deux des paramètres d'analyse de l'échelle de Glasgow associés sont notés sur dix (10) ; excepté un : Lequel ? A. Réponse motrice B. Ouverture des yeux C. Réponse verbale

47. Les éléments ci-dessous sont exacts sauf un, permettant d'identifier l'étiologie des sciatalgies. Lequel ?

A- Une spondylodiscite infectieuse c. Une hernie discale

b. Une tumeur osseuse d. Un canal lombaire agrandi.

48. Pour soulever un traumatisé du rachis avec le maximum de sécurité, il faut pratiquer les gestes ci-dessous, sauf un

A- Maintenir solidement et prudemment la tête en arrière c. Fléchir la tête

b. Tirer sur les chevilles d. Saisir le corps sous le tronc et sous les cuisses

49. Parmi les hémorragies cérébroméningées ci-dessous énumérées, lesquelles sont des complications de la fracture du crâne ? (Trois réponses)

A- Hématome extradural c. Hémorragie intradurale e. Hématome sous dural

b. Engagement cérébral d. Engagement cérébelleux

50. Parmi les symptômes ci-dessous, quels sont ceux d'un traumatisé de la base du crâne ? (Quatre réponses)

A- Paralysie faciale c. Otorragie e. Rhinorrhée

b. Trouble de l'équilibre d. Trouble de l'audition f. Délires

51. Parmi ces signes émanant du score de Glasgow, lesquels appartiennent à la meilleure réponse verbale ? (Deux réponses) A- Orientée C. inappropriée E. aucune

B. confuse D. incompréhensible

52. Parmi ces signes paracliniques, un seul permet de faire l'exploration neurologique et ostéoarticulaire complète dans la sciatalgie ; lequel ?

A- Sacro radiculographie C. Imagerie à résonnance magnétique (IRM)

B. Scanner du rachis

53. Dans le traumatisme crânien, la sonde d'aspiration gastrique vise à

A- Prévenir le syndrome de Mendelssohn C. Assurer un gavage du patient

B. Une déshydratation du patient D. Assurer une diète hydrique et alimentaire

54. Les éléments de surveillance post opératoire ci-dessous relèvent de l'état végétatif du patient, excepté un : Lequel ?

A- La respiration B. Le pouls C. La conscience D. La pression artérielle

55. Chez le traumatisé crânien en état de réanimation, les pertes hydriques sont quantifiées grâce. 2 réponses

A la sonde d'aspiration gastrique D. Au contrôle régulier de la TA

B. Au suivi de la diurèse E. A la prise régulière du pouls

C. Au suivi de l'apport d'eau de boisson

56. La liste ci-dessous contient des lésions traumatiques qui relèvent exclusivement du traumatisme crânien ; lesquelles ? 3 réponses

A- Scalpes pédiculés C. Hématome E. Fracture de l'Atlas
B. Embarrure D. Volet costal F. Fracture du rocher

57. La liste ci-dessous est celle des paramètres utilisés par l'échelle de Glasgow ; lesquels ? 3 réponses

A- Coloration de la peau C. Réponse verbale E. Réponse motrice
B. Ouverture des yeux D. Mouvement des yeux F. Sensibilité

58. DN, traumatisé crânien fléchit les membres supérieurs sur sa poitrine les poings fermés et les jambes tendues. DN présente une posture

A- D'embarrure C. De décérébration
B. De décortication D. De décélération

59. La classification de MASTER s'applique à un des groupes de traumatisme crânien suivant ; lequel ?

A- Traumatisme crânien bénin C. Traumatisme crânien grave
B. Traumatisme crânien modéré

60. Dans les fractures rachidiennes, les lésions articulaires proviennent de l'un des mécanismes ci-dessous

A. Distraction en extension ou flexion C. Rotation du rachis
B. Compression du corps vertébral

61. Dans la liste des vertèbres cervicales ci-dessous, l'axis correspond à

A. C1 B. C2 C. C3 D. C4

62. Le rachis cervical supérieur est composé du nombre de vertèbres suivant

A- 1 B. 2 C. 3 D. 4

63. Le rachis cervical inférieur est composé du nombre de vertèbres suivant

A- 4 B. 5 C. 6 D. 7

64. Dans les fractures rachidiennes, les changements de positions utilisées sont 2 réponses

A- Le décubitus latéral droit C. Le décubitus ventral E. La position de Trendelenburg
B. Le décubitus latéral gauche D. Le décubitus dorsal F. La position assise

65. Dans la prévention des escarres chez le paraplégique, les membres inférieurs doivent être en

A- Flexion légère B. Adduction légère C. Abduction légère

66. Dans la prévention des complications de décubitus chez le traumatisé du rachis tétraplégique, l'infirmier fait également au patient des mouvements

A- Passifs B. Actifs C. Passifs et actifs

67. L'immobilisation d'un rachis traumatisé doit respecter l'axe comprenant les éléments suivants : 3 réponses A- bras B. cuisses C. fesses D. tronc E. cou F. tête

68. La liste ci-dessous contient les rôles du disque intervertébral ; lesquels ? 2 réponses

A- Assurer la mobilité du rachis D. Assurer l'élimination du LCR
B. Amortir les charges et les chocs E. Produire en partie le LCR
C. Assurer la solidité du rachis

69. Dans la cotation du score de Glasgow la décortication est cotée à

A- 6 B- 5 C- 4 D- 3

70. Dans la cotation du score de Glasgow la décérébration est cotée à

A- 5 B- 4 C- 3 D- 2

71. Dans la cotation du score de Glasgow l'incohérence verbale est cotée à

A- 5 C- 4 D- 3 E- 2

SUJET N°14 : TRAUMATISMES CRANIENS N°2

QCD

1. DZ est reçu en position d'opisthotonos aux urgences de chirurgie pour traumatisme crânien. DZ développe un tétanos en phase d'état A / B

2. Dans les traumatismes crâniens, la présence de PCI est un signe de gravité A / B
3. La perte de connaissance initiale (PCI) désigne une rupture momentanée de la vie végétative A / B
4. La base du traitement des traumatisme crâniens est uniquement chirurgicale A / B
5. Le glucosé à 5 % fait partie des soluté hypertoniques utilisés dans la réanimation du traumatisé crânien A / B
6. L'on a parfois recours à la trachéotomie dans les traumatismes crâniens graves A / B
7. La douleur de la fracture du rachis est ressentie grâce à la sensibilité proprioceptive A / B
8. Un déplacement monobloc est un déplacement en chaise roulante A / B
9. Pendant l'intervalle libre, le traumatisé crânien ne souffre d'aucun signe A / B
10. Le plus petit score de Glasgow est chiffré à 1 A / B
11. Dans l'échelle de Glasgow, la décortication et l'incohérence verbale appartiennent au même paramètre d'appréciation A / B
12. La perte de connaissance initiale (PCI) dans le traumatisme crânien est toujours un signe de gravité A / B
13. Une fracture rachidienne peut être comminutive A / B
14. Une fracture l'axis est une fracture rachidienne A / B
15. Le drainage en va et vient se fait avec une sonde à deux voies A / B
16. Chez l'opéré du rachis, le drainage en va et vient est conseillé A / B
17. La purgation est conseillée chez l'opéré du rachis A / B
18. La tétraplégie est une paralysie de l'hémicorps A / B
19. Le décubitus ventral est position déconseillée dans l'installation d'un traumatisé du rachis A / B
20. Pour l'infirmier, la réfection de lit non occupé et les soins de siège font partie des exigences pour un patient en immobilisation prolongée A / B
21. De face, le rachis est rectiligne A / B
22. La hernie discale est la principale cause des sciatalgies A / B
23. Une lordose lombaire lors de l'examen physique d'un patient traumatisé du rachis est synonyme une lésion ostéoarticulaire lombaire A / B
24. Le rachis lombaire est composé de 7 vertèbres A / B
25. La neurologie est la discipline médicale qui prend en charge les maladies du système nerveux A / B
26. La subluxation est considérée comme une luxation incomplète A / B
27. L'une des étiologies du traumatisme du thorax est l'accident de sport A / B
28. La luxation de l'épaule est une perte de contact plus ou moins importante de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre A / B
29. Les lésions vasculo-nerveuses sont complications primaires des fractures du membre inférieur A / B
30. Éviter les complications fait partie des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax A / B
31. En cas de traumatisme du thorax, l'inspection apprécie aussi la déformation du thorax dans l'étape analytique
32. En cas de fracture isolée ou étagée de côte à l'étape synthétique chez le traumatisé du thorax, on note une douleur à l'inspiration profonde A / B
33. Le mal de pott est une infection disco-vertébrale due au bacille de KOCH. A / B
34. Le polytraumatisé est tout malade ayant moins de deux traumatismes. A / B
35. La ceinture pelvienne est un élément du squelette appendiculaire A / B
36. La traumatologie est la science qui étudie les accidents du squelette axial et appendiculaire A / B
37. Les fractures de l'enfant sont dites fractures en « bois vert ». A / B
38. L'atteinte du nerf sciatique et l'hématome sont deux complications immédiates des fractures du fémur A / B
39. Les 02 complications secondaires des fractures du fémur constituent l'amyotrophie du quadriceps et la raideur du genou A / B
40. Le choc est une incapacité de l'appareil circulatoire à assurer le flux sanguin et donc l'apport d'oxygène A / B nécessaire aux différents tissus de l'organisme A / B
41. Dans les traumatismes du rachis, les radiographies standards révèlent toujours les différentes lésions traumatiques A / B
42. Un déplacement monobloc est un déplacement qui maintient l'axe cranio-rachidien en rectitude A / B
43. Le traumatisme du rachis peut entrainer une atteinte du sphincter vésical et anal A / B

QCM

44. Le parenchyme cérébral est recouvert par trois enveloppes. Lesquelles ?

A- L'arachnoïde C- La pie mère E- La dure mère
B- La vielle-mère D- L'arachide F- L'arcade

45. La liste ci-dessous contient la principale cause des traumatismes cranio-encéphaliques, laquelle ?

A- Accident de sport C- Traumatisme balistique
B- Accident de travail D- Accident de la voie publique

46. La notion d'intervalle de temps libre chez le traumatisé crânien se rapporte

A- Au temps qui s'écoule entre la survenue de l'accident et la prise en charge du patient
B- Au temps qui sépare la perte de connaissance initiale et la réapparition des troubles de la conscience
C- A la durée des troubles de la conscience occasionnée par le traumatisme crânien
D- A la durée de la mise en observation du patient

47. Quels sont les éléments ci-dessous qui font partie des signes physiques du traumatisme crânien ? 2 réponses

A- La cotation de Glasgow D- L'hématome
B- La perte de connaissance initiale E- Le coma d'emblée
C- L'amnésie F- Les maux de tête persistants

48. Les éléments d'appréciation du score de Glasgow ci-dessous, appartiennent à la meilleure réponse verbale au cours de l'examen neurologique ; lesquels ?

A- Volontaire, sur commande 6 C- Aucune 1
B- Adaptée orientée à la douleur 4 D- En extension (décérébration) 3

49. S'agissant de l'échelle de Glasgow, le critère de la « réponse motrice » est noté sur

A- 6 B- 5 C- 4 D- 3

50. S'agissant de l'échelle de Glasgow, le critère la « réponse verbale » est noté sur

A- 6 B- 5 C- 4 D- 3

51. Un traumatisé de la voie publique qui ouvre les yeux à la douleur, émet des mots qui ne sont incompréhensibles et fait une flexion des bras à la douleur de manière anormale, présente comme score de Glasgow

A- 8 B = 9

52. La décortication et la décérébration sont des éléments de l'un des critères suivants de l'échelle de Glasgow ; lequel ?

A- La réponse verbale B- La réponse motrice C- L'ouverture des yeux

53. S'agissant du traumatisme crânien, l'embarrure est

A- Une hémorragie intra méningée C- Un hématome du cuir chevelu
B- Un bombement de la boite crânienne D- Un enfoncement de la boite crânienne

54. S'agissant de l'assistance ventilatoire du patient, l'un des soins ci-dessous est prioritaire sur les autres; lequel ?

A- La trachéotomie C- La désobstruction trachéobronchique
B- L'intubation trachéale d'urgence D- L'oxygénothérapie d'urgence

55. La liste ci-dessous contient deux soins préopératoires chez le traumatisé crânien ; lesquels ?

A- Rasage soigneux de la zone d'intervention du cuir chevelu
B- Rasage soigneux de la totalité du cuir chevelu
C- Rasage soigneux de toutes les zones de pilosité
D- Mise en place d'une ou deux voies veineuses aux membres inférieurs
E- Mise en place d'une ou deux voies veineuses aux membres supérieurs
F- Mise en place d'une ou deux voies veineuses au niveau cervical

56. Indiquez l'importance de la pose de sonde d'aspiration gastrique dans le protocole de réanimation du traumatisé crânien. (1réponse) Elle permet de :

A- Limiter l'extension de l'hématome C- éviter le syndrome de Wolkmann

B- Limiter la durée de l'intervalle libre D- éviter le syndrome de Mendelson

57. Que faut-il dans la CAT devant un scalp pédiculé ? (2 réponses)

A- Faire une craniotomie d'urgence D- Nettoyer et faire un pansement
B- Réappliquer et suturer le scalp E- Aspirer et désobstruer le patient en maintenant le scalp
C- Faire une assistance ventilatoire F- Poser une urinaire à demeure pour contrôler la diurèse

58. Parmi les éléments de la surveillance post opératoire ci-dessous, trois (3) relèvent de l'état végétatif du patient ; lesquels ?

A- Niveau de conscience C- Profondeur du coma E- Tension artérielle
B- Respiration D- Perméabilité des tuyaux F- Rythme cardiaque

59. Au plan anatomique, la cyphose du rachis se situe dans l'une des portions rachidiennes ci-dessous ; laquelle ?

A- Portion cervicale C- Portion lombaire
B- Portion dorsale D- Portion sacrocoxigienne

60. Les troubles neurovégétatifs sont consécutifs à l'atteinte de l'une des portions rachidiennes ci-dessous ; laquelle ?

A- Portion cervicale C- Portion lombaire
B- Portion dorsale D- Portion sacrocoxygienne

61. Le but du traitement dans le traumatisme du rachis est de

A- Prévenir la survenue des escarres C- Récupérer les fonctions motrices et sensitives
B- Soutenir le patient au plan psychologique D- Assurer une immobilisation conséquente du rachis

62. Les fractures et les luxations du rachis sont causées par les mouvements énumérés ci-dessous, sauf un : lequel ?

A- Les mouvements d'hyper flexion du rachis d. Le choc indirect
b. Les mouvements d'hyper extension du rachis e. Les plongées sous-marines
c. Le choc direct

63. Parmi les signes ci-dessous énumérés, lesquels ne sont pas des signes généraux du Mal de Pott ? (2réponses)

A- Raideur marquée du rachis D- Altération de l'état Général
B- Fièvre vespérale E- Contracture des muscles para vertébraux
C- Gibbosité

64. Dans le traumatisme crânien grave, le score de Glasgow est de :

A- 13 à 15 a. 9 à 12 b. 3 à 8

65. La liste ci-dessous est celle des paramètres d'analyse de l'échelle de Glasgow ; lesquels ? 3 réponses

A. Mouvement respiratoire C. Fermeture des yeux E. Réponse motrice
B. Ouverture des yeux D. Réponse verbale F. Ouverture de la bouche

66. Parmi ces signes émanant du score de Glasgow, lequel appartient à la meilleure réponse motrice ?

A- Mouvement de flexion anormale à la douleur = 3 C- Mouvement aux ordres = 6
B- Mouvement d'extension à la douleur = 2

67. Parmi les étiologies des sciatalgies énumérées ci-dessous, quelles sont les propositions exactes ? (3 réponses)

A- Une spondylodiscite infectieuse C- Une hernie discale
B- Un canal lombaire agrandi D- Un canal lombaire rétréci

68. Parmi ces examens paracliniques ci-dessous, un seul permet de faire l'exploration neurologique et ostéoarticulaire complète dans les sciatalgies ; lequel ?

A- Radiographie du rachis C- Imagerie à résonnance magnétique (IRM)
B- Sacro radiculographie

69. Un traumatisé de la voie publique qui ouvre les yeux à la parole, répond de manière confuse aux questions et fait une flexion des bras à la douleur de manière anormale, présente comme score de Glasgow

A- 8 B = 9 C = 10

70. Parmi les éléments du principe des quatre tuyaux suivants, deux sont des moyens de prévention du

syndrome de Mendelssohn et l'œdème cérébral.

A- Tubulure d'oxygénation c. Sonde urinaire
b. Perfusion par voie veineuse d. Sonde nasogastrique

71. Les lésions suivantes, peuvent être observées au niveau du cerveau après un traumatisme crânioencéphalique, sauf deux ; lesquelles ?

A- Un œdème b. Une ecchymose c. Une commotion d. Une embarrure

72. Les signes ci-dessous sont des signes méningés après un traumatisme crânioencéphalique, sauf deux ; lesquels ?

A- Raideur cervicale c. vomissement incoercible e. relâchement sphinctérien
b. hémiplégie d. myosis

CAS CLINIQUE

IKA admis aux urgences de chirurgie pour un traumatisme crânien : Il est en attitude d'opisthotonos, ouvre les yeux au pincement et ses dires sont incompréhensibles

73. Le score de Glasgow de IKA est

A- 10 B- 9 C- 8 D- 7

74. Selon la cotation du score de Glasgow, le traumatisme de IKA est un

A- Traumatisme crânien grave C- Traumatisme crânien bénin
B- Traumatisme crânien modéré D- Aucune des réponses

75. L'état de IKA nécessite

A- Une simple mise en observation dans les 24 heures
B- Une transfusion iso groupe immédiate dans les 24 heures
C- Une réanimation pour des soins adéquats dans les 24 heures
D- Des soins chirurgicaux adéquats dans les 24 heures

76. L'attitude d'opisthotonos de IKA relève de l'un des paramètres d'appréciation de l'échelle de Glasgow ci-dessous

A- Ouverture des yeux B- Réponse motrice C- Réponse verbale

77. Les lésions traumatiques du rachis sont de différents types : Lesquels ? 3 réponses

A- Lésions disco-vertébrales D- Lésions mixtes
B- Lésions musculaires E- Lésions disco-musculaires
C- Lésions disco-ligamentaires F- Lésions musculo-vertébrales

SUJET N°15 : SEMIOLOGIE CHIRURGICALE

QCD

1. Les exotoxines sont des poisons rejetés dans l'organisme à la mort du germe A / B
2. L'asepsie désigne l'absence de tout germe microbien et tout élément susceptible de provoquer la putréfaction et l'infection A / B
3. Le staphylocoque doré est un microbe saprophyte dans le milieu hospitalier A / B
4. L'utilisation abusive ou incontrôlée des antibiotiques en milieu hospitalier peut entrainer des résistances A / B
5. Le milieu, l'être vivant ou les objets qui ne comportent pas de germe sont dits septiques A / B
6. L'auto-infection, le germe exalte son pouvoir pathogène pour aller contaminer un sujet A / B
7. Le Pseudomonas devient virulent à la suite de l'utilisation d'un antibiotique A / B
8. Le Proteus est un germe saprophyte A / B
9. L'hétéro-infection est le fait que le germe provienne d'un autre individu pour contaminer un sujet sain A / B
10. La virulence est le pouvoir de multiplication du germe dans l'organisme A / B
11. L'asepsie en chirurgie est obtenue par différentes méthodes suivantes A / B
12. La désinfection de la peau au tour du champ opératoire avec des antiseptiques A / B
13. La stérilisation du linge opératoire par l'autoclave A / B
14. La stérilisation des instruments opératoires en métal par le poupinel A / B

15. La stérilisation de la salle opératoire à l'aide d'un produit pulvérisé dans la salle appelé formol A / B
16. L'isolement des malades infectés, éviction scolaire mise en quarantaine A / B
17. L'utilisation de boîte de pansement stérile ou individuel pour tous les patients A / B
18. La propreté du personnel médical ou autres personnels de santé A / B
19. L'inobservation des règles d'hygiène hospitalière A / B
20. La rougeur au niveau de l'inflammation relève de l'hyperthermie locale liée à la vasoconstriction A / B
21. La douleur traduit l'irritation de terminaisons nerveuses locales A / B

QCM

22. Compléter la phrase en choisissant le bon item parmi ceux qui sont proposés en dessous ? L'asepsie est…..
A. L'absence de tout germe bactérien pathogène
B. L'absence de tout germe bactérien susceptible de provoquer des infections
C. L'ensemble des méthodes qui ont pour but de détruire les microbes
D. L'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes
E. L'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des bactéries
F. La présence de tout élément susceptible de provoquer la putréfaction ou l'infection

23. La liste ci-dessous contient les différentes phases chronologiques de l'inflammation au plan local. Laquelle ?
A. (phase de réparation - phase cellulaire - phase vasculaire)
B. (phase vasculaire - phase de réparation - phase cellulaire)
C. (phase cellulaire - phase vasculaire - phase de réparation)
D. (phase pyrogène - phase douloureuse - phase œdémateuse)
E. (phase douloureuse - phase pyrogène - phase œdémateuse)

24. S'agissant du patient, lorsque l'on parle de terrain en chirurgie, il s'agit de quoi ?
A. De l'état clinique du client
B. De l'état physiologique du patient
C. Du lieu de travail du personnel soignant
D. De la porte d'entrée du germe en cause

25. Qu'est-ce que la septicémie ?
A. Une décharge de germes dans un organe
B. Une décharge répétée de germes dans le sang
E. Une décharge de germes dans toutes les cellules
D. Une multiplication de germes dans un tissu

26. L'infirmier prélève le sang pour l'hémoculture en période de frissons chez le patient. Pourquoi ? (Une réponse) Parce que :
A. Le germe est encore dans la porte d'entrée
B. Le germe est dans le sang
C. Le germe est en métaphase

27. Les signes ci-dessous sont dits physiques dans la septicémie sauf trois. Lesquels ?
A. Hyperthermie
B. Cardiomégalie
C. Eruptions cutanées
D. Splénomégalie
E. Arthralgie
F. Oligurie

28. Quelle est la porte d'entrée d'une septicémie à perfringens ?
A. Les infections urinaires
B. Une plaie mal traitée
E. La ponction veineuse
D. Un avortement septique

29. Que signifie inciser un abcès collecté au point le plus déclive signifie ?
A. Le point le plus latéral
B. Le point le plus haut
C. Le point le plus bas
D. Le point le plus médian

30. Quels sont les signes fonctionnels de la septicémie parmi ceux qui énumérés ci-dessous ? (Deux réponses)
A. Arthralgie
B. Hyperthermie
C. Faciès tiré
D. Oligurie
E. Pouls filant
F. Eruptions cutanées

31. Quelles sont les parties du corps humain ci-dessous pouvant être le siège d'une lymphangite? (Quatre réponses)
A. Le cou
B. La joue
C. Les membres
D. Les paupières
E. Les seins
F. La verge

32. La prise en charge étiologique d'un abcès froid dure
A. Au moins 6 mois
B. Moins de 6 mois
C. Au plus 6 moins

33. Quel est le germe responsable de l'abcès froid ?
A. Le colibacille
B. Le bacille d'Eberth
C. Le bacille de Koch
D. Le bacille de Nicolaier

SUJET N°16 : LES PLAIES: CELLULES ET TISSUS

Q.C.D.

1. Une effraction peu profonde de la peau n'est pas une plaie A / B
2. Une égratignure n'est pas une plaie A / B
3. Les plaies simples se limitent à l'effraction des tissus superficiels A / B
4. Les plaies composées sont des plaies complexes A / B
5. Les plaies composées atteignent les tissus sous-jacents A / B
6. Les plaies situées sur les parties osseuses évoluent vers l'ostéite A / B
7. Les escarres sont des plaies qui ne cicatrisent pas facilement A / B
8. Une plaie linéaire est due à un objet pointu A / B
9. Une plaie contuse est due à un objet contondant A / B
10. Un micro-organisme pathogène ne peut pas créer une plaie A / B
11. Le diagnostic d'une plaie se fait facilement à l'œil nu A / B
12. Les plaies par arme à feu sont plus graves que celles par arme blanche A / B
13. L'exsudat est un liquide qui suinte d'une plaie A / B
14. L'alimentation a une grande importance concernant la cicatrisation d'une plaie A / B
15. Les escarres sont classées parmi les plaies chroniques A / B
16. Les ulcères des jambes sont des plaies aigües A / B
17. Un épithélium stratifié est composé au minimum de trois couches de cellules A / B
18. Le tissu épithélial est classé en trois groupes A / B
19. Une glande tubuleuse est une glande exocrine A / B
20. Le testicule et le pancréas sont des glandes exocrines seulement A / B
21. Les glandes sébacées ont des canaux excréteurs A / B
22. Tous les épithéliums sont des tissus de revêtement seulement A / B
23. La division indirecte et la division directe ont les mêmes phases A / B
24. La méiose et la mitose ont les mêmes phases de division A / B
25. L'anabolisme cellulaire est une dégradation de la matière vivante A / B
26. Les cellules anaérobies et aérobies consomment toutes de l'oxygène A / B
27. Au niveau cellulaire, la respiration est synonyme de rejet de gaz carbonique A / B
28. Une cellule anaérobie est une cellule qui rejette beaucoup de gaz carbonique A / B
29. Les gamètes et les zygotes sont des cellules dont les chromosomes sont réduits de moitié A / B
30. Une cellule peut vivre indéfiniment A / B
31. La pinocytose est un mécanisme de digestion intra cellulaire de matériel liquide A / B
32. La cellule sexuelle est composée de 23 paires de chromosomes A / B
33. Le zygote est une cellule sexuelle A / B
34. Les cellules ont toutes la même forme A / B
35. Une cellule peut avoir une taille de plusieurs centimètres A / B
36. Un tissu est défini comme étant un ensemble de cellules superposées A / B
37. La consommation d'oxygène est réservée aux cellules aérobies A / B
38. L'expulsion des déchets hors de la cellule est un mécanisme de la digestion intra cellulaire A / B
39. Seule les cellules humaines ont la capacité de transmettre des informations héréditaires A / B
40. La forme de la cellule varie contrairement à sa taille A / B
41. La phagocytose et la pinocytose sont des mécanismes de digestion intra cellulaire A / B
42Une cellule nerveuse longue d'un mètre peut être étudiée à l'œil nu A / B
43. La pupille est un organe de l'œil A / B
44. La peau contient des glandes exocrines A / B
45. L'appendice peut prendre plusieurs positions dans l'abdomen A / B

Q.C.M.

46. Quels sont les deux (02) buts du traitement d'une plaie ?

A- Définir la plaie
B- Inspecter la plaie
C- Faire l'anamnèse de la plaie
D- Favoriser une bonne cicatrisation
E- Eviter les complications

47. On regroupe les plaies en deux (02) grandes catégories. Lesquelles ?

A- Plaies simples
B- Plaies complexes
C- Plaies délabrées
D- Plaies suintantes

48. Quels les objets parmi ceux qui sont énumérés en bas qui peuvent occasionner une plaie linéaire ? (Trois réponses)

A- Couteau
B- Fusil
C- gourdin
D- Lame
F- poignard
E- Machette

49. Quels sont les facteurs de gravité d'une plaie parmi ceux qui sont énumérés ci-dessous ? (Deux réponses)

A- Les circonstances de survenue
B- La douleur
C- La localisation
D- La profondeur
E- Le mécanisme

50. Identifiez en fonction de la nature, les plaies graves. (Quatre réponses)

A- Plaie dont le siège est l'abdomen
B- Plaie à proximité d'un orifice naturel
C- Plaie souillée
D- Plaie étendue et profonde
E- Plaie délabrée superficielle
F- Plaie linéaire non profonde

51. Quelles sont les plaies simples parmi celles-ci qui sont énumérées en dessous ? (Deux réponses)

A- Plaies linéaires non profondes
B- Délabrements cutanés superficiels
C- Ulcère phagédénique
D- Ulcère variqueux
E- Larges délabrements pas profonds
F- Plaies situées sur les parties osseuses

52. Identifiez les plaies complexes ou composées parmi celles qui sont énumérées en dessous ? 4 réponses

A- Délabrements cutanés superficiels
B- Larges délabrements profonds
C- Plaies linéaires profondes
D- Plaies punctiformes superficielles
E- Ulcère de Buruli
F- Les plaies situées sur des parties non charnues

53. Quelle est la cause d'un délabrement cutané ? (Deux réponses)

A- un barbelé en fer
B- une chaîne de moto
C- un coup de massue
D- un coup de poing

54. Quelles sont les objets responsables des plaies punctiformes parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Trois réponses)

A- Une aiguille
B- une balle d'arme à feu
C- un poignard
D- un bâton
E- une machette
F- une lame

55. Quelles sont les complications des plaies parmi celles qui sont énumérées en dessous ? (Quatre réponses)

A- surinfection
B- septicémie
C- gangrène
D- large délabrement profond
E- chéloïdes

56. Les mauvaises cicatrisations des plaies aboutissent à des complications. lesquelles ? (Trois réponses)

A- brides au niveau des plis
B- cals vicieux
C- chéloïdes
D- cicatrices rétractiles
E- pseudarthrose

57. Quelles sont les plaies qui ont besoin d'une prise en charge particulière parmi celles énumérées en dessous ? (Trois réponses)

A- Délabrement cutané superficiel
B- Escarres
C- Gangrènes
D- Plaie linéaire non profonde
E- Plaie punctiforme superficielle
F- Ulcère de Buruli

58. S'agissant des types de plaies et de leurs causes, les combinaisons ci-dessous sont les bonnes (Trois réponses). a. Plaie linéaire 1-AVP b. Plaie contuse 2-lame, couteau c. Délabrement cutané profond 3-balle d'arme à feu, pointe d. Plaie punctiforme4- coup de marteau, coup de poing e. Plaie étendue 5- barbelé en fer, chaîne de vélo/moto

A (a, 3); B (a, 2) C (b, 1); D (c, 5); E (d, 4); F (d, 3)

59. Que recherche l'examen clinique d'une plaie traumatique ?(Trois réponses)

b- L'aspect des bords
c- Le traitement déjà reçu
d- La nature de l'agent agresseur
e- Le mécanisme de l'agression
f- L'état des tissus vivants
g- Le nombre de plaies

60. Quelle conduite à tenir devant une plaie ? (Trois réponses)

A- Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon
B- Désinfecter la plaie avec un antiseptique
C- Protéger la plaie grâce à des pansements
D- Utiliser le même set pour tous les patients
E- Faire les pansements selon le rythme du patient

CAS CLINIQUE N°1

De garde aux urgences chirurgicales, vous recevez M. HORO T. 45 ans porteur d'une plaie à l'abdomen à la suite d'une rixe. Voici les constantes relevées par l'Aide-Soignante.- TA= 14/7 cm Hg - Taille = 175 cm - Poids = 90 kg - Pouls= 92 puls/min - T°= 37°8 C -Fréquence respiratoire= 20 cycles/min

A l'examen le médecin-chirurgien note :- Conjonctives colorées - Respiration calme et normale - Abdomen souple et dépressible -Saignement de faible abondance -Plaie linéaire outre la section cutanée n'atteint pas les tissus sous-cutanés

61. Qu'est-ce une plaie ? (1 réponse)

A- La plaie est une solution avec continuité de la peau
B- La plaie est une effraction plus ou moins profonde de la peau

62. Quel est ce type de plaie ? (1 réponse)

A- Plaie simple B- Plaie complexe

63. Quelle est la nature probable de l'agent agresseur ?

A- Une arme à feu B- Une arme blanche C- Un objet contondant

64. Quelle est la conduite à tenir de l'IDE dans la chronologie des actes de soins ?

A- (Faire le SAT - se laver les mains et/ou porter des gants- inspecter la plaie pour l'apprécier- la désinfecté avec un antiseptique- appliquer le produit de pansement indiqué- la recouvrir-)
B- (Inspecter la plaie pour l'apprécier- appliquer le produit de pansement indiqué- la désinfecter avec un antiseptique -la recouvrir- se laver les mains et/ou porter des gants -faire le SAT)
C- (Se laver les mains et/ou porter des gants- inspecter la plaie pour l'apprécier- la désinfecter avec un antiseptique- appliquer le produit de pansement indiqué- la recouvrir- faire le SAT)

65. Quelle est votre CCC à HORO par rapport à la plaie ? 3 réponses

A- Eviter les aliments riches en sucre
B- Eviter le lait écrémé
C- Eviter le gingembre et le curcuma
D- Favoriser les aliments riches en vitamine C et en protides
E- Eviter les souillures
F- Eviter les rixes

SUJET N°17: NEUROCHIRURGIE

QCD

1. L'un des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax est d'éviter les complications A / B
2. Dans les signes de souffrance respiratoire, le sujet ne présente pas une lésion du nerf récurrent (trouble phonique). A / B
3. En cas de traumatisme du thorax, l'inspection apprécie les vibrations vocales et le choc de pointe à l'étape analytique. A / B
4. L'impotence fonctionnelle relative ou absolue est un signe physique du traumatisme du bassin. A / B
5. L'état de choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature. A / B
6. Le polytraumatisé est tout blessé qui a moins de deux traumatismes. A / B
7. La précipitation n'est pas un geste salvateur dans la CAT auprès d'un traumatisé des voies publiques. A / B
8. Au cours d'un traumatisme crânien, plusieurs structures anatomiques sont sensibles d'être lésées. A / B
9. La mydriase est la dilation du diamètre de la pupille. A / B

10. L'arachnoïde fait partie des 3 enveloppes qui recouvrent la moelle osseuse A / B
11. L'amnésie n'est pas un signe fonctionnel en cas de traumatisme crânien. A / B
12. Dans les sciatalgies les douleurs résultent d'une action physique et chimique. A / B
13. Les kystes méningés sont l'une des causes des sciatalgies. A / B
14. Le nerf sciatique est le plus gros et le plus long nerf du corps humain. A / B
15. Plus le score de Glasgow est élevé plus l'état du malade est grabataire A / B

QCM

16. Parmi les signes ci-dessous énumérés, lesquels ne sont pas des signes généraux du Mal de Pott ? (2réponses)

a. Raideur marquée du rachis
b. Fièvre vespérale
c. Gibbosité
d. Altération de l'état Général
e. Contracture des muscles para vertébraux

17. Dans le traumatisme crânien grave, le score de Glasgow est de :

A- 13 à 15 B-9 à 12 C- 3 à 8

18. Parmi ces signes émanant du score de Glasgow, lequel appartient à la meilleure réponse motrice ?

1. Mouvement de flexion anormale à la douleur = 3
2. Mouvement d'extension à la douleur = 2
3. Mouvement aux ordres = 6

19. Parmi les étiologies des sciatalgies énumérées ci-dessous, quelles sont les propositions exactes ? (3 réponses)

A- Une spondylodiscite infectieuse
B- Un canal lombaire agrandi
C- Une hernie discale
D- Un canal lombaire rétréci

20. Parmi ces examens paracliniques ci-dessous, un seul permet de faire l'exploration neurologique et ostéoarticulaire complète dans les sciatalgies ; lequel ?

A- Radiographie du rachis
B-Sacro radiculographie
C-Imagerie à résonnance magnétique (IRM)

21. Un traumatisé de la voie publique qui ouvre les yeux à la parole, répond de manière confuse aux questions et fait une flexion des bras à la douleur de manière anormale, présente comme score de Glasgow

A = 8 B = 9 C = 10

22. Parmi les éléments du principe des quatre tuyaux suivants, deux sont des moyens de prévention du syndrome de Mendelson et l'œdème cérébral.

a. Tubulure d'oxygénation
b. Perfusion par voie veineuse
c. Sonde urinaire
d. Sonde nasogastrique

23. Les lésions suivantes, peuvent être observées au niveau du cerveau après un traumatisme crânioencéphalique, sauf deux ; lesquelles ?

a. Un œdème b. Une ecchymose c. Une commotion d. Une embarrure

24. Les signes ci-dessous sont des signes méningés après un traumatisme crânioencéphalique, sauf deux ; lesquels ?

a. Raideur cervicale
b. hémiplégie
c. vomissement incoercible
d. myosis
e. relâchement sphinctérien

25. Les pathologies ci-dessous sont des causes d'une sciatique, sauf deux ; lesquelles ?

a. Kystes méningés
b. Lymphangite
c. Mal de Pott
d. Lipome
e. Tumeurs osseuses

26. Parmi les propositions ci-dessous, quelle est celle qu'il ne faut pas faire chez les traumatisés du crâne ?

a. Apprécier l'état de conscience
b. Apprécier les fonctions vitales
c. Rechercher les signes méningés (céphalées, raideurs de la nuque)
d. Faire une ponction de l'hématome
e. Rechercher une mydriase.

27. Le score de Glasgow permet d'évaluer l'état de conscience et de suivre son évolution à partir des trois

éléments énumérés ci-dessous sauf un : lequel ?

a. Ouverture des yeux
b. La capacité à déglutir
c. L'ouverture des yeux aux stimulations verbales
d. L'appréciation de la réponse motrice à la parole et/ou à la douleur.

28. Les éléments ci-dessous sont exacts sauf un, permettant d'identifier l'étiologie des sciatalgies. Lequel ?

a. Une spondylodiscite infectieuse
b. Une tumeur osseuse
c. Une hernie discale
d. Un canal lombaire agrandi.

29. Pour soulever un traumatisé du rachis avec le maximum de sécurité, il faut pratiquer les gestes ci-dessous, sauf un

a. Maintenir solidement et prudemment la tête en arrière
b. Tirer sur les chevilles
c. Fléchir la tête
d. Saisir le corps sous le tronc et sous les cuisses

30. Parmi les hémorragies cérébroméningées ci-dessous énumérées, lesquelles sont des complications de la fracture du crâne ? (Trois réponses)

a. Hématome extradural
b. Engagement cérébral
c. Hémorragie intradurale
d. Engagement cérébelleux
e. Hématome sous dural

31. Parmi les symptômes ci-dessous, quels sont ceux d'un traumatisé de la base du crâne ? (Quatre réponses)

a. Paralysie faciale
b. Trouble de l'équilibre
c. Otorragie
d. Trouble de l'audition
e. Rhinorrhée
f. Délires

32. Parmi ces signes émanant du score de Glasgow, lesquels appartiennent à la meilleure réponse verbale ? (Deux réponses)

a. Orientée
b. confuse
c. inappropriée
d. incompréhensible
e. aucune

33. Parmi ces signes paracliniques, un seul permet de faire l'exploration neurologique et ostéoarticulaire complète dans la sciatalgie ; lequel ?

a. Sacro radiculographie b. Scanner du rachis c. Imagerie à résonnance magnétique (IRM)

SUJET N° 18 : Neurochirurgie N°2

I- QUESTIONS À CHOIX DOUBLE (QCD)

1. La neurologie est la discipline médicale qui prend en charge les maladies du système nerveux A / B
2. La subluxation est considérée comme une luxation incomplète A / B
3. L'une des étiologies du traumatisme du thorax est l'accident de sport A / B
4. La luxation de l'épaule est une perte de contact plus ou moins importante de deux surfaces articulaires, l'une par rapport à l'autre A / B
5. Les lésions vasculo-nerveuses sont complications primaires des fractures du membre inférieur A / B
6. Éviter les complications fait partie des buts de la conduite thérapeutique en cas de traumatisme du thorax A / B
7. En cas de traumatisme du thorax, l'inspection apprécie aussi la déformation du thorax dans l'étape analytiqueA/B
8. En cas de fracture isolée ou étagée de côte à l'étape synthétique chez le traumatisé du thorax, on note une douleur à l'inspiration profonde A / B
9. Le mal de pott est une infection disco-vertébrale due au bacille de KOCH. A / B
10. Le polytraumatisé est tout malade ayant moins de deux traumatismes A / B
11. La ceinture pelvienne est un élément du squelette appendiculaire A / B
12. La traumatologie est la science qui étudie les accidents du squelette axial et appendiculaire. A / B
13. Les fractures de l'enfant sont dites fractures en « bois vert ». A / B
14. L'atteinte du nerf sciatique et l'hématome sont deux complications immédiates des fractures du fémur A / B
15. Les 02 complications secondaires des fractures du fémur constituent l'amyotrophie du quadriceps et la raideur du genou A / B
16. La sciatalgie n'est pas une maladie A / B
17. La sciatalgie ou névralgie sciatique ou encore sciatique se définit comme toute douleur dans le territoire du nerf

sciatique (L5 S1). A / B

II- QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM)

18.Quels sont les signes fonctionnels de la fracture du tiers moyen de la clavicule ? (Deux réponses)

A- abaissement du moignon de l'épaule
C- tête inclinée du côté atteint
B- douleur vive et persistante
D- impotence fonctionnelle

19. Dans les bases du traitement en cas de fracture de la clavicule, la méthode orthopédique consiste à : (Une réponse)

A- Une réduction sous anesthésie générale à foyer ouvert
B- Un bandage en huit de chiffre et les branches se croisent dans le dos
C- Une contention par broche de Kirchner introduite par l'extrémité de l'os

20. En quoi consistent les rôles de l'infirmier (ère) sur le lieu d'un accident de la circulation ? (Trois réponses)

A- faire une immobilisation provisoire des éventuelles fractures
B- préparer le champ opératoire
C- faire un pansement aseptique
D- baliser le lieu de l'accident
E- mettre les victimes dans une position latérale de sécurité
F- transporter rapidement les blessés à l'hôpital le plus proche

21. Quels sont les symptômes du syndrome de Wolkmann, parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Trois réponses)

A- Hématome
D- Arthrose
B- Œdème
E- impotence fonctionnelle
C- Douleur plus ou moins vive du membre supérieur
F- extrémités chaudes

22. Faire le nursing du malade consiste à : (Une réponse)

A- Faire la préparation psychologique
B- Faire la préparation physique pour une éventuelle intervention chirurgicale
C- Faire le prélèvement pour le bilan préopératoire
D- faire la toilette et la prévention des escarres

23. Relevez parmi les complications suivantes des fractures du membre supérieur, celles qui sont des complications immédiates (Deux réponses)

A- lésions vasculo-nerveuses
C- choc traumatique
E- cals vicieux
B- ulcères variqueux
D- atrophie musculaire

24. Quels sont les signes d'une insuffisance circulatoire à reconnaître par l'infirmier(ère) dans la surveillance d'un malade choqué ? (Quatre réponses)

A- Le signe de Kernig
D- L'obnubilation
B- Le pouls filant, voire imprenable
E- L'état de conscience
C- La diurèse
F- La chute de la tension artérielle

25. Dans la CAT devant une luxation récente de l'épaule, que faut-il faire ? (Deux réponses)

A- Procéder à l'interrogatoire sur les circonstances de l'accident
B- Préparer psychologiquement le malade
C- Demander des radiographies de face et de profil pour une confirmation du diagnostic
D- Dépister les complications neuro-vasculaires
E- Faire une ostéosynthèse de la région atteinte

ETUDE DE CAS

Une patiente à la peau dépigmentée victime d'un accident de la voie publique est référée dans un CHU de la place. Elle présente plusieurs fractures sur toutes les parties de son membre supérieur gauche ne mettant pas en jeu le pronostic vital. Elle est choquée mais consciente. Le traitement suivant lui a été prescrit en attente du traitement

des fractures : -Sérum glucosé 5% = 1 litre/jour -Tramadol 50 mg = 2 ampoules en perfusion/jour Sachant que : 1ampoule fait 2 ml

26. Dans quel service doit-on l'hospitalisée ?

A- Urgence chirurgicale C- Traumatologie E- Neurologie
B- Dermatologie D- Rhumatologie

27. Selon vous, cette patiente est dite :

A- Polyfracturée B- Polytraumatisée C- polyfracturée et polytraumatisée

28. De quel choc s'agit-il ?

A- Choc anaphylactique C- Choc cardiogénique E- Choc traumatique
B- Choc hypovolémique D- Choc septique

29. Quels sont les effets secondaires fréquents de l'abus des corticoïdes ? (Quatre réponses)

A- Amincissement de la peau D- Augmentation de la glycémie
B- Absence de vergetures et d'ecchymoses E- Retard de cicatrisation
C- Elévation de la pression artérielle F- Accélération de la croissance

30. Quels sont les signes du choqué parmi ceux qui sont énumérés en dessous ? (Trois réponses)

A- Langue saburrale D- Pression artérielle basse avec différentielle pincée
B- Pouls filant E- Œdèmes des membres inférieurs
C- Asthénie F- Fréquence respiratoire anormale

31. Quel est le débit de la perfusion ?

A- 12 gouttes/min B- 14 gouttes/min C- 16 gouttes/min

32. Quels conseils allez-vous à la dame à la sortie de l'hôpital ? (Trois réponses)

A- Lui conseiller les pommades à base de quinones pour encore plaire
B- Lui expliquer les conséquences de l'usage abusif des corticoïdes
C- Revenir dans le service dès la moindre douleur sous plâtre
D- Noter la date de la pose et de l'ablation du plâtre sur le membre plâtré
E- Eviter la toilette générale
F- Avoir une alimentation riche en protide et variée

SUJET N° 19 : CHIRURGIE PEDIATRIQUE

QCD

1. Les malformations congénitales constituent un groupe de troubles variés d'origine prénatale A / B
2. Les malformations congénitales, également appelées anomalies à la naissance, sont des malformations physiques déjà présentes avant la naissance A / B
3. Une maladie congénitale est une pathologie qui touche une personne dès la naissance A / B
4. Une maladie héréditaire est une maladie transmise par les parents A / B
5.Tous les gènes transmis par les parents sont dominants A / B
6. Le chromosome Y est uniquement transmis du père à son fils A / B
7. La malformation congénitale est un vice de structure anatomique uniquement externe présent à la naissance A /B
8. Les facteurs extrinsèques agissent avant le 3ème mois sur le fœtus A / B

9. les malformations congénitales sont liées à des perturbations au cours de la vie in utéro. Quels en sont les deux (02) types ? (1 réponse)

A- Acquises seulement B- Embryonnaires uniquement C- Embryonnaires ou Acquises

10. Quelles sont les anomalies de développement par défaut parmi ceux qui sont énumérés en dessous ?

A- Aplasie B- Atrophie C- Hypertrophie D- Polydactylie

11. La liste ci-dessous contient trois (3) facteurs extrinsèques favorisant les malformations congénitales, lesquels?

A- La rubéole C- Le mongolisme E- La toxoplasmose
B- Les rayons X D- L'hépatite B F- Le paludisme

12. Les malformations peuvent être d'ordre: (Quatre réponses)

A- Héréditaire C- Génétique E- Nerveux
B- Chromosomique D- Carence en micronutriments F- Stress

13. Laquelle des malformations congénitales ci-dessous est diagnostiquée chez le nouveau-né par la manœuvre d'Ortolani

A. La côte cervicale B. La hanche luxée C. La polydactylie D. La hanche luxable

14. L'une des malformations congénitales ci-dessous est diagnostiquée chez le nouveau-né par le signe de Nélaton

A- La hanche luxée B- La hanche luxable C- La polydactylie D- La côte cervicale

15. Quelle est la malformation congénitale parmi celles énumérées ci-dessous est une déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambes en X)

A- Syndactylie B- Genu valgus C- Genu varus

16. La luxation de la hanche est réductible ; à quel âge ?

Avant 8 ans B-Après 8 ans

17. L'une des variétés de pieds bots ci-dessous est plus fréquente chez les garçons que les filles; laquelle?

A- Pied bot métatarsus varus C- Pied bot valgus
B- Pied bot varus équin D- Pied talus

18. S'agissant des pieds bots, la déviation du pied en dehors par rapport à l'axe du corps est :

A- Le pied bot métatarsus varus C- Le pied bot valgus
B- Le pied bot varus équin D- Le pied talus

19. S'agissant des pieds bots, l'étalement exagéré des orteils portés en dedans est

A- Le pied talus C- Le pied bot varus équin
B- Le pied bot valgus D- Le pied bot métatarsus varus

20. S'agissant des pieds bots, lorsque la plante du pied est tournée vers l'intérieur, l'on parle de

A- Pied bot varus C- Pied bot métatarsus E- Pied talus
B- Pied bot valgus D- Pied bot équin

21. S'agissant des pieds bots, lorsque la pointe du pied est dirigée vers le bas, l'on parle de

A- Pied talus C- Pied bot varus E- Pied bot métatarsus
B- Pied bot équin D- Pied bot valgus

22. S'agissant des pieds bots, lorsque le pied est en hyper flexion tourné vers le genou, l'on parle de

A- Pied talus C- Pied bot varus E- Pied bot métatarsus
B- Pied bot équin D- Pied bot valgus

23. La côte cervicale est

A- Une variété de volet costal C- Une luxation post traumatique de la côte
B- Une luxation congénitale de la côte D- Une malformation de côte en surnombre

24. Qu'est-ce que la syndactylie ?

A- Une intervention chirurgicale sur les doigts C- Une insensibilité des doigts
B- Une union de deux ou plusieurs doigts D- Aucune des propositions

25. Qu'est-ce que le pouce bifide ?

A- Une polydactylie du pouce C- Une malformation par manque du pouce
B- Une infection chronique du pouce D- Aucune des propositions

26.La maladie de Madelung est aussi appelée

A- Radius curvus B- Syndactylie C- Polydactylie D- Mains bottes

27. Le poumon droit contient l'une des variétés de muscles ci-dessous, laquelle?

A- Le muscle strié C- Le muscle horripilateur
B- Le muscle lisse D- Le muscle strié particulier

28.Les organes creux abdominaux contiennent l'une des variétés de muscles ci-dessous, laquelle?

A- Le muscle strié particulier B- Le muscle strié C- Le muscle lisse

29. La liste ci-dessus contient un élément appartenant au tissu nerveux, lequel?

A- Le tissu conjonctif B- La muqueuse C- Le sang D- La cellule gliale

30. Parmi les organes ci-dessous, quels sont ceux qui ont un tissu conjonctif ? (Deux réponses)

A- La bouche C- Les seins E- Les fesses
B- Le sang D- La fibula ou péroné F- Le neurone

31. A quelle variété de tissu appartient le neurone parmi celles qui sont énumérés en dessous ?

A- Le tissu de régulation C- Le tissu musculaire
B- Les tissus conjonctifs D- Les épithéliums

32. La liste ci-dessous contient un tissu qui recouvre le conduit auditif, lequel ?

A- La muqueuse B- Le tissu aréolaire C- Le tissu réticulé D- La séreuse

33. La mélanine est un pigment synthétisé par l'une des variétés de tissus ci-dessous, laquelle?

A- Le tissu de régulation C- Le tissus épithélial
B- Le tissu musculaire D- Le tissus conjonctif

34.L'une des divisions cellulaires ci-dessous est dite réductionnelle, laquelle?

A- Mitose B- Méiose C- Amitose D- Division directe

35. Parmi les phases de division cellulaire ci-dessous, la troisième phase est

A- La télophase B- L'anaphase C- La métaphase D- La prophase

36. Qu'est-ce une glande amphicrine ? C'est une glande :

A- Exocrine B- Mixte C- Endocrine

37. Dans quelle partie de la cellule se trouvent les chromosomes?

A- Le noyau B- Le cytoplasme C- La membrane plasmique

38. Dans la cellule, les informations relatives à l'hérédité se trouvent au niveau

A- De la membrane plasmique C- Du noyau
B- Du cytoplasme D- De la membrane nucléaire

D.E CHIRURGIE TEST N°1

QCM

1. Choisissez les 3 réponses qui sont les principaux signes de la hernie étranglée :

a) De grosses bourses indolentes c) La non impulsivité à la toux e) L'expansion à la toux
b) La réductibilité d) La douleur spontanée f) L'irréductibilité

2. Choisir les 3 bonnes réponses Le rôle de l'infirmier(e) avant la transfusion est de :

a) Rechercher les signes de caillotage
b) Rechercher les accidents d'exposition au sang
c) Faire le test de sérologie virale du destinateur et/ou du producteur
d) Vérifier la date de prélèvement et de péremption des produits sanguins
e) Prise des constantes hémodynamiques
f) Faire le test de compatibilité

3. Les contre-indications de la perfusion sont : choisir 4 réponses

a) Anasarque d) Anémie très sévère g) Insuffisance cardiaque grave
b) Déshydratation sévère e) Intervention chirurgicale
c) Alimentation parentérale f) Œdème aigu des poumons

4. La luxation de l'épaule peut-être : choisir la bonne réponse

a- Complète b- Incomplète c- Complète ou incomplète

5. Les signes cliniques d'une luxation traumatique sont : choisissez les 3 bonnes réponses

a- Hyperthermie c- Perte de la mobilité normale e- Asthénie
b- Douleur de l'articulation d- Changement dans la longueur du membre

6. Les luxations peuvent être : choisissez la bonne réponse

A. Congénitales, traumatiques, pathologiques/spontanées C- pathologiques E- Traumatiques
B- Congénitales D- Spontanées

7. L'infection d'un orteil par des germes pathogènes est dénommée : cochez la bonne réponse

a- Anthrax b- Furoncle c- Gangrène d- Phlegmon e- Panaris

8. Les phases chronologiques du phénomène de l'inflammation sont : choisir la bonne réponse

A- La phase cellulaire-la phase vasculaire-la phase de préparation
B- La phase de réparation-la phase vasculaire-la phase cellulaire
C- La phase vasculaire-la phase cellulaire-la phase de réparation

9. le traitement d'une luxation récente consiste à : choisir les 2 bonnes réponses

a- référer le blessé chez un chirurgien en cas d'échec
b- rechercher des complications associées et s'abstenir de toute intervention
c- traiter de manière orthopédique seulement
d- faire l'ostéosynthèse seulement

10. Les raisons de l'éventuel échec à la réduction de la luxation de l'épaule sont : choisir les 3 bonnes réponses

a- le blessé est trop maigre
b- le blessé a une taille anormale
c- le blessé est sédentaire
d- le blessé est trop musclé
e- le blessé a été vu tardivement
f- le blessé a des signes évidents de complications

11. Les interventions infirmières dans la luxation consistent à : choisir les 2 bonnes réponses assurer les soins

a- assurer les soins de nursing
b- attendre les décisions du chirurgien
c- dépister les complications neuro-vasculaires
d- préparer psychologiquement le patient

12Quels sont les quatre (04) signes cliniques qui relèvent de l'abcès chaud, parmi ceux proposés ci-dessous ?

a- Céphalées
b- rougeur
c- Gonflement local
d- Douleur
e- chaleur locale
f- Eruption cutanée

13. Parmi les signes indiqués ci-dessous, deux (02) relèvent des signes fonctionnels de l'hémorragie interne. Lesquels ?

a- Acidose respiratoire
b-Extrémités froides
c-Taux d'hémoglobine inférieur à la normale
d-tachycardie

QCD

14. On appelle fracture, la rupture de la continuité du tissu osseux. A / B
15. La survenue d'une fracture peut se faire par un choc indirect. A / B
16. Le syndrome de Wolkmann survient avec la pose d'un appareil plâtré trop serré. A / B
17. Un polyfracturé n'est pas un polytraumatisé. A / B
18. L'asepsie en chirurgie désigne l'ensemble des méthodes qui préserve contre la souillure des microbes tout ce qui est en contact avec la plaie opératoire. A / B
19. L'articulation de l'épaule est dite diarthrose. A / B
20. Au cours d'une luxation traumatique, une fracture associée peut être décelée par la radiographie de l'articulation. A / B
21. Toute infection sans décharges importantes et répétées de germes dans le sang à partir d'un foyer septique peut déterminer une septicémie. A / B
22. Tous les germes sont pathogènes. A / B
23. La notion de terrain en sémiologie est l'état physiologique du sujet. A / B
24. Le sérum glucosé 5% n'est pas un soluté de remplissage. A / B
25. Dans les prodromes de l'appendicite aigüe, la constipation est plus fréquente que la diarrhée. A / B
26. L'occlusion intestinale relève de quatre (04) processus. A / B
27. La polyurie signifie une émission excessive d'urine A / B
28. Un patient du groupe sanguin A rhésus positif ne peut pas recevoir du sang du groupe O négatif. A / B

CAS CLINIQUE N°1

L'élève HILI S. 20 ans, fait une chute de cyclomoteur en se rendant au Lycée. Il est amené par le SAMU aux urgences de l'hôpital.

Il est choqué et respire difficilement mais conscient. Le médecin après examen clinique pose le diagnostic de fracture ouverte de l'humérus. Avec rupture probable de la rate.

29. A quel squelette appartient l'humérus ?

A- Squelette axial B- Squelette appendiculaire C- Squelette zonal

30. Dans quel cadran de l'abdomen est située la rate ?

A- L'épigastre C- Le flanc gauche E- La région ombilicale
B- L'hypochondre gauche D- La fosse iliaque gauche F- L'hypogastre

31. Définir la fracture ouverte de l'humérus

A- Rupture de la continuité de l'os situé dans le bras
B- Rupture de la continuité de l'os situé dans la cuisse dont le foyer de fracture ne communique pas avec l'extérieur par une plaie
C- Rupture de la continuité de l'os situé dans le bras dont le foyer de fracture communique avec l'extérieur par une plaie même minime

32. Qu'est-ce qu'une fracture pathologique ?

A- Fracture survenant à la suite d'un traumatisme important
B- Fracture survenant à la suite d'un traumatisme minime

33Identifiez les signes cliniques de la fracture parmi les signes énumérés ci-dessous ? 3 réponses

A- Déformation du membre atteint D- Hyperthermie
B- Douleur à la mobilisation du membre atteint E- Sénilité
C- Impotence fonctionnelle F- Asthénie

CAS CLINIQUE N°2

Mlle Sulié T. 20 ans, étudiante en Licence3 communication à la FLASH de l'Université A.O de Bouaké est amenée aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales brutales dans la fosse iliaque droite, avec nausées, vomissements et hyperthermie. Ces conjonctives sont colorées. La pression artérielle est normale.

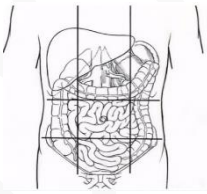
On lui prescrit :

1) Novalgin 5ml inj. : 1 amp. X 3/jour en perfusion
2) Ceftriaxone1g inj. : 1amp. X 2/ jour
3) SGI 500 ml : 1fl X 3/ jour

Observez bien cette image

Les cadrans sont identifiés par les lettres de la gauche vers la droite

A- B -C
D- E- F
G- H- I



34. Dans quel cadran se trouve la rate ?

A B C D E G H I

35. Dans quel cadran se trouve l'appendice ?

A B C D E G H I

36. De quoi souffre Mlle Sulié T. ?

A. Dysménorrhées C- Ulcère gastroduodénal E- Appendicite aigüe
B- IVG D- Occlusion intestinale aigüe F- Péritonite généralisée

37. Quels sont les éléments qui vous permettent de poser ce diagnostic ? (choisir 3 éléments)

A- Douleurs dans la fosse iliaque droite C- Tension artérielle normale E- Conjonctives colorées
B- Nausées et vomissements D- hyperthermie

38. Quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic ? (choisir 2 examens)

A- ECBU B- Echographie abdominale C- NFS/VS D- KOP

39. Quels peuvent être les autres diagnostics différentiels ? (choisir 2 éléments)

A- Grossesse tubaire droite C- Constipation opiniâtre E- Salpingite droite
B- Colique néphrétique D- Ovarite droite

40. Quelles sont les probables causes de la pathologie de Mlle Sulié T. ? (choisir 2 réponses)

A- Corps étrangers B- Obésité C- Parasitoses intestinales D- Stress

41. Quel est le débit d'une perfusion ?

A- 20 gttes/min B- 21 gttes/min C- 22 gttes/min

42 Justifiez l'usage de la ceftriaxone ?

A- Accélérer l'intervention chirurgicale C- Arrêter les nausées et vomissements

B- Prévenir les infections

D.E CHIRURGIE TEST N°2

QCD

1. On appelle fracture, la solution de continuité du tissu osseux A / B
2. La survenue d'une fracture peut se faire par un choc direct A / B
3. Le syndrome de Wolkmann survient avec la pose d'un appareil plâtré trop serré sur le membre inférieur A / B
4. Un polyfracturé n'est pas un polytraumatisé A / B
5. L'asepsie en chirurgie désigne l'ensemble des méthodes qui préservent contre la souillure des microbes tout ce qui est en contact avec la plaie opératoire A / B
6. L'articulation de l'épaule est une articulation amphiarthrose A / B
7. Au cours d'une luxation traumatique, une fracture associée peut être décelée par l'échographie de l'articulation
8. Toute infection avec décharges importantes et répétées de germes dans le sang à partir d'un foyer septique peut déterminer une septicémie A / B
9. Tous les germes sont saprophytes A / B
10. La notion de terrain en sémiologie est l'état physique du sujet A / B
11. Le sérum glucosé 5% est un soluté de remplissage A / B
12. Dans les prodromes de l'appendicite aigüe, la constipation est moins fréquente que la diarrhée A / B
13. L'occlusion intestinale relève de quatre (03) processus A / B
14. La pollakiurie signifie une émission excessive d'urine A / B
15. Un patient du groupe sanguin A rhésus positif peut recevoir du sang du groupe O négatif A / B

QCM

16. Choisissez les 3 réponses qui ne sont pas parmi les principaux signes de la hernie étranglée :

a) De grosses bourses indolentes c) La non impulsivité à la toux e) L'expansion à la toux

b) La réductibilité d) La douleur spontanée f) L'irréductibilité

17. Quelles sont les précautions que l'infirmier(e) doit prendre avant la transfusion ? (Quatre réponses)

a) Identifier les erreurs d'étiquetage des produits

b) Rechercher les accidents d'exposition au sang

c) Faire le test de dépistage du VIH et de l'hépatite B

d) Vérifier la date de prélèvement et de péremption des produits sanguins

e) Vérifier les constantes hémodynamiques

f) Faire le test de compatibilité au pied du lit du patient

18. Quelles sont les indications de la perfusion ? choisir 3 réponses

a) Anasarque c) Alimentation parentérale e) Diarrhée profuse

b) Déshydratation sévère d) Anémie très sévère f) Œdème aigu des poumons

g) Insuffisance cardiaque grave

19. La luxation de l'épaule peut-être : choisir la bonne réponse

a- Complète b- Incomplète c- Complète ou incomplète

20. Les signes cliniques d'une luxation traumatique sont : choisissez les 3 bonnes réponses

a- Anorexie d- Douleur de l'articulation

b- Asthénie e- Hyperthermie

c- Changement dans la longueur du membre f- Perte de la mobilité normale

21. Les luxations peuvent être : choisissez la bonne réponse

A. Congénitales, traumatiques, pathologiques/spontanées C- pathologiques
B- Congénitales D- Spontanées E- Traumatiques

22. L'inflammation aigüe du tissu conjonctif sous-cutané ou profond de la main par des germes pathogènes est dénommée : cochez la bonne réponse

a- Anthrax b- Furoncle c- Gangrène d- Phlegmon e- Panaris

23. Les phases chronologiques du phénomène de l'inflammation sont : choisir la bonne réponse

A- La phase cellulaire-la phase vasculaire-la phase de préparation
B- La phase vasculaire-la phase cellulaire-la phase de réparation
C- La phase de réparation-la phase vasculaire-la phase cellulaire

24. le traitement d'une luxation récente consiste à : choisir les 2 bonnes réponses

a- un traitement orthopédique seulement
b- référer le blessé chez un chirurgien en cas d'échec
c- rechercher des complications associées et s'abstenir de toute intervention
d- traiter de manière ensanglantée seulement

25. Les raisons de l'éventuel échec à la réduction de la luxation de l'épaule sont : choisir les 3 bonnes réponses

a- le blessé est trop musclé
b- le blessé a été vu tardivement
c- le blessé a des signes évidents de complications
d- le blessé est très maigre
e- le blessé a une taille anormale
f- le blessé est sédentaire

26. Les interventions infirmières dans la luxation consistent à : choisir les 2 bonnes réponses

a- assurer les soins de nursing
b- attendre les décisions du chirurgien
c- dépister les complications neuro-vasculaires
d- préparer psychologiquement le patient
e- administrer la prémédication

27. Quels sont les quatre (04) signes cliniques qui relèvent de l'abcès chaud, parmi ceux proposés ci-dessous ?

a- Céphalées D- œdème d- chaleur locale
b- rougeur c- Douleur f- éruption cutanée

28. Parmi les signes indiqués ci-dessous, deux (02) relèvent des signes fonctionnels de l'hémorragie interne. Lesquels ?

A. Sensation de soif C. Taux d'hémoglobine inférieur à la normale
B. Peau moite et froide D. Augmentation de la fréquence respiratoire

CAS CLINIQUE N°1

L'élève LAURENT S. 17 ans, fait une chute de cyclomoteur en se rendant au Lycée. Il est amené par le SAMU aux urgences de l'hôpital.

Il est choqué et respire difficilement mais conscient. Le médecin après examen clinique pose le diagnostic de fracture fermée des deux os de l'avant-bras avec rupture probable de la rate.

29. A quel squelette appartiennent les os de l'avant-bras ?

A- Squelette axial B- Squelette appendiculaire C- Squelette zonal

30. Dans quel cadran de l'abdomen est située la rate ?

A- L'épigastre C- Le flanc gauche E- La région ombilicale
B- L'hypochondre gauche D- La fosse iliaque gauche F- L'hypogastre

31. Nommez les deux os de l'avant-bras.

A- L'humérus et l'omoplate C- Le radius et le cubitus
B- L'humérus et la clavicule D- L'humérus et le fémur

32. Qu'est-ce qu'une fracture pathologique ?

A- Fracture survenant à la suite d'un traumatisme important
B- Fracture survenant à la suite d'un traumatisme minime

33. Identifiez les signes cliniques de fracture parmi les signes énumérés ci-dessous ? 3 réponses

A- Déformation du membre atteint D- Hyperthermie
B- Douleur à la mobilisation du membre atteint E- Sénilité

C- Impotence fonctionnelle F- Asthénie

CAS CLINIQUE N°2

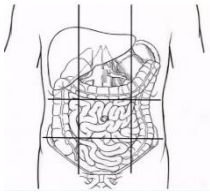
Mlle YIEO Tiéplé. 19 ans, est étudiante en DEUG II à l'Université A.O de Bouaké. Elle est amenée aux urgences chirurgicales pour douleurs abdominales brutales dans la fosse iliaque droite, avec nausées, vomissements et hyperthermie. Ces conjonctives sont peu colorées. La pression artérielle est normale. On lui prescrit en attendant l'intervention chirurgicale

1) Baralgin 5ml inj. : 1 amp. X 3/jour en IM
2) Ceftriaxone1g inj. : 1amp. X 2/ jour en IVD
3) SANG 500 CC : 1fl en 3 H et demie

Observez bien cette image

Les cadrans sont identifiés par les lettres de la gauche vers la droite

A- B -C
D- E- F
G- H- I



34. Dans quel cadran se trouve l'appendice ?

A B C D E F G H I

35. Dans quel cadran se trouve la rate ?

A B C D E F G H I

36. De quoi souffre Mlle Yiéo T. ?

A- Appendicite aigüe
B- Dysménorrhées
C- Interruption Volontaire de Grossesse
D- Ulcère gastroduodénal perforé
E- Occlusion intestinale aigüe
F- Péritonite généralisée

37. Quels sont les éléments qui vous permettent de poser ce diagnostic ? (choisir 3 éléments)

A- Douleurs dans la fosse iliaque droite
B- Nausées et vomissements
C- Tension artérielle normale
D- hyperthermie
E- Conjonctives peu colorées

38. Quels sont les examens à faire pour confirmer le diagnostic ? (choisir 2 examens)

A- ECBU
B- Echographie abdominale
C- NFS/VS
D- KOP

39. Quels peuvent être les autres diagnostics différentiels ? (choisir 2 éléments)

A- Annexite
B- Grossesse Extra Utérine
C- Colique néphrétique
D- Constipation opiniâtre

40. Quelles sont les probables causes de la pathologie chez Mlle Yiéo T. ? (choisir 2 réponses)

A- Corps étrangers
B- Obésité
C- Parasitoses intestinales
D- Stress

41. Quel est le débit de la transfusion ?

A- 34 gttes/min B- 36 gttes/min C- 38 gttes/min D- 42 gttes/min

42. Justifiez l'usage de la ceftriaxone ?

A- Accélérer l'intervention chirurgicale
B- Prévenir les infections
C- Arrêter les nausées et vomissements

D.E CHIRURGIE TEST N°3

Cas clinique 1 :

AREZKI Claudia, étudiante de 24 ans est hospitalisée en chirurgie digestive au CHU de Yopougon à la suite d'une ablation de l'appendice.

Comme traitement administré, on note :

- Sérum glucosé isotonique 500 ccx2/jour ;
- Novalgin 5 ml, 2 ampoules par perfusion ;
- Ceftriaxone 1 ampoule x2/jour en IVD

1. L'appendicite aiguë est une inflammation aiguë de l'appendice. A / B
2. Au niveau de l'abdomen, l'appendice est situé à la fosse iliaque droite. A / B
3. La douleur, la constipation et la fièvre sont les signes fonctionnels de l'appendicite aiguë. A / B
4. L'appendicite est la cause la plus courante de l'inflammation aiguë dans le cadran inférieur droit de la cavité abdominale A / B
5. L'infection à staphylocoques est une étiologie de l'appendicite aiguë. A / B
6. L'une des causes de l'appendicite aiguë est la coudure de l'appendice. A / B
7. L'appendicite non traitée et qui s'est compliquée par une perforation appendiculaire est la cause de la péritonite.
8. Dans l'appendicectomie avec drainage, dès le réveil du patient, on peut lui donner de la morphine toutes les 3 ou 4 h. A / B
9. La gastro-entérite aiguë est un diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë.
10. L'appendicite peut être le fait d'une infection par voie hématogène ou locale.

formant les jambes en parenthèse. A / B

12. Les diarthroses sont encore appelées articulations immobiles. A / B
13. Un ovule contient un mètre d'ADN, tout comme un spermatozoïde A / B
14. La denture est le mode d'apparition des dents. A / B
15. Les artères transportent le sang pauvre en oxygène A / B
16. La crépitation neigeuse est un signe physique de la gangrène gazeuse. A / B
17. L'antibiothérapie est systématique, dans la prise en charge du furoncle. A / B
18. ATOU est reçu en hospitalisation de la traumatologie pour une prise en charge de sa plaie, suite à un traumatisme ouvert du fémur droit. Le pansement sec aseptique est indiqué en cas de traumatisme non infecté. A / B
19. ATOU doit-il bénéficier aussi d'un pansement humide chaud. A / B
20. ATOU peut recevoir sur sa nouvelle plaie un pansement compressif. A / B

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM) (Q21 à Q45)

21. Deux (02) parmi les propositions ci-dessous citées sont des étiologies de l'appendicite aiguë, lesquelles ?

a. Infection à streptocoques c. Calcul appendiculaire
b. Abcès du foie d. Cholécystite aiguë

22. Parmi ces examens paracliniques, deux (02) sont couramment demandés en cas d'appendicite aiguë, lesquels ?

a. L'urée-créatinine c. Le lavement baryté e. L'échographie abdominale
b. L'abdomen sans préparation d. La numération formule sanguine

23. Indiquez le débit d'une perfusion dont doit bénéficier l'étudiante AREZKI Claudia pendant 4h, selon le traitement prescrit :

a. 43 gttes/mn b. 42,5 gttes/mn c. 42 gttes/mn d. 41,66 gttes/mn

24. Les affirmations ci-dessous indiquées sont les buts de la perfusion, sauf un, lequel ?

a. But curatif b. But de réhydratation c. But thérapeutique

25. Le traitement du plastron appendiculaire est :

a. Chirurgical b. Radiothérapique c. Médical

26. Quel peut être le besoin fondamental prioritaire non satisfait chez AREZKI Claudia, dans le modèle conceptuel de VIRGINIA HENDERSON, en dehors du besoin d'éviter le danger :

a. Besoin de se mouvoir et se maintenir en position convenable
b. Besoin d'éviter le danger
c. Besoin de s'occuper en vue de se réaliser
d. Besoin d'être propre, soigné et protéger ses téguments

Cas Clinique 2 :
Vous êtes infirmier au centre de santé rural de Bazra Nattis. M. Kabran, 59 ans, vous arrive à 2 h 35 du matin pour impossibilité brutale et totale d'uriner.

27. A quelle pathologie-pensez-vous ?
a-Rétention urinaire aigüe b- Adénome de la prostate c- Rétention urinaire chronique

28. Un signe physique parmi ceux énumérés ci-dessous vous conforte dans votre diagnostic ; lequel ?
a- Impossibilité d'uriner b- Besoin impérieux d'uriner c- Un globe vésical

29.Un signe fonctionnel parmi ceux indiqués ci-dessous vous rassure pour le diagnostic posé, lequel ?
a- Impossibilité d'uriner
b- Douleur sous-pubienne plus ou moins intense à la palpation
c- Globe vésical

30. Indiquez un examen biologique à faire pour confirmer le diagnostic.
a- ASP
b- UIV avec cliché permictionnel
c- Bilan sanguin préopératoire usuel

31. Un geste d'urgence peut immédiatement soulager M. Kabran ; lequel ?
a- Intervention chirurgicale
b- Administration d'un antalgique
c- Sondage urétral d'urgence

32. La pose de la sonde urinaire se fait dans les cas suivants, sauf deux (02) ; lesquels ?
a. Rétention d'urines c. Infection urinaire e. Incontinence urinaire
b. Douleur sus-pubienne d. Hypertrophie bénigne de la prostate

33. Dans la surveillance du patient avant la pose de la sonde urinaire, il faut procéder :
a. A une hygiène des mains du praticien ou de son aide
b. A une réfection de lit occupé après toilette générale
c. A une hygiène du méat, de la région génitale et rectale
d. A un bain et douche quotidien du praticien au besoin
e. A une préparation psychologique suivie de prévention d'escarres

34. Les définitions ci-après sont celles de l'escarre, sauf deux (02), lesquelles ?
a. Une plaie profonde suite à une morsure de serpent
b. Une plaie qui survient à la suite d'un contact prolongé sur une saillie osseuse chez un patient alité
c. Une plaie de position mal conduite
d. Une plaie qui survient chez un patient sans toilette

35.Un patient est transféré avec 450 ml de sang en 3h aux débits suivants. Indiquez le nombre de goutes/mn.
a. 38 gouttes/mn b. 50 gouttes/mn c. 90 gouttes/mn

36. Ces différents sites sont les premiers à être affectés par les escarres quand le malade est en position latérale, exceptés deux (02), lesquels ?
a. Malléole externe b. Pénis c. Épaule d. Tête du trochanter e. Menton

37. La perfusion veineuse obéit aux rôles suivants, sauf un (01), lequel ?
a. Véhiculer un médicament c. Compléter l'alimentation d'un patient moins alimenté
b. Réhydrater un patient d. Toutes les assertions sont justes

38.L a luxation congénitale de la hanche est une malformation : (Choisir une seule réponse)
a. Des surfaces articulaires c. Des ligaments articulaires
b. Des moyens de glissement d. De la capsule articulaire

39. La classification des luxations antérieures de l'épaule comprend les variétés suivantes, sauf une (01) ;

laquelle ?

a. Luxation extracoracoïdienne
b. Luxation sous-scapulaire
c. Luxation sous-claviculaire
d. Luxation intracoracoïdienne
e. Luxation sous-coracoïdienne

40.Vous devez passer 5 litres de perfusion à un patient pendant 24h. Quel nombre de gouttes deviez-vous faire passer par minute ?

a. 80 gttes b. 60 gttes c. 70 gttes d. 90 gttes

41. Ces différentes pathologies font partie des contre-indications de la transfusion sanguine, sauf deux (02), lesquelles ?

a. Embolie pulmonaire
b. Insuffisance cardiaque
c. Drépanocytose
d. Leucémie aiguë

42.Dans le syndrome d'irritation péritonéale, tous les signes cités ci-dessous sont décrits, sauf un (01), lequel

a. Douleur provoquée et défense ou contracture à la palpation
b. Douleur au TR (toucher rectal)
c. Téguments qui portent des traces
d. Douleur abdominale

43. L'un des objectifs visé dans la démarche de soins infirmiers, en cas de rétention urinaire est :

a. Le retour du mode d'élimination normal des urines
b. La pose de la sonde urinaire
c. La ponction sus-pubienne

44. Les éléments suivants définissent l'état de l'armoire dans le rangement d'une armoire à pharmacie, exceptés trois (03), lesquels ?

a. Les clés
b. La propreté
c. Les médicaments
d. L'entrée et la sortie des médicaments
e. L'armoire en bon état
f. L'inventaire

45. Monsieur W.S présente à l'examen, une déformation caractéristique de son poignet en dos de fourchette, après une chute sur son poignet. Cela évoque une fracture de POUTEAU-COLLES. Sur quel(s) os allez-vous rechercher la fracture à l'examen radiographique ?

a. Les deux (02) os b. Le radius c. L'ulna

D.E CHIRURGIE TEST N°4

Vous êtes infirmier au centre de santé rural de bouguera. Mr Yao 65 ans, vous arrive de à 1 h 00 du matin pour impossibilité brutale et totale d'uriner.

1. A quelle pathologie pensez-vous ? (choisir une seule réponse)

A. Rétention urinaire aiguë B. Adenum de la prostate C .Rétention urinaire chronique

2. Trois signes physiques parmi les signes suivants vous confortent dans votre diagnostic présomptif. Lesquels ?

A- Impossibilité d'uriner
B. Besoin impérieux d'uriner
C. Un globe vésical
D. Douleur à la palpation augmentant le besoin d'uriner
E. Douleur sus pubienne plus intense
F. Masse hypogastrique pouvant remonter jusqu'à l'ombilique

3. Ressortez deux signes fonctionnels pour le même diagnostic parmi ceux énumérés

A. Impossibilité d'uriner
B. Pollakiurie diurne ou nocturne par la diminution de la capacité fonctionnel.
C .incontinence par regorgement
D. Douleur sus pubienne de plus en plus intense

4. Trois examens biologiques et bactériologiques parmi ceux énumérés permettent de confirmer le diagnostic : lesquels ?

A. A.S.P D. Bilan rénal (urée, créatinine)

B. UIV avec clichés per mictionnels. E .échographie : rein, vessie, prostate
C .bilan sanguin préopératoire usuel F. ECBU avec antibiogramme

5. parmi les gestes d'urgence suivants, deux vont soulager immédiatement Mr YAO : lesquels ? 2 réponses

A. Intervention chirurgicale C. Sondage urétrale
B. Administration d'un analgésique D .ponction sus pubienne

SUJET II : Q.C.D (question à choix direct)

Vous recevez Mr amadou pour douleur abdominale et vomissement. A l'examen le chirurgien pose comme diagnostic, une occlusion intestinale. En per opératoire, il en ressort que cette occlusion est due à un volvulus intestinal et une péritonite appendiculaire.

6. pour confirmer le diagnostic les examens suivants ont été demandés : L'ASP et le lavement baryté : A / B
7. L'arrêt de matière et de gaz est un fonctionnel majeur pour poser le diagnostic : A / B
8. douleur abdominale et vomissement font partie des signes physiques d'une occlusion intestinale : A / B
9. A la percution l'on constate un météorisme et un ballonnement abdominal : A / B
10.à l'auscultation nous entendons un bruit hydro-Aerique appelé aussi gargouillement : A / B
11. un volvulus est une torsion de colon : A / B
12. une protonique est une inflammation de la cavité péritonéale rarement causé par une infection bactérienne :A /B
13. La péritonite appendiculaire est due à la rupture de l'appendice : A / B
14. Les soins per opératoire sont l'ensemble des activités menées par l'infirmier au cours de l'opération du malade ou quand le malade est au bloc : A / B
15. Depuis ses douleurs Mr amadou a arrêté toutes activités et exercice physiques face à cette situation l'IDE décide d'élaborer un plan de soins pour une meilleure prise en charge. Diagnostic infirmier posé :
Altération de la mobilité physique reliée à son état de santé : A / B
16. objectif de soins correspondant : Mr amadou doit être capable de mener des activités ou exercices physiques après l'intervention chirurgicale : A / B
17. surveiller les constances ou paramètre (TA, T°) : Activités menés par l'IDE (actions) Activités délégués A / B
18. administrer le traitement prescrit : A / B
19. mener avec un kinésithérapeute des exercices physiques ou massage : A / B
20. surveiller la plaie opératoire : Activités autonomes A / B
21. effectuer le premier lever : A / B
22. eduquer le malade en matière de son mode de vie, d'hygiène de vie etc… :Activités préventives A / B

23. parmi les signes cliniques suivants trois sont fonctionnel : lesquels ? 2 réponses

A .anorexie
B .nausée et vomissement alimentaire ou bilieux
C .coecum gargouillant à la palpation
D .douleur à droite provoqué par le douché pelvienne
E. Trouble du transite digestif
F. Douleur plus ou moins intense provoquée

24. deux sont des signes généraux : lesquels ?

A .une défense plus ou moins nette à la palpation
B .fièvre à 38 °C
C .état général conservé au début
D. Douleur abdominale plus au moins intense localisée dans la Fosse iliaque droite

25. A l'inspection de face d'une fracture des 2 os de l'avant bras :

La main est désaxée avec saillie exagérée de la tête cubitale sous la peau. A / B

26. Quels sont les 02 signes fonctionnels évocateurs d'une fracture de la diaphyse du fémur :

A impotence fonctionnelle absolue C mobilité passive anormale avec crépitation
B douleur exquise au niveau du foyer de fracture D douleur violente au niveau de la cuisse

27. Dans la liste suivante, indiquez les 03 complications secondaires et générales d'une fracture du fémur :

A phlébite et embolie C lésions vasculo-nerveuses E accidents de décubitus
B retard de consolidation D atrophies musculaires

28. Quelles sont les 03 interventions infirmières dans les fractures ouvertes des membres sur le lieu de l'accident :

A faire un examen clinique complet D faire un antibiotique à large spectre
B faire un examen clinique minutieux et complet E bloquer les articulations sus et sous-jacentes
C faire un antalgique

29. Les ménisques sont des fibrocartilages interposés entre condyles tibiaux et plateaux fémoraux. A / B

30. En urgence, il faut toujours immobiliser provisoirement la fracture de la diaphyse du fémur pour éviter d'aggraver le choc et minimiser le risque d'embolie graisseuse. A / B

31. La traction dite au ZENITH : c'est la traction-suspension où le membre est tiré horizontalement. A / B

32. le choc est un syndrome général de plus ou moins grande gravité, observé après toute agression de l'organisme quelle que soit sa nature A / B

33. les principes de traitement des chocs traumatiques sont :

A les mesures associées à rôle d'adjuvent C réchauffement afin d'éviter les frissons
B rétablir une perfusion tissulaire correcte D tout blessé déchoqué reste choquable

34. la lutte contre la détresse ventilatoire chez polytraumatisé consiste à :

A désencombrer les voies aériennes supérieures C prendre une bonne voie veineuse
B ventiler par intubation trachéale D mettre en place une sonde urinaire

35. Le traumatisé du bassin se plaint de : 2 réponses

A douleur vive B tuméfactions C craquement D déformation

36. Les 02 signes fonctionnels d'une lésion méniscale sont :

A douleur en rotation interne C instabilité articulaire reflexe
B claquement et sensation de déchirure D douleur provoquée à la palpation

37. La surveillance de l'état de conscience, postopératoire immédiate dans les fractures des membres, consiste à :

A vérifier la déglutition B surveiller le faciès C prendre les constantes

38. Le geste salvateur à faire auprès d'un traumatisé des voies publiques :

A l'empoignade sous les aisselles
B la précipitation
C le maintien du rachis cervical en rectitude

39. Un signe ne fait pas partie des signes physiques d'une fracture des 02 os de l'avant bras : lequel ?

A impotence fonctionnelle du membre
B raccourcissement du membre
C crépitation à la palpation

40. le bassin est constitué par les deux os iliaques réunis en avant par le sacrum et en arrière par la symphyse pubienne A / B

41. le syndrome de loge existe tant au membre supérieur qu'au membre inférieur A / B

42. A Propos de la traumatologie en général, cochez la seule bonne réponse parmi ces 03 énoncés.

A une fracture ouverte grade I au tibia impose une stabilisation par fixateur externe
B une fracture de fatigue n'intéresse qu'un os pathologique
C une fracture comminutive n'est qu'une fracture partielle, ne rompant qu'une seule corticale

43. indiquez la bonne réponse. Chez un polytraumatisé, quelles sont les lésions les plus fréquemment observées

A les lésions cervicales B les lésions orthopédiques C les lésions thoraciques

44. indiquez les 2 bonnes réponses. Le tableau clinique d'une luxation de hanche peut montrer :

A- une déformation du membre inférieur avec abduction
B. une atteinte du nerf crural
C- une atteinte du nerf sciatique
D- une impotence fonctionnelle majeure

TEST N°5 CHIRURGIE

QCD (Questions à Choix Double)

1.Le score de Glasgow chez un traumatisé du crâne qui ouvre les yeux à la douleur, émet des sons incohérentes et fait une flexion des bras à la douleur de façon anormale est :

A-8 B- 9

2.Au cours des traumatismes du thorax, une décélération, entraîne souvent un traumatisme pariétal. A / B

3.En cas d'hémothorax, l'on observe une hyper sonorité ou tympanisme. A / B

4.En cas de fracture de l'omoplate, et en absence de complication, la consolidation s'obtient en quatre à six semaines avec un cal hypertrophique inesthétique. A / B

5.Le signe de Psoas est la palpation douce du flanc gauche qui entraine une douleur controlatérale au cours des appendicites aigües. A / B

6.Le signe de l'épaulette dans les luxations de l'épaule est l'aplatissement du moignon de l'épaule, avec coup de hache externe au tiers supérieur du bras. A / B

7.Le signe du berger dans les luxations de l'épaule est l'impossibilité de l'adduction du bras car l'abduction est irréductible. A / B

8.Un trauma est une blessure ou une lésion locale produite par une violence extérieure. A / B

9.Toute hernie abdominale se caractérise par une tuméfaction dure, tendue, douloureuse, irréductible, non impulsive et non expansive à la toux. A / B

10.Les appendicites sont fréquentes chez les sujets de 10 à 30 ans et exclusivement ceux de sexe masculin. A / B

11.Les occlusions par obstruction se caractérisent par l'existence de lésions vasculaires liées à l'écrasement ou à la torsion des vaisseaux du mésentère. A / B

12.Les occlusions fonctionnelles sont consécutives à un dérèglement du système nerveux intestinal par paralysie ou des spasmes. A / B

13.La péritonite est une inflammation de la vaginale habituellement causée par une infection bactérienne. A / B

14.Le cancer de l'œsophage survient fréquemment chez l'alcoolo-tabagique, en cas d'œsophagite ou de méga-œsophage, après ingestion de produit caustique. A / B

15.En cas de cancer de l'œsophage, seul la chimiothérapie est reconnue comme pouvant entraîner une guérison.

16.Le cancer de l'estomac survient fréquemment chez le sujet de 40 et 50 ans ou plus tôt et souvent du groupe A/Rh+. A / B

17.le cancer colique se développe le plus souvent sur une séreuse colique antérieurement saine. A / B

18.Le traitement des cancers du côlon est exclusivement chirurgical. Ni la radiothérapie, ni la chimiothérapie n'ont aucune action efficace. A / B

19.Le cancer du rectum est extrêmement fréquent dans le monde occidental tant Europe qu'en Amérique. A / B

20.Une rectorragie de sang rouge ou noirâtre, accompagnant ou précédant la défécation, ou parfois indépendante est évocateur de cancer de rectum. A / B

21.La fracture de Pouteau Colle se définit comme : 2 réponses

A- Une fracture de la partie proximale du radius
B- Une fracture de la partie distale du radius
C- Une fracture de la partie proximale du cubitus
D- Une fracture de la partie distale du cubitus
E- Une fracture classique juxta-articulaire
F- Une fracture des deux os de l'avant-bras.

22.Dans les fractures des os de l'avant-bras, le syndrome de Wolkmann se caractérise par deux de ces signes : 2 réponses

A- Douleur plus ou moins vive sous plâtre
B- Anorexie
C- Cyanose du membre
D- Hyper kinésie
E- Impotence fonctionnelle
F- Asthénie physique.

23.Au cours des traumatismes crâniens, les hémorragies épidurales se caractérisent par : 2 réponses

A- Du sang d'origine veineuse
B- Du sang artériel

C- Une localisation entre la dure-mère et le cortex cérébral
D- Une absence d'intervalle libre
E- Un intervalle libre bref
F- Un intervalle libre long d'environ 15 jours.

24.Sur les lieux de l'accident, deux de ces gestes ne sont recommandés en cas de fracture du fémur, lesquels ? 2 réponses

A- Faire des manœuvres ou de mobilisations intempestives
B- Laisser le blessé couché par terre
C- Chercher à réduire une fracture ouverte
D- Préparer psychologiquement à l'intervention le blessé
E- S'abstenir d'immobiliser le membre atteint dans une gouttière ou écharpe.
F- Transfuser le client

25.Dans l'examen somatique d'un traumatisé du bassin, associez chaque observation à l'organe touché. 2 réponses

1- Le malade urine beaucoup et facilement avec des urines claires
2- Le malade urine beaucoup et facilement avec des urines sanguinolentes
3- Le malade n'urine pas du tout et présence d'un globe vésical
4- Le malade urine peu ou pas tout et absence de globe vésical.

a- Rupture vésicale et/ou urétrale
b- Aucun organe touché
c- Rupture urétrale
d-Contusion rénale probable.

A (1, b) ; C (4, b) ; E (3, a) ;
B (2, d) ; D (2, b) ; F (3, a).

26.Deux de ces éléments sont des signes observés lors de la phase primaire ou latente du choc, lesquels ? 2 réponses

A- Pouls accéléré, imprenable
B- Affaissement des veines superficielles
C- Cyanose des extrémités
D- Une pâleur extrême
E- les lésions sont irréversibles
F- Une pâleur avec refroidissement des extrémités.

27.Quels sont les buts du traitement de l'occlusion intestinale aigüe ? 3 réponses

A-Lutter contre la fièvre
B-Rétablir la continuité du circuit intestinal normal
C-Lever l'obstacle
D-Alimenter le client
E-Corriger les désordres humoraux
F-Assurer une couverture antibiotique.

28.Dans le diagnostic du siège, en cas d'occlusion colique : 2 réponses

A- Le début est brutal par une douleur très vive avec paroxysmes rapprochés
B- L'arrêt des matières et des gaz est peu net au début
C- Le ralentissement sur l'état général est rapide
D- Le début des signes est progressif, insidieux
E- La déshydratation est peu marquée et la diurèse satisfaisante
F- Le météorisme est modéré au début, son siège est plutôt central.

29.La péritonite abandonnée à elle-même aboutit au stade terminal à : 3 réponses

A- Un pouls qui devient rapide, petit et misérable
B- Une immobilité diaphragmatique à l'inspection
C- Un faciès qui se plombe de plus en plus
D- Une contracture abdominale à la palpation
E- Un faciès péritonéal
F- Une contracture faisant place à une tension marquée.

30.Les signes fonctionnels révélateurs de cancer de l'estomac sont : 2 réponses

A- La dyspepsie
B- Anorexie avec dégoût de la viande, des graisses et du tabac
C- crampes, pesanteurs ou brûlures survenant après les repas
D- Hématémèse ou méléna
E- Déshydratation
F- Hyperthermie.

31.Dans les cancers du rectum, la biopsie permet de : 2 réponses

A- Déterminer le type histologique de la tumeur
B- Déceler les lésions multiples associées du côlon
C- Visualiser la lésion
D- Délimiter de façon précise la tumeur
E- Faire la biopsie
F- Confirmer le diagnostic de cancer

32.L'adénome de la prostate se caractérise deux de ces troubles mictionnels ; lesquels ?

A- Une pollakiurie nocturne et (ou) diurne
B- Une déshydratation
C- Une pyurie
D- Une polyurie
E- Une diminution de la force et du calibre du jet
F- Un rétrécissement urétral.

33.La prise en charge infirmière dans les vingt-quatre heures qui suivent une intervention chirurgicale se résument à deux de ces propositions, lesquelles ?

A- Pratiquer le bilan préopératoire
B- Surveiller des signes vitaux et de la conscience
C- Préparer physiquement le client
D- Préparer la chambre de client
E- Vérifier la perméabilité des perfusions veineuses
F- Faire le pansement selon les habitudes du service.

34.Choisissez la ou les bonnes propositions2 réponses

A- La rétention aiguë ou complète se traduit par l'impossibilité de vider totalement la vessie.
B- La rétention aiguë ou complète se traduit par l'impossibilité brutale et totale d'uriner ou d'émettre des urines
C- La rétention chronique ou incomplète d'urine se traduit par l'impossibilité brutale et totale d'uriner ou d'émettre des urines
D- La rétention chronique ou incomplète d'urine se traduit par l'impossibilité de vider totalement la vessie.

35.En cas de cryptorchidie : 2 réponses

A- Lorsque l'abaissement du testicule peut être réalisé manuellement, on parle de testicule oscillant.
B- Lorsque l'abaissement du testicule peut être réalisé manuellement, on dit que ce testicule est ectopique
C- Lorsque la position du testicule est en dehors de l'axe de descente normale, on dit que ce testicule est ectopique.
D- Lorsque la position du testicule est en dehors de l'axe de descente normale, on parle de testicule oscillant.

36.Au cours de la cryptorchidie : 2 réponses

A- Le testicule est atrophié mais supporte la température de l'abdomen
B- La température de l'abdomen est plus élevée que celle du scrotum
C- Le testicule est susceptible de se cancériser ou entraîner la stérilité
D- Elle ne peut être associée à une hernie étranglée ou une torsion du testicule.

37.Choisissez la ou les bonnes propositions 2 réponses

A- Si le résidu post-mictionnel est inférieur à 300 cc, on parle de rétention sans distension
B- Si le résidu post-mictionnel est supérieur à 500 cc, on parle de rétention sans distension
C- Si le résidu post-mictionnel est supérieur à 300 cc, on parle de rétention avec distension
D- Si le résidu post-mictionnel est inférieur à 500 cc, on parle de rétention avec distension.

38.Choisissez la ou les bonnes propositions relatives à l'urètre masculin 2 réponses

A- L'urètre postérieur d'environ 4 cm contiennent les canaux éjaculateurs et prostatiques pour l'écoulement du sperme.
B- L'urètre antérieur ou spongieux où se trouve le sphincter urétral permet la continence.
C- L'urètre au niveau du gland pénètre dans le corps spongieux est appelé segment membraneux.
D- L'urètre antérieur où se trouve le sphincter urétral est aussi appelé urètre membraneux.

39.Un hydrocèle se définit comme :

A- Etant un épanchement liquidien séreux à l'intérieur des testicules.
B- Etant un épanchement liquidien séreux entre les deux feuillets de la vaginale.
C- Etant une saillie de viscères creux entre les deux feuillets de la vaginale.
D- Etant un épanchement liquidien purulent entre les deux feuillets de la vaginale.

40.La syndactylie est :

A- L'atrophie de la moitié interne de l'épiphyse radiale inférieure
B- L'union de deux ou plusieurs doigts ou une partie de leur longueur
C- La déviation permanente de la main sur l'avant-bras
D- Le fait que le sujet ne puisse porter la main à la bouche en gardant le coude au corps.

41.Choisissez la ou les bonnes propositions

A- Le Genu Varum est une déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambes en X)
B- Le Genu Varum est la déviation des cuisses en abduction (jambes en parenthèses)
C- Le Genu Valgum est une déviation des jambes en dehors et des genoux en dedans (jambes en X)
D- Le Genu Valgum est la déviation des cuisses en abduction (jambes en parenthèses).

42.Le Spina-Bifida est :

A- Une hernie des organes abdominaux dans la base du cordon ombilical
B- Un défaut de soudure des vertèbres lombaires
C- Une malformation régionale qui peut intéresser le rectum, l'anus, les organes génitaux et le périnée.
D- Caractérisé par l'interruption complète de la lumière intestinale.

43.L'omphalocèles est :

A- Une hernie des organes abdominaux dans la base du cordon ombilical
B- Un défaut de soudure des vertèbres lombaires
C- Une malformation régionale qui peut intéresser le rectum, l'anus, les organes génitaux et le périnée.
D- Caractérisé par l'interruption complète de la lumière intestinale.

44.Deux de ces éléments sont généralement incriminés dans l'apparition de la fente labio-palatine ou bec de lièvre. Lesquels ?

A- L'anémie C- La syphilis E- L'ascaridiose
B- La rubéole D- L'helminthiase F- L'albinisme.

45.Deux de ces méthodes font partie du traitement d'une fracture du corps du radius et du cubitus sans déplacement, lesquelles ?

A- Réduction manuelle D- Réduction chirurgicale
B- Rééducation E- Mise en place d'une plaque de compression avec des vis.
C- Application d'un plâtre le long du bras

46.Au cours du volet costal dans les traumatismes du thorax ; 2 réponses

A- L'inspiration entraine l'enfoncement du volet costal et le gonflement de la cage thoracique.
B- L'expiration entraine l'enfoncement du volet costal et le gonflement de la cage thoracique.
C- L'expiration entraine l'expulsion du volet costal et l'affaissement de la cage thoracique.
D- L'inspiration entraine l'expulsion du volet costal et l'affaissement de la cage thoracique.

47.Parmi les complications suivantes des fractures du fémur, relevez les deux immédiates :

A. L'amyotrophie du quadriceps C. Le choc hypovolémique
B. L'atteinte du nerf sciatique D. La raideur du genou.

48.Deux de ces éléments font partie des formes évolutives de l'appendicite aigue. Lesquels ?

A- Appendicite catarrhale C- Appendicite gangreneuse E- Plastron appendiculaire
B- Abcès appendiculaire D- Pyélonéphrite droite F- Appendicite phlegmoneuse.

49.Dans les omphalocèles, il existe deux (02) principaux risques. Lesquels ?

A-La rupture C- La nécrose E- L'infection
B- La desquamation D- La ligature F- La déshydratation

ETUDE DE CAS

De garde au service des grands brulés du CHU de Cocody/Abidjan, vous recevez M. TOKA, domicilié au quartier Konan Ferrand sis dans la commune de Yopougon. Sans profession fixe et pour survivre, il s'est spécialisé dans la fourniture frauduleuse d'électricité à travers les branchements anarchiques.

M. TOKA a 50 ans et mesure 1m 70 et pèse 65 Kg. Il souffre en substance de diabète notifié depuis sa dernière visite dans un centre médical.

Votre équipe de garde le reçoit pour brûlure.

L'examen physique l'interne identifie une brûlure de deuxième degré superficiel limitée au membre supérieur droit et au tronc antérieur.

Il prescrit pour sa prise en charge des solutés macromoléculaires, du bicarbonatés et du sérum glucosé isotonique. Il constate une diminution du taux d'hémoglobine à 5 g/dl de sang. Ce qui l'emmène à proposer une transfusion de sang iso groupe/iso rhésus avec pour objectif transfusionnel de 10 g/dl de sang.

50.Calculez la surface corporelle brûlée (SCB) chez M. TOKA en vous servant de la table de Lund et Browder.

A-27 B-22.5 C-18 D-36

51.Quelle est la quantité de solutés nécessaire pendant les premières 24 heures pour réanimer M. TOKA selon la règle de Baxter ?

A-2925 ml B-5850 ml C-4500 ml D-2250 ml

52.Déterminez le chiffre correspondant au pronostic vital de M.TOKA selon la loi de Baux.

A-72.5 B-87.5 C-92 D-102.5

53.Déterminez le pronostic vital du Sieur TOKA

A-La guérison est certaine C-La mort est quasi-certaine

B-Il a une chance sur deux de guérir

54.Quels sont les éléments anatomiques de la peau susceptibles d'être atteint chez M.TOKA.

A. Hypoderme C- Derme

B- Couche basale Malpighi-hypoderme D- Epiderme.

55.Calculez la quantité de bicarbonate nécessaire au deuxième jour pour la réhydratation de M.TOKA selon la règle d'Evans.

A-2925 ml B-1462,5 ml C-1096,875 ml D-365,625 ml

56.Face à l'anémie de M. TOKA, quelle est la quantité de concentré érythrocytaire qui lui est indispensable ?

A-1500 ml B-975 ml C-1950 ml D-3900 ml

57.Calculez le débit de la transfusion de M.TOKA s'il recevait du sang total en dix (10) heures et quart (15 mn)?

A-24 gouttes/mn B-48 gouttes/mn C-95 gouttes/mn D-37 gouttes/mn.

58. Identifiez deux (02) besoins fondamentaux selon VIRGINIA Henderson qui sont susceptibles d'être perturbés chez M.TOKA.

A- Besoin de pratiquer sa religion

B- Besoin de respirer

C- Besoin de maintenir sa température corporelle dans les limites de la normale

D- Besoin d'être propre et de protéger ses téguments

E- Besoin d'éviter le danger

59.Un des besoins de M.TOKA est le besoin d'éviter le danger. Parmi les diagnostics infirmiers suivants choisissez celui qui est relié à ce besoin.

A- Risque potentiel de complication relié aux plaies laissées par les phlyctènes

B- Incapacité de faire sa toilette reliée à la solution de continuité

C- Impossibilité de vaquer à ses occupations professionnelles due à son hospitalisation

60.En prenant le besoin d'être propre et protéger ses téguments, quels soins infirmiers ou activités allez- vous pratiquer pour aider M.TOKA à être propre et protéger ses téguments. Choisissez deux activités.

A- Aider à s'habiller

B- Installer le blessé selon la position requise pour son état

C- Soins d'hygiène régulière

D- Prévention d'escarres

E- Donner une alimentation riche en en fibres et en glucide.